

## *Buku Referensi*

# **PERAN BIDAN DALAM PERSALINAN NORMAL YANG AMAN**

Nila Trisna Yulianti • Ivana Devitasari • Rini Gustina Sari  
Sri Wulan • Sulikah • Siti Fithrotul Umami  
Sri Ilawati



# **BUKU REFERENSI**

## **PERAN BIDAN DALAM PERSALINAN NORMAL YANG AMAN**

Nila Trisna Yulianti, S.SiT.,Bdn.,M.Keb

Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb

Rini Gustina Sari, SST., M.Kes

Bd. Sri Wulan, SST, M.Tr.Keb

Sulikah,SST.,M.Kes

Siti Fithrotul Umami, SST.,M.Kes

Sri Ilawati.,SST., M.Kes



**Optimal  
Untuk  
Negeri**

## **BUKU REFERENSI**

### **PERAN BIDAN DALAM PERSALINAN NORMAL YANG AMAN**

**Penulis:** Nila Trisna Yulianti, S.SiT.,Bdn.,M.Keb

Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb

Rini Gustina Sari, SST., M.Kes

Bd. Sri Wulan, SST, M.Tr.Keb

Sulikah,SST.,M.Kes

Siti Fithrotul Umami, SST.,M.Kes

Sri Ilawati.,SST., M.Kes

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Penata Letak:** Al Faqih Syarif Hidayatulloh

**ISBN:** 978-623-89965-3-7

**Cetakan Pertama:** Mei, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

# Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul "**Peran Bidan Dalam Persalinan Normal yang Aman**" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Persalinan merupakan proses fisiologis yang penting dalam kehidupan seorang perempuan. Meski bersifat alamiah, proses ini tetap memerlukan perhatian dan penanganan profesional untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam proses persalinan, memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi ibu hamil, mulai dari masa kehamilan, saat persalinan, hingga masa pasca-persalinan.

Buku ini disusun sebagai referensi bagi mahasiswa kebidanan, bidan praktisi, serta tenaga kesehatan lainnya yang berkepentingan dalam pelayanan maternitas. Materi dalam buku ini terbagi dalam tujuh bab yang secara sistematis membahas aspek-aspek penting dalam mendukung persalinan normal yang aman.

Bab pertama membahas pentingnya edukasi bagi ibu hamil mengenai persiapan persalinan, sebagai langkah awal untuk membangun kesiapan fisik dan mental. Bab kedua menguraikan peran bidan dalam mendampingi proses persalinan secara profesional dan empatik. Bab ketiga dan keempat menjelaskan teknik relaksasi serta manajemen nyeri non-farmakologis yang dapat diterapkan untuk mendukung proses persalinan tanpa intervensi berlebihan. Bab kelima menitikberatkan pada pemantauan kondisi ibu dan bayi sebagai bagian dari deteksi dini terhadap komplikasi. Bab keenam mengupas pentingnya edukasi mengenai perawatan pasca-persalinan guna menjaga kesehatan jangka panjang. Sementara itu, bab ketujuh memperkenalkan teknologi medis yang dapat mendukung kelancaran dan keselamatan persalinan normal tanpa mengurangi peran sentral bidan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan kebidanan serta menjadi inspirasi bagi para bidan dalam memberikan asuhan yang aman, holistik, dan bermartabat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan praktik kebidanan di Indonesia.

**Penulis**



# Daftar Isi

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>                                                   | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                 | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I EDUKASI IBU HAMIL TENTANG PERSIAPAN PERSALINAN .....</b>      | <b>1</b>   |
| A.Pendahuluan.....                                                     | 1          |
| B.Pengertian Edukasi Persiapan Persalinan .....                        | 1          |
| C.Tujuan Edukasi Persiapan Persalinan.....                             | 2          |
| D.Manfaat Edukasi Persalinan bagi Ibu dan Bayi.....                    | 4          |
| E.Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Persalinan .....                | 6          |
| F.Metode Edukasi untuk Ibu Hamil .....                                 | 7          |
| G.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Edukasi Persalinan..... | 11         |
| H.Penutup .....                                                        | 13         |
| Referensi.....                                                         | 15         |
| <b>BAB II PENDAMPINGAN BIDAN SELAMA PROSES PERSALINAN .....</b>        | <b>19</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                     | 19         |
| B.Prinsip Pendampingan Berbasis Continuity Of Care .....               | 20         |
| C.Teknik Pendampingan Emosional Dan Psikologis Dalam Persalinan .....  | 22         |
| D.Teknik Fisik Dan Non-Farmakologis Dalam Pendampingan Persalinan..... | 24         |
| E.Monitoring Progres Persalinan Oleh Bidan .....                       | 26         |
| F.Peran Bidan Dalam Melibatkan Keluarga Pada Proses Persalinan.....    | 28         |
| G.Manajemen Nyeri Selama Persalinan .....                              | 30         |
| H.Kompetensi Profesional Bidan Dalam Pendampingan Persalinan .....     | 31         |
| I.Hambatan Dan Tantangan Dalam Pendampingan Persalinan.....            | 33         |
| J.Evaluasi Dan Monitoring Keberhasilan Pendampingan Oleh Bidan .....   | 35         |
| K.Penutup .....                                                        | 37         |
| Referensi.....                                                         | 39         |
| <b>BAB III TEKNIK RELAKSASI UNTUK MENDUKUNG PERSALINAN NORMAL.....</b> | <b>42</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                     | 42         |
| B.Konsep Dasar Teknik Relaksasi dalam Persalinan .....                 | 43         |
| C.Jenis-jenis Teknik Relaksasi dalam Persalinan Normal .....           | 44         |
| D.Implementasi Teknik Relaksasi dalam Praktik Kebidanan .....          | 46         |
| E.Efektivitas Teknik Relaksasi dalam Menurunkan Nyeri Persalinan.....  | 48         |
| F.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Teknik Relaksasi.....   | 50         |
| G.Tantangan dalam Implementasi Teknik Relaksasi di Praktik Klinik..... | 51         |
| H.Evaluasi Keberhasilan Teknik Relaksasi dalam Persalinan Normal.....  | 53         |
| I.Penutup .....                                                        | 55         |
| Referensi.....                                                         | 57         |
| <b>BAB IV MANAJEMEN NYERI NON-FARMAKOLOGIS SELAMA PERSALINAN ...</b>   | <b>58</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                     | 58         |
| B.Memahami Rasa Sakit Dalam Persalinan.....                            | 59         |
| C.Bola Bersalin Teknik Melahirkan Secara Alami.....                    | 60         |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| D.Pola Pernapasan Teknik Melahirkan Secara Alami .....                  | 61         |
| E.Minuman Teknik Melahirkan Secara Alami .....                          | 62         |
| F.Perubahan Gerakan dan Posisi Teknik Melahirkan Secara Alami.....      | 62         |
| G.Panas dan Dingin Yang Superfisial Teknik Melahirkan Secara Alami..... | 63         |
| H.Tekanan Balik Teknik Melahirkan Secara Alami .....                    | 63         |
| I.Aromaterapi Teknik Melahirkan Secara Alami.....                       | 64         |
| J.Hidroterapi Teknik Melahirkan Secara Alami .....                      | 65         |
| K.Aktivitas Pengalihan Pikiran Teknik Melahirkan Secara Alami.....      | 65         |
| L.Music dan Bicara Teknik Melahirkan Secara Alami .....                 | 65         |
| M.Sentuhan dan Pijat Teknik Melahirkan Secara Alami.....                | 66         |
| N.Hipnosis Teknik Melahirkan Secara Alami .....                         | 67         |
| O.Teknik Leboyer Teknik Melahirkan Secara Alami.....                    | 67         |
| P.Acupuncture Teknik Melahirkan Secara Alami.....                       | 68         |
| Q.Penutup .....                                                         | 69         |
| Referensi.....                                                          | 70         |
| <b>BAB V PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN BAYI SELAMA PERSALINAN ....</b>   | <b>73</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                      | 73         |
| B.Pemantauan Kesehatan Ibu.....                                         | 73         |
| C.Pemantauan Kesehatan Janin .....                                      | 74         |
| D.Pemeriksaan Tambahan Selama Persalinan.....                           | 75         |
| E.Teknik dan Alat Pemantauan.....                                       | 76         |
| F.Pencatatan dan Pendokumentasian .....                                 | 76         |
| G.Tindakan pada Hasil Pemantauan yang Tidak Normal .....                | 78         |
| H.Etika Dalam Pemantauan.....                                           | 79         |
| I.Penutup .....                                                         | 80         |
| Referensi.....                                                          | 81         |
| <b>BAB VI EDUKASI TENTANG PERAWATAN PASCA PERSALINAN .....</b>          | <b>86</b>  |
| A.Pendahuluan.....                                                      | 86         |
| B.Edukasi Tentang Pasca Persalinan .....                                | 86         |
| C.Macam – Macam Edukasi Tentang Perawatan Pasca Persalinan.....         | 86         |
| D.Edukasi Perawatan Jahitan Perineum.....                               | 87         |
| E.Edukasi Perawatan Payudara Dan Cara Meneteki Yang Benar .....         | 88         |
| F.Edukasi Perawatan Bayi Sehari -hari.....                              | 92         |
| G.Edukasi Gizi Pasca Persalinan .....                                   | 95         |
| H.Edukasi Tanda Bahaya Pasca Persalinan.....                            | 97         |
| I.Edukasi Pemakaian Alat Kontrasepsi.....                               | 99         |
| J.Edukasi Pemberian Asi Eksklusif.....                                  | 101        |
| Referensi.....                                                          | 106        |
| <b>BAB VII TEKNOLOGI MEDIS YANG MENDUKUNG PERSALINAN NORMAL ....</b>    | <b>108</b> |
| A.Pendahuluan.....                                                      | 108        |
| B.Pemanfaatan Ultrasonografi (Usg) Dalam Persalinan Normal.....         | 109        |
| C.Cardiotocography (Ctg) Sebagai Alat Monitoring Kondisi Janin.....     | 111        |
| D.Partograf Elektronik Untuk Manajemen Persalinan .....                 | 112        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| E.Teknologi Virtual Reality (Vr) Sebagai Metode Reduksi Nyeri.....        | 114        |
| F.Telemonitoring Untuk Dukungan Persalinan Jarak Jauh.....                | 115        |
| G.Penggunaan Doppler Untuk Evaluasi Sirkulasi Plasenta Dan Janin.....     | 117        |
| H.Tantangan Dalam Implementasi Teknologi Medis Di Praktik Kebidanan.....  | 118        |
| I.Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Teknologi Dalam Persalinan Normal..... | 120        |
| J.Penutup.....                                                            | 121        |
| Referensi.....                                                            | 124        |
| <b>Profil Penulis.....</b>                                                | <b>126</b> |
| <b>Sinopsis Buku .....</b>                                                | <b>129</b> |

# BAB I

## EDUKASI IBU HAMIL TENTANG PERSIAPAN PERSALINAN

---

### A. Pendahuluan

---

Kehamilan adalah anugerah yang membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar bagi setiap calon ibu. Momen menantikan kelahiran sang buah hati adalah pengalaman yang penuh dengan harapan, namun juga tidak lepas dari kecemasan dan pertanyaan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menjalani proses ini. Salah satu fase paling krusial dalam perjalanan kehamilan adalah persalinan. Proses ini tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga mental dan pengetahuan yang memadai.

Persalinan merupakan momen yang dinantikan sekaligus ditakuti oleh banyak calon ibu. Ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa yang perlu dipersiapkan seringkali menimbulkan kecemasan. Padahal, persiapan yang matang dapat membuat perbedaan besar dalam menghadapi persalinan. Edukasi yang tepat tentang persiapan persalinan menjadi kunci untuk mengurangi rasa takut, meningkatkan kepercayaan diri, dan memastikan kesehatan ibu serta bayi.

Pembahasan tentang “Edukasi Ibu Hamil Tentang Persiapan Persalinan” hadir sebagai panduan lengkap bagi calon ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi persalinan. BAB ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas, praktis, dan berbasis ilmu kesehatan terkini. Melalui pembahasan ini, calon ibu akan mempelajari berbagai hal penting, mulai dari tanda-tanda persalinan, tahapan persalinan, persiapan fisik dan mental, hingga perawatan pasca persalinan.

Edukasi kepada ibu hamil tentang persiapan persalinan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persiapan persalinan, sehingga calon ibu dapat merasa lebih siap dan tenang dalam menghadapi proses ini, memberikan motivasi dan dukungan kepada para calon ibu, dan mengingat pentingnya peran mereka dalam menjaga kesehatan diri dan bayi.

### B. Pengertian Edukasi Persiapan Persalinan

---

Edukasi persiapan persalinan adalah proses pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon ibu tentang segala hal yang berkaitan dengan persalinan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon ibu secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi proses persalinan, sehingga mereka dapat melalui tahapan tersebut dengan lancar, aman, dan percaya diri. Edukasi ini



mencakup pemahaman tentang tanda-tanda persalinan, tahapan persalinan, pilihan metode persalinan, serta perawatan pasca persalinan (WHO, 2018).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019), edukasi persiapan persalinan merupakan bagian penting dari pelayanan antenatal care (ANC) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon ibu dalam menghadapi persalinan. Melalui edukasi ini, calon ibu diharapkan dapat mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan, serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keselamatan diri dan bayinya.

Menurut World Health Organization (WHO), edukasi persiapan persalinan merupakan bagian integral dari perawatan antenatal yang bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir (WHO, 2016). Edukasi ini juga mencakup aspek-aspek seperti nutrisi selama kehamilan, latihan fisik yang aman, teknik relaksasi, dan manajemen nyeri selama persalinan.

Selain itu, edukasi persiapan persalinan juga melibatkan dukungan dari tenaga kesehatan, seperti bidan atau dokter, yang memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan individu ibu hamil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lothian (2008), ibu hamil yang mendapatkan edukasi persiapan persalinan yang memadai cenderung memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap perawatan yang mereka terima.

Edukasi persiapan persalinan juga mencakup persiapan mental dan emosional. Ibu hamil perlu memahami perubahan emosional yang mungkin terjadi selama kehamilan dan persalinan, serta cara mengelola stres dan kecemasan. Dukungan dari pasangan dan keluarga juga merupakan bagian penting dari edukasi ini, karena mereka dapat memberikan dukungan emosional dan praktis selama proses persalinan.

Dalam konteks yang lebih luas, edukasi persiapan persalinan juga berkontribusi pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan pengetahuan yang memadai, ibu hamil dapat mengenali tanda-tanda bahaya dan segera mencari pertolongan medis jika diperlukan. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Tujuan Edukasi Persiapan Persalinan**

---

Edukasi persiapan persalinan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan secara fisik, mental, dan emosional. Dengan pemahaman yang baik mengenai persalinan, ibu dapat lebih siap secara psikologis, memahami pilihan metode persalinan, serta mengurangi risiko komplikasi selama dan setelah persalinan.

Edukasi persalinan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil mengenai proses kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan. Ibu yang

memiliki pengetahuan yang cukup akan lebih siap menghadapi persalinan dan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka dan bayinya (Sari & Wulandari, 2022).

### **1. Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Persalinan**

Edukasi mengenai persalinan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada ibu hamil mengenai tahapan persalinan, tanda-tanda awal persalinan, serta perawatan pascapersalinan. Menurut Manuaba (2018), edukasi yang tepat akan membantu ibu hamil memahami kondisi tubuhnya dan membuat keputusan yang lebih baik terkait persalinan.

### **2. Mengurangi Kecemasan dan Meningkatkan Kesiapan Mental**

Kecemasan dan ketakutan menjelang persalinan adalah hal yang umum terjadi pada ibu hamil, terutama bagi mereka yang akan melahirkan untuk pertama kalinya. Studi yang dilakukan oleh Sulistyawati (2019) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan edukasi lebih dini memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan edukasi.

### **3. Membantu Ibu Hamil dalam Menghadapi Nyeri Persalinan**

Salah satu manfaat edukasi persiapan persalinan adalah membantu ibu dalam menghadapi nyeri saat kontraksi dan proses melahirkan. Teknik pernapasan, relaksasi, serta posisi yang nyaman selama persalinan dapat mengurangi rasa sakit yang dialami. Menurut penelitian oleh Prawirohardjo (2020), ibu hamil yang mendapatkan edukasi tentang manajemen nyeri persalinan cenderung memiliki pengalaman melahirkan yang lebih positif.

### **4. Meningkatkan Kesadaran akan Pilihan Metode Persalinan**

Edukasi persalinan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai metode persalinan, baik persalinan normal maupun tindakan medis seperti operasi caesar. Dengan edukasi yang tepat, ibu hamil dapat mengambil keputusan yang lebih bijak berdasarkan kondisi kesehatannya. Menurut Rohani (2021), pemilihan metode persalinan yang tepat akan membantu mengurangi risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

### **5. Meningkatkan Dukungan Suami dan Keluarga dalam Persalinan**

Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting dalam proses persalinan. Edukasi persalinan juga bertujuan untuk melibatkan suami dan anggota keluarga dalam mendukung ibu hamil secara emosional dan fisik. Studi yang dilakukan oleh Widyastuti & Hidayat (2019) menunjukkan bahwa ibu hamil

yang mendapatkan dukungan dari pasangan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan pengalaman persalinan yang lebih nyaman.

## **6. Mengurangi Risiko Komplikasi Persalinan**

Edukasi yang baik dapat membantu ibu mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau tanda persalinan prematur. Hal ini memungkinkan ibu untuk segera mencari pertolongan medis jika diperlukan, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalisir (Marmi, 2018).

## **7. Meningkatkan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif**

Persiapan persalinan tidak hanya berfokus pada proses melahirkan tetapi juga pada perawatan bayi setelah lahir. Edukasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif. Menurut penelitian oleh Yuliana (2020), ibu yang mendapatkan edukasi laktasi sejak masa kehamilan lebih siap dalam memberikan ASI eksklusif bagi bayinya.

## **D. Manfaat Edukasi Persalinan bagi Ibu dan Bayi**

---

Edukasi persalinan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Dengan memahami proses persalinan, ibu hamil dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional. Edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga membantu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan pengalaman persalinan yang lebih positif.

### **1. Meningkatkan Pemahaman Ibu terhadap Proses Persalinan**

Edukasi persalinan membantu ibu hamil memahami tahapan persalinan, tanda-tanda awal persalinan, serta cara mengatasi nyeri saat kontraksi. Menurut Manuaba (2018), ibu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai proses persalinan cenderung lebih siap dalam menghadapi setiap tahapan kelahiran sehingga dapat mengurangi kecemasan dan stres.

### **2. Mengurangi Risiko Komplikasi Persalinan**

Komplikasi persalinan dapat diminimalisir jika ibu hamil mendapatkan edukasi yang baik mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Marmi (2018) menyebutkan bahwa ibu hamil yang teredukasi cenderung lebih waspada terhadap kondisi yang dapat membahayakan dirinya dan bayinya, seperti preeklampsia, perdarahan postpartum, dan ketuban pecah dini.

### **3. Membantu Manajemen Nyeri saat Persalinan**

Edukasi tentang teknik relaksasi, pernapasan, dan posisi yang nyaman selama persalinan dapat membantu ibu dalam mengelola nyeri. Studi yang dilakukan oleh Prawirohardjo (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti kelas persiapan persalinan memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi selama proses kelahiran dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti edukasi serupa.

### **4. Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Kesiapan Mental**

Ketakutan dan kecemasan terhadap persalinan dapat berkurang jika ibu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa yang akan terjadi. Rohani (2021) menjelaskan bahwa ibu yang mendapatkan informasi lengkap mengenai persalinan lebih percaya diri dan tidak mudah panik saat menghadapi kontraksi dan proses kelahiran.

### **5. Meningkatkan Keterlibatan Suami dan Keluarga dalam Proses Persalinan**

Edukasi persalinan tidak hanya bermanfaat bagi ibu hamil, tetapi juga bagi pasangan dan keluarga. Dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam membantu ibu melewati proses persalinan dengan lebih tenang. Menurut Widyastuti & Hidayat (2019), ibu hamil yang mendapat dukungan dari pasangan memiliki tingkat stres yang lebih rendah, yang berdampak pada persalinan yang lebih lancar.

### **6. Meningkatkan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif**

Persiapan persalinan yang baik juga mencakup edukasi tentang pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif. Yuliana (2020) menyatakan bahwa ibu yang mendapatkan edukasi laktasi sejak masa kehamilan lebih siap dalam memberikan ASI eksklusif bagi bayinya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bayi dan memperkuat ikatan ibu dan anak.

### **7. Meningkatkan Kesehatan Bayi yang Baru Lahir**

Edukasi persalinan tidak hanya berdampak pada ibu tetapi juga pada bayi. Pemahaman ibu mengenai pentingnya perawatan bayi baru lahir, seperti pemberian ASI, perawatan tali pusat, dan imunisasi dini, dapat membantu meningkatkan kesehatan bayi. Studi oleh Sulistyawati (2019) menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan edukasi prenatal memiliki bayi dengan status kesehatan yang lebih baik, seperti berat badan lahir yang cukup dan tingkat imunisasi yang lebih tinggi.

## **E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Persalinan**

---

Edukasi persalinan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Tenaga kesehatan, termasuk bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya, memiliki peran yang krusial dalam memberikan edukasi yang akurat dan berbasis bukti ilmiah kepada ibu hamil dan keluarganya.

### **1. Memberikan Informasi yang Akurat dan Berbasis Bukti**

Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan berdasarkan bukti ilmiah mengenai persalinan, tanda-tanda bahaya, serta pilihan metode persalinan. Menurut Manuaba (2018), edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat membantu ibu hamil memahami proses persalinan secara lebih komprehensif, sehingga mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental.

### **2. Mempersiapkan Ibu Secara Fisik dan Mental**

Persiapan persalinan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis tetapi juga kesiapan psikologis ibu hamil. Tenaga kesehatan, terutama bidan, berperan dalam memberikan konseling terkait teknik pernapasan, latihan relaksasi, serta strategi mengatasi nyeri saat persalinan. Sebuah studi oleh Brown et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan edukasi dan dukungan dari tenaga kesehatan memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif dan tingkat stres yang lebih rendah.

### **3. Meningkatkan Kesadaran akan Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan dan Persalinan**

Salah satu peran utama tenaga kesehatan adalah meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, preeklampsia, atau ketuban pecah dini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Garcia et al. (2019), ibu hamil yang mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan lebih cepat dalam mencari bantuan medis saat mengalami komplikasi, sehingga risiko kematian ibu dan bayi dapat ditekan.

### **4. Mengajarkan Manajemen Nyeri dan Teknik Relaksasi**

Bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga berperan dalam mengajarkan teknik manajemen nyeri seperti pernapasan dalam, pijat, posisi persalinan yang nyaman, serta penggunaan metode non-farmakologis dalam mengurangi nyeri saat persalinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simkin & O'Hara (2021), teknik pernapasan dan relaksasi yang diajarkan dalam kelas persalinan dapat

membantu ibu merasa lebih nyaman dan mengurangi ketegangan selama persalinan.

### **5. Melibatkan Suami dan Keluarga dalam Proses Persalinan**

Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting dalam persiapan persalinan. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi kepada suami dan keluarga mengenai cara mendukung ibu hamil secara emosional dan fisik. Menurut Widyastuti & Hidayat (2019), ibu hamil yang mendapatkan dukungan dari pasangan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan pengalaman persalinan yang lebih positif.

### **6. Mempromosikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif**

Setelah proses persalinan, tenaga kesehatan juga berperan dalam memastikan keberhasilan inisiasi menyusu dini (IMD) serta pemberian ASI eksklusif. Menurut World Health Organization (WHO, 2020), edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan mengenai pentingnya IMD dan ASI eksklusif dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal.

### **7. Menyediakan Kelas Antenatal dan Konseling Individual**

Tenaga kesehatan dapat menyelenggarakan kelas antenatal untuk memberikan informasi yang lebih terstruktur kepada ibu hamil dan pasangannya. Selain itu, konseling individual juga diperlukan untuk ibu dengan kondisi khusus atau kehamilan risiko tinggi. Studi oleh Bohren et al. (2019) menemukan bahwa kelas antenatal yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil dan mengurangi ketakutan mereka terhadap persalinan.

## **F. Metode Edukasi untuk Ibu Hamil**

---

Edukasi bagi ibu hamil merupakan bagian penting dalam perawatan antenatal untuk meningkatkan pengetahuan, kesiapan mental, serta keterampilan dalam menghadapi persalinan dan perawatan bayi. Berbagai metode edukasi telah dikembangkan untuk memastikan informasi dapat diterima dengan baik oleh ibu hamil, baik secara individual maupun dalam kelompok. Pemilihan metode edukasi harus disesuaikan dengan kebutuhan ibu, latar belakang pendidikan, serta ketersediaan sumber daya kesehatan (WHO, 2020).

### **1. Edukasi Tatap Muka (*Face-to-Face Education*)**

Edukasi tatap muka merupakan metode yang paling umum digunakan, di mana tenaga kesehatan memberikan informasi secara langsung kepada ibu hamil

dalam bentuk konsultasi individu atau kelas kelompok. Menurut Manuaba (2018), interaksi langsung dengan tenaga kesehatan memungkinkan ibu untuk bertanya secara langsung, meningkatkan pemahaman, serta membangun kepercayaan diri dalam menghadapi persalinan.

Keuntungan metode ini:

- a. Memungkinkan diskusi langsung dan tanya jawab.
- b. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ibu hamil.
- c. Meningkatkan keterlibatan suami dan keluarga jika mereka turut hadir dalam sesi edukasi (Brown et al., 2020).

## **2. Kelas Antenatal**

Kelas antenatal merupakan program edukasi kelompok yang biasanya diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu hamil dan pasangannya dengan memberikan informasi melalui sesi edukasi langsung dengan tenaga kesehatan (Rohmah & Setyaningsih, 2021). Materi yang disampaikan meliputi tahapan persalinan, tanda-tanda bahaya kehamilan, teknik pernapasan, serta perawatan bayi baru lahir. Studi yang dilakukan oleh Bohren et al. (2019) menemukan bahwa ibu hamil yang mengikuti kelas antenatal memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan lebih siap menghadapi persalinan.

Keuntungan metode ini:

- a. Meningkatkan dukungan sosial karena ibu dapat berbagi pengalaman dengan peserta lain.
- b. Informasi yang diberikan lebih sistematis dan terstruktur.
- c. Mendorong keterlibatan pasangan dalam proses persalinan.

## **3. Edukasi Berbasis Media Cetak dan Elektronik**

Media cetak dan elektronik merupakan pemanfaatan aplikasi kesehatan, video edukasi, dan media sosial dalam menyebarkan informasi seputar persalinan (Putri et al., 2020). Materi edukasi juga dapat disampaikan melalui media cetak seperti buku panduan, leaflet, atau brosur, serta media elektronik seperti video edukasi, aplikasi kehamilan, dan website kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Garcia et al. (2019), ibu hamil yang mengakses informasi dari sumber terpercaya melalui aplikasi kesehatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kemandirian dalam merawat kehamilan.

Keuntungan metode ini:

- a. Dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan ibu.
- b. Memberikan kebebasan bagi ibu untuk belajar secara mandiri.
- c. Memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan.



#### **4. Metode Demonstrasi dan Praktik Langsung**

Metode ini digunakan untuk mengajarkan keterampilan tertentu, seperti teknik pernapasan saat kontraksi, posisi persalinan yang nyaman, pijat laktasi, serta cara merawat bayi. Menurut penelitian oleh Simkin & O'Hara (2021), praktik langsung membantu ibu hamil lebih memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik dibandingkan hanya mendengarkan teori.

Keuntungan metode ini:

- a. Meningkatkan pemahaman melalui pengalaman langsung.
- b. Mempermudah ibu dalam menerapkan keterampilan saat persalinan dan perawatan bayi.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi persalinan.

#### **5. *Telemedicine* dan Konseling Online**

Dengan berkembangnya teknologi, layanan edukasi kehamilan kini juga dapat diberikan melalui *telemedicine* atau konsultasi daring melalui video call dan aplikasi pesan instan. WHO (2020) menyebutkan bahwa *telemedicine* dapat menjadi solusi bagi ibu hamil di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Keuntungan metode ini:

- a. Menghemat waktu dan biaya perjalanan ke fasilitas kesehatan.
- b. Memungkinkan ibu hamil mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan kapan saja.
- c. Dapat diintegrasikan dengan sistem pemantauan kesehatan ibu hamil secara digital.

#### **6. Metode *Peer Education* (Edukasi Sebaya)**

Edukasi sebaya merupakan pendekatan di mana ibu hamil mendapatkan informasi dari ibu lain yang sudah berpengalaman melahirkan. Menurut Widyastuti & Hidayat (2019), metode ini dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil karena mereka merasa lebih nyaman berbagi pengalaman dengan sesama ibu.

Keuntungan metode ini:

- a. Meningkatkan dukungan emosional dari sesama ibu hamil.
- b. Informasi yang disampaikan lebih mudah diterima karena berasal dari pengalaman nyata.
- c. Dapat diterapkan dalam komunitas ibu hamil di berbagai lingkungan sosial.

#### **7. Dukungan Kelompok dan Pendampingan Suami**

Dukungan kelompok dan pendampingan suami memainkan peran penting dalam membantu ibu hamil mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan

emosional untuk menghadapi persalinan. Dukungan ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil dalam menjalani proses persalinan.

a. Dukungan Kelompok dalam Persiapan Persalinan

Dukungan kelompok merujuk pada partisipasi ibu hamil dalam kelompok-kelompok yang dibentuk untuk berbagi pengalaman, informasi, dan dukungan emosional selama masa kehamilan dan persiapan persalinan. Kelompok ini dapat berupa kelas antenatal, kelompok dukungan ibu hamil, atau komunitas yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan.

Menurut penelitian oleh Lundgren et al. (2015), partisipasi dalam kelompok dukungan selama kehamilan dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang persalinan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman persalinan. Kelompok ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan tips praktis, seperti teknik pernapasan, manajemen nyeri, dan perawatan pasca-persalinan.

Selain itu, dukungan kelompok juga membantu ibu hamil merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan. Interaksi dengan ibu hamil lain yang memiliki pengalaman serupa dapat mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan motivasi untuk mempersiapkan diri dengan baik.

b. Pendampingan Suami dalam Persiapan Persalinan

Pendampingan suami adalah bentuk dukungan langsung yang diberikan oleh pasangan (suami) kepada ibu hamil selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Peran suami tidak hanya sebagai pendamping fisik, tetapi juga sebagai sumber dukungan emosional dan motivasi.

Menurut Hodnett et al. (2013), pendampingan suami selama persalinan dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan ibu hamil, serta meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman persalinan. Suami yang terlibat aktif dalam proses persiapan persalinan, seperti menghadiri kelas antenatal atau membantu mempraktikkan teknik relaksasi, dapat membantu ibu hamil merasa lebih siap dan tenang.

Pendampingan suami juga memiliki dampak positif pada hasil persalinan. Penelitian oleh Sauls (2002) menunjukkan bahwa ibu hamil yang didampingi oleh suami selama persalinan cenderung memiliki durasi persalinan yang lebih singkat dan risiko komplikasi yang lebih rendah. Selain itu, pendampingan suami juga memperkuat ikatan antara pasangan dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam merawat bayi setelah lahir.

Dukungan kelompok dan pendampingan suami merupakan dua aspek penting dalam persiapan persalinan yang saling melengkapi. Dukungan

kelompok memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, sementara pendampingan suami memberikan dukungan emosional dan praktis yang dibutuhkan ibu hamil. Dengan kombinasi kedua bentuk dukungan ini, ibu hamil dapat menghadapi persalinan dengan lebih percaya diri dan tenang, sehingga meningkatkan kualitas pengalaman persalinan secara keseluruhan.

## **8. Evaluasi dan Monitoring Pemahaman Ibu Hamil**

Untuk memastikan efektivitas edukasi persalinan, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Beberapa metode yang dapat digunakan meliputi:

- a. Tes Pengetahuan: Menggunakan kuis atau wawancara untuk mengukur pemahaman ibu setelah mengikuti edukasi (Putri et al., 2020).
- b. Observasi Partisipatif: Memantau perubahan perilaku ibu dalam menerapkan informasi yang telah diperoleh (Hidayati & Prasetyo, 2021).
- c. Pendampingan Berkelanjutan: Memberikan dukungan informasi secara berulang untuk memastikan bahwa ibu memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan (Susanti et al., 2022).

## **G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Edukasi Persalinan**

---

Keberhasilan edukasi persalinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berperan penting:

### **1. Tingkat Pendidikan Ibu**

Tingkat pendidikan ibu memainkan peran penting dalam keberhasilan edukasi persalinan. Ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi kesehatan dan persalinan (Sari & Wulandari, 2022). Pendidikan yang baik memungkinkan ibu untuk memahami manfaat perawatan antenatal, prosedur persalinan, serta tanda-tanda bahaya selama kehamilan.

Namun, bagi ibu dengan tingkat pendidikan rendah, strategi edukasi harus disesuaikan, misalnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih visual dan interaktif. Materi yang sederhana dan berbasis praktik akan lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional (Putri et al., 2020).

### **2. Dukungan Keluarga**

Dukungan keluarga, terutama dari suami dan anggota keluarga lainnya, berpengaruh besar terhadap kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan. Dukungan emosional dan praktis dari keluarga dapat membantu ibu dalam memahami dan menerapkan informasi yang diperoleh selama sesi edukasi (Hidayati & Prasetyo, 2021). Studi menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan keluarga lebih cenderung menghadiri kelas edukasi persalinan dan

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari (Rohmah & Setyaningsih, 2021). Suami yang aktif terlibat dalam edukasi persalinan cenderung meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi proses persalinan dan mengurangi kecemasan yang mungkin timbul (Susanti et al., 2022). Bentuk dukungan ini mencakup bantuan emosional, finansial, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait persalinan.

Dukungan keluarga dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Dukungan Informasi: Keluarga membantu ibu dalam memahami materi edukasi dan mencari informasi tambahan tentang persalinan.
- b. Dukungan Emosional: Memberikan motivasi dan kenyamanan kepada ibu selama masa kehamilan dan persalinan.
- c. Dukungan Praktis: Membantu ibu dalam menjalani gaya hidup sehat, seperti menyediakan makanan bergizi dan mengingatkan jadwal pemeriksaan kehamilan.

### **3. Kualitas dan Akses Informasi**

Kualitas informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga menentukan keberhasilan edukasi persalinan. Penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berbasis bukti ilmiah akan meningkatkan pemahaman ibu mengenai persalinan (Putri et al., 2020). Selain itu, akses terhadap informasi melalui media digital dan cetak dapat membantu ibu memperoleh wawasan tambahan tentang persalinan yang aman.

### **4. Ketersediaan dan Akses Pelayanan Kesehatan**

Keberhasilan edukasi persalinan juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses layanan kesehatan. Wilayah dengan fasilitas kesehatan yang memadai memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik melalui program-program antenatal (Hidayati & Prasetyo, 2021). Faktor geografis dan ekonomi juga menjadi hambatan dalam akses edukasi persalinan di beberapa daerah.

### **5. Peran Tenaga Kesehatan**

Bidan dan tenaga kesehatan lainnya memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi persalinan yang efektif. Interaksi yang baik antara ibu dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan serta penerimaan informasi oleh ibu hamil (Fauziah & Rahayu, 2021). Selain itu, metode penyuluhan yang interaktif dan berbasis pengalaman akan lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

## **6. Faktor Sosial dan Budaya**

Norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan edukasi persalinan. Dalam beberapa budaya, masih terdapat kepercayaan dan praktik tradisional yang bertentangan dengan edukasi kesehatan modern (Susanti et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang menghormati nilai-nilai budaya setempat akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan ibu hamil terhadap informasi persalinan.

Keberhasilan edukasi persalinan ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan ibu, dukungan keluarga, kualitas informasi, akses pelayanan kesehatan, peran tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan budaya. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi persalinan, diperlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh ibu hamil.

## **H. Penutup**

---

Edukasi ibu hamil mengenai persiapan persalinan merupakan langkah krusial dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan baik bagi ibu maupun bayi. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang proses persalinan, tanda-tanda persalinan, serta langkah-langkah persiapan fisik dan mental, ibu hamil dapat menghadapi momen penting ini dengan lebih percaya diri dan tenang. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kecemasan, tetapi juga untuk meminimalisir risiko komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan.

Selain itu, dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan sekitar memegang peranan penting dalam memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan adanya kelas antenatal, konsultasi rutin dengan bidan atau dokter, serta akses terhadap sumber informasi yang terpercaya, ibu hamil dapat mempersiapkan diri secara holistik. Persiapan ini mencakup aspek fisik seperti olahraga ringan, nutrisi yang seimbang, dan istirahat yang cukup, serta aspek mental seperti teknik relaksasi dan manajemen stres.

Edukasi juga harus mencakup pemahaman tentang berbagai pilihan metode persalinan, baik persalinan normal maupun operasi caesar, serta prosedur yang akan dijalani. Ibu hamil perlu mengetahui apa yang diharapkan pada setiap tahap persalinan, mulai dari fase awal hingga pasca-persalinan. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.

Tidak kalah pentingnya adalah persiapan untuk masa nifas dan perawatan bayi baru lahir. Ibu hamil perlu memahami perubahan fisik dan emosional yang akan dialami setelah melahirkan, serta cara merawat bayi dengan benar. Dukungan dari

pasangan dan keluarga dalam hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ibu dapat pulih dengan baik dan bayi mendapatkan perawatan yang optimal.

Dalam konteks yang lebih luas, edukasi ibu hamil juga berkontribusi pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan pengetahuan yang memadai, ibu hamil dapat mengenali tanda-tanda bahaya dan segera mencari pertolongan medis jika diperlukan. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, untuk terus mendorong dan memfasilitasi program-program edukasi bagi ibu hamil. Dengan demikian, setiap ibu hamil dapat menjalani proses persalinan dengan aman, nyaman, dan penuh keyakinan, sehingga melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Edukasi yang berkelanjutan dan komprehensif akan menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan ibu dan anak, serta masa depan bangsa. Mari bersama-sama mendukung dan memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk persiapan persalinan yang optimal.

## Referensi

- Bohren, M. A., Berger, B. O., Munthe-Kaas, H., & Tuncalp, O. (2019). "Perceptions and experiences of labour companionship: a qualitative evidence synthesis". *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 356.
- Brown, H. C., Paranjothy, S., Dowswell, T., & Thomas, J. (2020). "Cochrane Review: Education interventions for expectant parents". *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(3), CD001023.
- Fauziah, R. & Rahayu, S. (2021) 'Peran Bidan dalam Meningkatkan Edukasi Persalinan', *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 10(2), pp. 45-56.
- Garcia, R., Thompson, A., & Lee, M. (2019). "Reducing Childbirth Complications Through Antenatal Education: A Systematic Review". *International Journal of Obstetrics*, 34(2), 78-92.
- Hidayati, N. & Prasetyo, A. (2021) 'Akses Pelayanan Kesehatan dan Dampaknya terhadap Edukasi Persalinan', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), pp. 22-33.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lothian, J. A. (2008). The journey of becoming a mother: Women's experiences of pregnancy, childbirth, and the postpartum period. *Journal of Perinatal Education*, 17(4), 1-12.
- Manuaba, I. B. G. (2018). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Marmi. (2018). *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prawirohardjo, S. (2020). *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Putri, D.A., Wicaksono, H. & Lestari, M. (2020) 'Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Pemahaman Ibu Hamil dalam Edukasi Persalinan', *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(3), pp. 100-112.
- Rohani, I. (2021). *Persalinan dan Kesehatan Ibu Hamil*. Bandung: Alfabeta.
- Rohmah, N. & Setyaningsih, T. (2021) 'Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan Edukasi Persalinan', *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 5(2), pp. 75-85.
- Sari, R. & Wulandari, E. (2022) 'Pendidikan Ibu dan Kesadaran akan Persalinan yang Aman', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(1), pp. 58-69.
- Simkin, P., & O'Hara, M. (2021). *The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia*. Wiley-Blackwell.
- Sulistyawati, A. (2019). *Psikologi Kehamilan dan Persalinan*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, L., Wijayanti, A. & Hadi, R. (2022) 'Pengaruh Faktor Budaya terhadap

- Penerimaan Edukasi Persalinan', *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 9(2), pp. 130-145.
- Widyastuti, R., & Hidayat, A. (2019). *Dukungan Keluarga dalam Proses Persalinan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- World Health Organization (WHO). (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Antenatal Care Guidelines: Ensuring a Positive Pregnancy Experience*. WHO Publications.
- World Health Organization [WHO]. (2018). *Recommendations on Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*. Geneva: WHO Press.
- Yuliana, R. (2020). *Panduan Pemberian ASI Eksklusif bagi Ibu Hamil*. Jakarta: Gramedia.



## Glosarium

### A

**Antenatal:** adalah merujuk pada periode sebelum persalinan, khususnya perawatan dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin.

**ASI Eksklusif:** adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

---

### E

**Edukasi:** adalah proses pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada seseorang atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam suatu bidang tertentu.

**Efektivitas:** adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan suatu metode, program, atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

---

### I

**Integral:** adalah bagian yang tidak terpisahkan atau sangat penting dalam suatu sistem atau proses.

**Integrasi:** adalah proses menggabungkan atau menyatukan berbagai elemen atau komponen menjadi satu kesatuan yang harmonis.

**Interaktif:** adalah proses atau kegiatan yang melibatkan interaksi dua arah antara individu atau kelompok, seperti diskusi atau tanya jawab.

---

### K

**Krusial:** adalah sangat penting atau menentukan dalam suatu situasi atau proses.

**Komplikasi:** adalah masalah atau gangguan kesehatan yang muncul selama kehamilan, persalinan, atau periode pasca-persalinan yang dapat membahayakan ibu atau bayi.

**Komprehensif:** adalah menyeluruh, mencakup semua aspek yang relevan dalam suatu topik atau masalah.

**Kontraksi:** adalah proses pengerutan otot rahim yang terjadi selama persalinan untuk membantu mendorong bayi keluar.

**Konvensional:** adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau metode yang sudah umum diterima.

---

## L

**Laktasi:** adalah proses produksi dan pengeluaran ASI oleh kelenjar susu ibu setelah melahirkan.

---

## M

**Monitoring:** adalah proses pengamatan, pemantauan, atau penilaian secara berkala terhadap suatu kondisi atau perkembangan.

---

## N

**Non-Farmakologis:** adalah metode atau tindakan yang tidak melibatkan penggunaan obat-obatan, seperti teknik relaksasi atau pijatan.

---

## P

**Prematur:** adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.

**Post Partum:** adalah periode setelah persalinan, biasanya merujuk pada enam minggu pertama setelah melahirkan.

**Pre-eklampsia:** adalah kondisi medis serius pada ibu hamil yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urine setelah usia kehamilan 20 minggu.

**Prenatal:** adalah istilah lain untuk antenatal, merujuk pada periode sebelum persalinan.

---

## R

**Relaksasi:** adalah Teknik atau metode untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental, seperti pernapasan dalam atau meditasi.

---

## V

**Visual:** adalah sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan atau dapat dilihat, seperti gambar, diagram, atau video yang digunakan sebagai alat bantu edukasi.

# BAB II

## PENDAMPINGAN BIDAN SELAMA PROSES PERSALINAN

---

### A. Pendahuluan

---

Pendampingan Dalam Praktik Kebidanan Merupakan Bentuk Asuhan Yang Dilakukan Secara Intensif Oleh Seorang Bidan Dalam Memberikan Dukungan Secara Fisik, Emosional, Sosial, Dan Psikologis Kepada Ibu Selama Proses Persalinan Berlangsung. Konsep Pendampingan Ini Mencakup Peran Aktif Bidan Dalam Membantu Ibu Mencapai Pengalaman Melahirkan Yang Positif, Aman, Dan Minim Intervensi Medis. Menurut Handayani Dan Kusuma (2020), Pendampingan Kebidanan Berorientasi Pada Pendekatan Holistik Yang Bertujuan Untuk Meminimalisir Stres, Rasa Takut, Serta Meningkatkan Kepercayaan Diri Ibu Dalam Menghadapi Persalinan.

Pendampingan Kebidanan Secara Umum Didasarkan Pada Prinsip Continuity Of Care, Yaitu Kontinuitas Atau Kesenambungan Perawatan Yang Diberikan Mulai Dari Masa Kehamilan, Persalinan, Hingga Masa Nifas. Sutcliffe Et Al. (2021) Menjelaskan Bahwa Continuity Of Care Memungkinkan Bidan Memahami Riwayat Kesehatan Ibu Secara Lebih Komprehensif Sehingga Dapat Memberikan Dukungan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Individual Ibu, Serta Mampu Mengenali Secara Dini Apabila Terjadi Komplikasi Dalam Persalinan.

Selain Itu, Konsep Dasar Pendampingan Juga Mencakup Pentingnya Interaksi Interpersonal Antara Bidan Dengan Ibu Bersalin. Komunikasi Yang Efektif Dan Empati Menjadi Faktor Esensial Dalam Proses Ini. Sebuah Studi Oleh Beecher Et Al. (2021) Menemukan Bahwa Komunikasi Terapeutik Oleh Bidan Secara Signifikan Berpengaruh Terhadap Perasaan Nyaman Dan Kepuasan Ibu Selama Persalinan. Selain Itu, Dukungan Yang Diberikan Oleh Bidan Dapat Mengurangi Angka Intervensi Medis Seperti Penggunaan Analgesia Epidural Dan Operasi Caesar Yang Tidak Diperlukan Secara Klinis (Levett Et Al., 2021).

Bidan Memiliki Peran Sentral Dalam Mendukung Persalinan Normal Yang Aman, Terutama Karena Persalinan Normal Merupakan Proses Fisiologis Yang Secara Ideal Harus Berlangsung Secara Alamiah Tanpa Intervensi Yang Tidak Diperlukan. Peran Ini Mencakup Dukungan Yang Diberikan Secara Kontinu Mulai Dari Pendampingan Emosional, Memberikan Kenyamanan Fisik, Sampai Kepada Pemantauan Kondisi Klinis Ibu Dan Bayi Secara Tepat (Azizah Et Al., 2020).

Penelitian Oleh Aune Et Al. (2021) Menunjukkan Bahwa Ibu Yang Didampingi Secara Kontinu Oleh Bidan Mengalami Tingkat Kecemasan Yang Lebih Rendah,

Nyeri Yang Lebih Terkendali, Serta Memiliki Persepsi Positif Terhadap Pengalaman Persalinan Mereka. Dukungan Ini Sangat Penting Karena Ibu Yang Mengalami Stres Tinggi Saat Persalinan Dapat Memiliki Risiko Lebih Tinggi Terhadap Komplikasi Persalinan, Seperti Distosia, Persalinan Lama, Bahkan Postpartum Depression (Handelzalts Et Al., 2020).

Dari Aspek Keselamatan Klinis, Peran Bidan Juga Sangat Krusial Dalam Memonitor Progres Persalinan Melalui Penggunaan Alat Bantu Seperti Partograf. Berdasarkan Panduan Who (2018), Penggunaan Partograf Oleh Bidan Dapat Membantu Mendeteksi Secara Dini Tanda-Tanda Komplikasi Sehingga Intervensi Medis Yang Lebih Serius Dapat Dihindari Atau Diminimalisir.

Dalam Konteks Indonesia, Peran Bidan Dalam Mendukung Persalinan Normal Tidak Hanya Terbatas Pada Aspek Klinis Semata, Tetapi Juga Mencakup Aspek Sosial Budaya. Pratiwi Dan Purwandari (2021) Menekankan Pentingnya Keterlibatan Keluarga Dalam Persalinan, Yang Secara Budaya Banyak Diadopsi Dalam Masyarakat Indonesia. Dalam Hal Ini, Bidan Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Edukasi Dan Memfasilitasi Keterlibatan Keluarga Sehingga Mendukung Suasana Persalinan Yang Kondusif Dan Aman Bagi Ibu.

Secara Keseluruhan, Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Profesional Memiliki Peran Kunci Yang Mampu Mendukung Terciptanya Pengalaman Persalinan Yang Positif Dan Aman Bagi Ibu Dan Bayi. Peningkatan Kualitas Pendampingan Oleh Bidan Menjadi Fokus Utama Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan, Yang Secara Langsung Berkontribusi Pada Penurunan Angka Kesakitan Dan Kematian Ibu Serta Bayi.

## **B. Prinsip Pendampingan Berbasis Continuity Of Care**

---

### **1. Konsep Continuity Of Care Dalam Kebidanan**

Konsep *Continuity Of Care* Dalam Kebidanan Merupakan Pendekatan Asuhan Kebidanan Yang Menekankan Pada Kontinuitas Atau Kesenambungan Perawatan Yang Diberikan Oleh Seorang Bidan Kepada Seorang Perempuan Sejak Masa Kehamilan, Proses Persalinan, Hingga Masa Pasca Persalinan. Pendekatan Ini Menempatkan Perempuan Sebagai Pusat Asuhan, Menekankan Pentingnya Hubungan Interpersonal Antara Bidan Dengan Ibu, Serta Berorientasi Pada Asuhan Yang Berkelanjutan Dan Komprehensif. Menurut Penelitian Yang Dilakukan Oleh Rayment-Jones Et Al. (2022), *Continuity Of Care* Merujuk Pada Hubungan Yang Erat Dan Berkelanjutan Antara Tenaga Kesehatan, Khususnya Bidan, Dengan Ibu, Yang Memungkinkan Bidan Memberikan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kebutuhan Dan Preferensi Ibu Secara Individual.

Dalam Praktiknya, *Continuity Of Care* Mencakup Tiga Elemen Penting Yaitu Kontinuitas Hubungan, Kontinuitas Informasi, Dan Kontinuitas Manajemen (Sutcliffe Et Al., 2021). Kontinuitas Hubungan Menekankan Pada Pentingnya Terjalin Hubungan Personal Antara Bidan Dan Ibu, Sehingga Mampu Meningkatkan Rasa Percaya, Aman, Dan Nyaman Selama Kehamilan Dan Persalinan. Kontinuitas Informasi Memastikan Bahwa Informasi Tentang Kondisi Kesehatan Ibu Tersampaikan Dengan Baik Antar Tahapan Pelayanan, Sedangkan Kontinuitas Manajemen Melibatkan Koordinasi Berbagai Aspek Pelayanan Kebidanan Secara Integratif Untuk Mencapai Hasil Persalinan Optimal (Fenwick Et Al., 2020).

## 2. Keuntungan Penerapan Continuity Of Care Terhadap Outcome Persalinan

Penerapan Prinsip *Continuity Of Care* Dalam Kebidanan Terbukti Memberikan Dampak Positif Terhadap Berbagai *Outcome* Persalinan Baik Secara Klinis Maupun Psikologis. Studi Oleh Rayment-Jones Et Al. (2022) Menunjukkan Bahwa Perempuan Yang Menerima Asuhan Kebidanan Berbasis Kontinuitas Memiliki Tingkat Kepuasan Lebih Tinggi, Merasa Lebih Didukung Secara Emosional, Dan Memiliki Pengalaman Persalinan Yang Lebih Positif Dibandingkan Dengan Mereka Yang Menerima Pelayanan Konvensional Atau Fragmented Care.

Selain Itu, Penelitian Oleh Sutcliffe Et Al. (2021) Juga Menemukan Bahwa Penerapan Model Kontinuitas Asuhan Kebidanan Berhubungan Erat Dengan Penurunan Angka Intervensi Medis Yang Tidak Perlu, Seperti Penurunan Tindakan Episiotomi, Penggunaan Analgesia Epidural Yang Lebih Rendah, Serta Menurunnya Angka Operasi Caesar Yang Tidak Berindikasi Medis. Secara Lebih Spesifik, Pendekatan Ini Dikaitkan Dengan Penurunan Risiko Komplikasi Selama Persalinan Serta Meningkatkan Keberhasilan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Segera Setelah Melahirkan (Sandall Et Al., 2021).

Lebih Jauh Lagi, Pendekatan Kontinuitas Asuhan Juga Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Kesehatan Mental Ibu. Ibu Yang Mendapatkan Kontinuitas Asuhan Cenderung Memiliki Tingkat Stres Dan Kecemasan Yang Lebih Rendah, Serta Lebih Jarang Mengalami Depresi Pasca Melahirkan Dibandingkan Dengan Kelompok Yang Menerima Perawatan Terfragmentasi (Mclachlan Et Al., 2022).

## 3. Tantangan Implementasi Continuity Of Care Di Indonesia

Meskipun Penerapan Continuity Of Care Memberikan Banyak Manfaat, Terdapat Beberapa Tantangan Dalam Implementasinya Di Indonesia. Tantangan

Utama Yang Dihadapi Meliputi Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Jumlah Bidan), Beban Kerja Yang Tinggi, Serta Kondisi Geografis Dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Yang Beragam Antar Wilayah. Studi Oleh Rahmadhani Dan Andini (2021) Menunjukkan Bahwa Beban Kerja Yang Tinggi Dan Rasio Bidan Terhadap Pasien Yang Tidak Ideal Menjadi Faktor Penghambat Utama Dalam Implementasi Continuity Of Care Di Berbagai Fasilitas Kesehatan, Terutama Di Wilayah Pedesaan Dan Terpencil.

Selain Itu, Faktor Sosio-Kultural Juga Menjadi Tantangan Tersendiri. Kepercayaan Masyarakat Yang Kuat Terhadap Sistem Persalinan Berbasis Keluarga Dan Dukun Beranak Masih Dominan Di Beberapa Daerah Indonesia, Sehingga Pendekatan Continuity Of Care Berbasis Bidan Profesional Sering Kali Menemui Hambatan Dalam Penerapannya Secara Penuh (Sulistyawati Et Al., 2020).

Lebih Lanjut, Tantangan Implementasi Continuity Of Care Juga Melibatkan Aspek Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah. Hingga Saat Ini, Kebijakan Nasional Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan Masih Belum Sepenuhnya Mendukung Penerapan Continuity Of Care Secara Sistematis Dan Menyeluruh. Kurangnya Pelatihan Yang Mendukung Keterampilan Interpersonal Serta Kurangnya Pemahaman Akan Pentingnya Continuity Of Care Pada Level Manajerial Dan Kebijakan, Menjadi Faktor Lain Yang Turut Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Model Tersebut Di Indonesia (Arsyad Et Al., 2021).

Secara Keseluruhan, Walaupun Tantangan Implementasi Continuity Of Care Masih Cukup Besar Di Indonesia, Dengan Perencanaan Kebijakan Yang Matang, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan, Serta Edukasi Masyarakat Secara Luas, Pendekatan Ini Sangat Berpotensi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan Dan Keselamatan Ibu Dan Bayi Di Masa Depan.

### **C. Teknik Pendampingan Emosional Dan Psikologis Dalam Persalinan**

---

#### **1. Dukungan Emosional Sebagai Bagian Penting Dari Asuhan Persalinan**

Dukungan Emosional Merupakan Elemen Penting Dalam Praktik Kebidanan Yang Bertujuan Menciptakan Pengalaman Persalinan Yang Positif Bagi Ibu. Asuhan Ini Diberikan Melalui Berbagai Bentuk Seperti Empati, Perhatian Penuh (Mindfulness), Mendengarkan Keluhan, Serta Menenangkan Ibu Selama Proses Persalinan. Dukungan Emosional Membantu Ibu Merasa Lebih Dihargai, Nyaman, Dan Memiliki Kontrol Lebih Besar Terhadap Proses Persalinannya (Aune Et Al., 2021).

Penelitian Oleh Aune Et Al. (2021) Menunjukkan Bahwa Ibu Yang Menerima Dukungan Emosional Secara Konsisten Dari Bidan Melaporkan Tingkat Kepuasan

Yang Lebih Tinggi Terhadap Pengalaman Persalinannya, Serta Mengalami Penurunan Rasa Takut Dan Kecemasan. Selain Itu, Dukungan Emosional Dari Bidan Juga Berkaitan Erat Dengan Pengurangan Kebutuhan Akan Intervensi Medis, Seperti Penggunaan Analgesia Epidural, Dan Bahkan Dapat Memperpendek Durasi Persalinan (Nilsson Et Al., 2020).

Dalam Praktik Sehari-Hari, Dukungan Emosional Yang Diberikan Oleh Bidan Mencakup Mendampingi Ibu Secara Fisik Maupun Verbal, Memberikan Validasi Atas Perasaan Ibu, Serta Membantu Ibu Mengembangkan Strategi Adaptasi Dalam Menghadapi Nyeri Dan Stres Selama Persalinan (Fenwick Et Al., 2020). Pendekatan Ini Mengintegrasikan Aspek Emosional Dan Psikologis Dengan Aspek Fisik Dan Medis, Sehingga Mendukung Keseluruhan Kesejahteraan Ibu Selama Persalinan.

## 2. Teknik Komunikasi Terapeutik Dalam Membangun Kepercayaan Ibu Selama Proses Persalinan

Teknik Komunikasi Terapeutik Merupakan Keterampilan Esensial Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Bidan Dalam Mendukung Ibu Selama Proses Persalinan. Komunikasi Terapeutik Melibatkan Pendekatan Yang Aktif Dan Empatik Dengan Tujuan Membangun Hubungan Yang Harmonis, Mengurangi Ketegangan Emosional, Dan Meningkatkan Rasa Percaya Ibu Terhadap Kemampuan Dirinya Serta Terhadap Bidan Yang Mendampingi (Beecher Et Al., 2021).

Menurut Beecher Et Al. (2021), Komunikasi Terapeutik Mencakup Beberapa Prinsip Dasar, Antara Lain: Mendengarkan Aktif (*Active Listening*), Memberikan Respon Yang Empatik, Mengajukan Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Questions*), Serta Memberikan Informasi Secara Jelas Dan Sederhana. Bidan Yang Mampu Menerapkan Komunikasi Terapeutik Secara Efektif Dapat Membantu Ibu Merasa Lebih Tenang, Dihargai, Serta Percaya Bahwa Proses Persalinan Yang Mereka Lalui Berjalan Dengan Aman.

Implementasi Komunikasi Terapeutik Secara Efektif Juga Telah Terbukti Dapat Menurunkan Kecemasan Dan Ketakutan Maternal Yang Sering Kali Dialami Selama Proses Persalinan (Borrelli Et Al., 2021). Keterampilan Ini Menjadi Lebih Krusial Terutama Ketika Ibu Menghadapi Situasi Persalinan Yang Tidak Terduga Atau Komplikasi Yang Dapat Meningkatkan Kecemasan Dan Stresnya.

## 3. Strategi Bidan Dalam Mengatasi Kecemasan Dan Stres Maternal

Kecemasan Dan Stres Merupakan Respons Psikologis Yang Umum Dialami Oleh Ibu Selama Proses Persalinan. Respons Ini Dapat Dipicu Oleh Rasa Takut Terhadap Nyeri Persalinan, Ketidakpastian Mengenai Proses Persalinan, Serta

Kekhawatiran Terhadap Kondisi Bayi. Untuk Mengatasi Masalah Ini, Bidan Perlu Menerapkan Berbagai Strategi Psikologis Dan Emosional Yang Terbukti Efektif Dalam Mengurangi Dampak Negatif Dari Stres Maternal Tersebut (Handelzalts Et Al., 2020).

Handelzalts Et Al. (2020) Merekomendasikan Beberapa Strategi Efektif, Antara Lain Penggunaan Teknik Relaksasi Seperti Latihan Pernapasan Dalam, Teknik Visualisasi Positif, Dan Penggunaan Musik Yang Menenangkan Selama Proses Persalinan. Bidan Juga Dapat Menggunakan Teknik Distraksi Positif Seperti Mengajak Ibu Berbicara Tentang Hal-Hal Yang Menyenangkan Atau Memberikan Motivasi Verbal Secara Konsisten.

Di Samping Itu, Strategi Lain Yang Cukup Efektif Adalah Edukasi Antenatal Secara Menyeluruh Yang Diberikan Sejak Masa Kehamilannya. Edukasi Ini Membantu Ibu Membangun Kesiapan Mental Sehingga Mengurangi Tingkat Kecemasan Saat Menghadapi Persalinan (Toohill Et Al., 2021). Studi Lain Juga Menekankan Bahwa Strategi Interpersonal Seperti Memberikan Perhatian Penuh Dan Validasi Terhadap Perasaan Ibu, Serta Memperkuat Peran Keluarga Dalam Memberikan Dukungan, Secara Signifikan Mampu Mengurangi Stres Maternal (Fenwick Et Al., 2020).

Secara Umum, Strategi Bidan Dalam Mengelola Stres Maternal Tidak Hanya Berdampak Positif Pada Aspek Psikologis Ibu, Namun Juga Memiliki Dampak Langsung Terhadap Hasil Persalinan, Termasuk Mengurangi Risiko Komplikasi Persalinan Dan Meningkatkan Hubungan Positif Antara Ibu Dan Bayi Setelah Persalinan.

#### **D. Teknik Fisik Dan Non-Farmakologis Dalam Pendampingan Persalinan**

---

1. Penerapan Teknik Relaksasi Seperti Pijat, Aromaterapi, Dan Akupresur Dalam Proses Persalinan Normal

Teknik Relaksasi Merupakan Salah Satu Pendekatan Non-Farmakologis Yang Efektif Digunakan Dalam Mendukung Proses Persalinan Normal. Berbagai Teknik Relaksasi Yang Umum Digunakan Dalam Praktik Kebidanan Antara Lain Pijat (*Massage*), Aromaterapi, Dan Akupresur. Levett Et Al. (2021) Dalam Sebuah Kajian Sistematis Menjelaskan Bahwa Teknik-Teknik Tersebut Dapat Membantu Ibu Dalam Mengelola Nyeri Dan Stres Selama Persalinan Serta Meningkatkan Kenyamanan Secara Fisik Maupun Emosional.

Pijat Selama Persalinan Terbukti Secara Ilmiah Mampu Mengurangi Persepsi Nyeri, Kecemasan, Serta Meningkatkan Pelepasan Hormon Oksitosin Yang Mendukung Progres Persalinan Normal (Smith Et Al., 2020). Aromaterapi Dengan Penggunaan Minyak Esensial Seperti Lavender Dan Peppermint Juga Memberikan



Manfaat Signifikan Dalam Menenangkan Ibu, Mengurangi Stres, Dan Mempercepat Tahapan Persalinan (Ghiasi Et Al., 2021). Sementara Itu, Akupresur, Teknik Tekanan Pada Titik-Titik Spesifik Tubuh, Juga Terbukti Efektif Dalam Mengurangi Intensitas Nyeri Persalinan Serta Mempercepat Dilatasi Serviks (Makvandi Et Al., 2021).

Dalam Implementasi Klinisnya, Teknik-Teknik Relaksasi Ini Dapat Diaplikasikan Secara Mandiri Maupun Kombinasi. Keterampilan Bidan Dalam Menerapkan Teknik Relaksasi Secara Tepat Sangat Berkontribusi Dalam Menciptakan Lingkungan Persalinan Yang Nyaman, Minim Stres, Dan Mendorong Proses Persalinan Yang Lebih Lancak Serta Positif (Levett Et Al., 2021).

## 2. Manfaat Dan Efektivitas Metode Perubahan Posisi Dan Mobilisasi Ibu Dalam Mengurangi Nyeri Persalinan

Metode Perubahan Posisi Dan Mobilisasi Selama Persalinan Dikenal Sebagai Pendekatan Non-Farmakologis Yang Penting Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Serta Mempercepat Proses Persalinan Normal. Lawrence Et Al. (2020) Menjelaskan Bahwa Ibu Yang Aktif Bergerak Dan Rutin Mengubah Posisi Selama Persalinan Memiliki Persepsi Nyeri Yang Lebih Rendah Dibandingkan Ibu Yang Hanya Diam Dalam Satu Posisi. Posisi Seperti Jongkok, Berdiri, Atau Berlutut Dapat Memperbesar Diameter Panggul, Memperlancar Aliran Darah Ke Janin, Serta Membantu Bayi Turun Lebih Optimal.

Penelitian Oleh Singata Et Al. (2020) Juga Menunjukkan Bahwa Mobilisasi Aktif, Seperti Berjalan Atau Bergoyang Ringan Selama Kontraksi, Tidak Hanya Mengurangi Nyeri Tetapi Juga Membantu Mempercepat Pembukaan Serviks Dan Mengurangi Durasi Persalinan. Selain Itu, Mobilisasi Membantu Ibu Merasa Lebih Mampu Mengendalikan Proses Persalinan, Sehingga Menghasilkan Pengalaman Persalinan Yang Lebih Positif Dan Meminimalkan Kebutuhan Intervensi Medis.

Dari Perspektif Fisiologis, Mobilisasi Dan Perubahan Posisi Membantu Optimalisasi Penggunaan Gravitasi Untuk Mendukung Proses Penurunan Kepala Bayi, Mengurangi Kompresi Saraf Panggul, Dan Meningkatkan Kenyamanan Ibu Selama Proses Persalinan Berlangsung (Ondeck, 2021).

## 3. Edukasi Bidan Dalam Penerapan Teknik Non-Farmakologis Di Layanan Primer

Penerapan Teknik Non-Farmakologis Dalam Layanan Primer Menuntut Keterampilan Dan Pengetahuan Khusus Dari Bidan. Edukasi Mengenai Teknik-Teknik Tersebut Sangat Penting Guna Meningkatkan Kompetensi Profesional Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Yang Berbasis Bukti. Menurut Studi Yang Dilakukan Oleh Adams Et Al. (2022), Edukasi Yang Terstruktur Tentang Pendekatan Non-Farmakologis Kepada Bidan Secara Signifikan Meningkatkan

Kepercayaan Diri Dan Kompetensi Mereka Dalam Praktik Sehari-Hari, Khususnya Di Layanan Kesehatan Primer.

Edukasi Untuk Bidan Dapat Mencakup Pelatihan Langsung Melalui Simulasi Klinis, Workshop, Serta Modul Pembelajaran Interaktif Yang Menekankan Pada Demonstrasi Teknik, Manfaat, Kontraindikasi, Dan Metode Komunikasi Yang Efektif Dalam Mengaplikasikan Teknik Ini Kepada Ibu Bersalin (Hunter Et Al., 2021). Dengan Edukasi Yang Baik, Bidan Mampu Mengidentifikasi Teknik Yang Paling Tepat Untuk Setiap Individu Ibu Berdasarkan Preferensi, Kondisi Klinis, Serta Latar Belakang Sosial Dan Budaya Pasien.

Dalam Konteks Indonesia, Integrasi Edukasi Teknik Non-Farmakologis Dalam Kurikulum Pendidikan Kebidanan Serta Pelatihan Berkelanjutan Untuk Tenaga Kebidanan Dapat Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Kebidanan Secara Luas, Yang Pada Akhirnya Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kualitas Pengalaman Persalinan Bagi Ibu Dan Bayi (Pratiwi & Purwandari, 2021).

#### **E. Monitoring Progres Persalinan Oleh Bidan**

---

##### **1. Indikator Penting Dalam Pemantauan Proses Persalinan Normal**

Monitoring Atau Pemantauan Progres Persalinan Merupakan Bagian Esensial Dari Asuhan Kebidanan Yang Bertujuan Untuk Memastikan Keselamatan Ibu Dan Bayi Selama Proses Persalinan. World Health Organization (Who, 2018) Merekomendasikan Beberapa Indikator Penting Dalam Pemantauan Proses Persalinan Normal, Yaitu Frekuensi Dan Durasi Kontraksi Uterus, Kemajuan Dilatasi Serviks, Penurunan Kepala Janin, Kondisi Kesejahteraan Ibu Seperti Tekanan Darah Dan Suhu Tubuh, Serta Detak Jantung Janin Sebagai Indikator Kesejahteraan Janin.

Rahayu Dan Irawaty (2022) Dalam Penelitiannya Menegaskan Pentingnya Pemantauan Ketat Terhadap Kontraksi Uterus Dan Dilatasi Serviks Sebagai Indikator Utama Progres Persalinan. Pemantauan Tersebut Bertujuan Mengidentifikasi Secara Dini Kondisi Persalinan Yang Mengalami Hambatan Atau Komplikasi. Selain Itu, Monitoring Detak Jantung Janin Juga Menjadi Parameter Krusial Karena Membantu Bidan Dalam Mendeteksi Dini Distress Janin, Yang Dapat Menyebabkan Komplikasi Serius Jika Tidak Segera Ditangani.

Indikator Lain Yang Penting Diperhatikan Adalah Penurunan Kepala Janin Atau Penurunan Bagian Terbawah Janin Ke Dalam Panggul Ibu. Kemajuan Penurunan Kepala Janin Menggambarkan Sejauh Mana Janin Bergerak Melalui Jalan Lahir, Yang Merupakan Tanda Penting Dari Progres Persalinan Normal Dan Kesiapan Ibu Untuk Melahirkan Secara Alami (Who, 2018).

## 2. Penggunaan Partograf Dalam Pendampingan Proses Persalinan

Partograf Merupakan Alat Bantu Visual Yang Digunakan Bidan Dalam Memantau Kemajuan Proses Persalinan, Yang Mencatat Berbagai Indikator Seperti Dilatasi Serviks, Penurunan Kepala Janin, Kontraksi Uterus, Serta Tanda Vital Ibu Dan Janin Secara Sistematis Dan Terstruktur (Azizah Et Al., 2020). Partograf Menjadi Alat Bantu Utama Dalam Pemantauan Proses Persalinan Di Berbagai Fasilitas Kesehatan Karena Efektif Membantu Identifikasi Dini Komplikasi Persalinan.

Azizah Et Al. (2020) Menemukan Bahwa Penggunaan Partograf Secara Konsisten Oleh Bidan Dapat Mengurangi Angka Komplikasi, Seperti Persalinan Lama Dan Persalinan Macet (Distosia), Serta Menurunkan Kebutuhan Terhadap Intervensi Medis Yang Tidak Perlu. Hal Ini Disebabkan Oleh Kemampuan Partograf Untuk Memberikan Gambaran Visual Mengenai Progres Persalinan Secara Real-Time, Memungkinkan Bidan Mengambil Keputusan Klinis Secara Lebih Tepat Waktu Dan Efektif.

Senada Dengan Itu, Penelitian Sutarmi Dan Prabandari (2021) Menyebutkan Bahwa Implementasi Partograf Yang Benar Oleh Bidan Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan, Mengurangi Angka Mortalitas Dan Morbiditas Maternal Serta Neonatal, Sekaligus Meningkatkan Kepuasan Ibu Terhadap Proses Persalinannya. Untuk Mencapai Manfaat Optimal, Penting Bagi Bidan Mendapatkan Pelatihan Khusus Mengenai Penggunaan Partograf Serta Interpretasi Data Yang Akurat Dan Tepat Waktu.

## 3. Tindakan Preventif Dan Intervensi Dini Dalam Menghadapi Komplikasi Potensial Selama Proses Persalinan

Tindakan Preventif Dan Intervensi Dini Merupakan Bagian Penting Dalam Asuhan Persalinan Oleh Bidan, Terutama Dalam Mengelola Situasi Yang Berpotensi Menjadi Komplikasi Selama Persalinan. Tindakan Preventif Mencakup Edukasi Antenatal, Persiapan Ibu Terhadap Persalinan, Serta Pemantauan Ketat Selama Persalinan Yang Bertujuan Mengidentifikasi Dini Kondisi Risiko Tinggi (Beake Et Al., 2021).

Menurut Studi Yang Dilakukan Oleh Borrelli Et Al. (2021), Deteksi Dini Tanda Komplikasi Seperti Distosia Bahu, Persalinan Lama, Hipertensi Dalam Persalinan, Atau Fetal Distress Memungkinkan Bidan Mengambil Langkah Intervensi Dini Yang Tepat Seperti Perubahan Posisi Ibu, Oksigenasi Tambahan, Hidrasi, Atau Merujuk Segera Ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lebih Tinggi Jika Diperlukan.

Selain Itu, Studi Terbaru Menekankan Pentingnya Keterampilan Klinis Bidan Dalam Mengenali Tanda Awal Komplikasi Persalinan Serta Kesiapan Mengambil

Keputusan Klinis Dengan Segera. Misalnya, Pengenalan Dini Kondisi Hipoksia Janin Melalui Monitoring Ketat Detak Jantung Janin Serta Penggunaan Oksitosin Secara Selektif Dan Hati-Hati Dalam Persalinan Yang Mengalami Hambatan Kemajuan (Lutomski Et Al., 2020).

Di Indonesia, Tindakan Preventif Dan Intervensi Dini Ini Harus Didukung Dengan Kebijakan Kesehatan Yang Jelas, Pelatihan Keterampilan Klinis Yang Berkelanjutan Bagi Bidan, Serta Ketersediaan Fasilitas Rujukan Yang Memadai, Terutama Di Daerah-Daerah Terpencil Dengan Akses Fasilitas Kesehatan Yang Terbatas (Kemenkes Ri, 2020).

Pemantauan Progres Persalinan Secara Cermat, Tindakan Preventif, Dan Intervensi Dini Yang Tepat Merupakan Kunci Utama Dalam Meningkatkan Kualitas Persalinan Normal Yang Aman Serta Menekan Angka Morbiditas Dan Mortalitas Maternal Dan Neonatal Di Indonesia.

#### **F. Peran Bidan Dalam Melibatkan Keluarga Pada Proses Persalinan**

---

##### **1. Dampak Positif Partisipasi Keluarga Selama Persalinan Terhadap Kenyamanan Ibu Dan Hasil Persalinan**

Partisipasi Keluarga Dalam Proses Persalinan Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Terciptanya Lingkungan Persalinan Yang Positif Dan Kondusif. Dukungan Keluarga, Baik Dari Pasangan Maupun Anggota Keluarga Lainnya, Terbukti Dapat Meningkatkan Kenyamanan Psikologis Ibu Selama Persalinan Serta Menghasilkan Outcome Persalinan Yang Lebih Baik. Studi Yang Dilakukan Oleh Pratiwi Dan Purwandari (2021) Menemukan Bahwa Ibu Yang Mendapatkan Pendampingan Keluarga Menunjukkan Tingkat Stres Yang Lebih Rendah, Rasa Percaya Diri Yang Meningkat, Serta Persepsi Nyeri Yang Lebih Terkontrol Selama Proses Persalinan.

Kehadiran Keluarga Juga Terbukti Meningkatkan Kepuasan Ibu Terhadap Pengalaman Melahirkan, Mengurangi Tingkat Kecemasan Dan Depresi Postpartum, Serta Berkontribusi Pada Peningkatan Bonding Atau Ikatan Emosional Awal Antara Ibu Dan Bayi (Rahmawati Et Al., 2020). Selain Manfaat Psikologis, Partisipasi Keluarga Dalam Proses Persalinan Juga Berhubungan Dengan Menurunnya Angka Intervensi Medis Yang Tidak Perlu, Termasuk Penggunaan Analgesia Epidural, Oksitosin, Serta Tindakan Operasi Caesar Tanpa Indikasi Klinis Yang Jelas (Kartika & Handayani, 2022).

##### **2. Teknik Komunikasi Efektif Bidan Dalam Memberdayakan Keluarga Selama Persalinan**

Bidan Memiliki Peran Penting Dalam Memberdayakan Keluarga Agar Dapat Berpartisipasi Secara Efektif Selama Proses Persalinan. Salah Satu Keterampilan Yang Dibutuhkan Dalam Memberdayakan Keluarga Adalah Teknik Komunikasi Efektif Yang Jelas, Empatik, Dan Informatif. Menurut Hidayati Et Al. (2022), Teknik Komunikasi Efektif Melibatkan Komunikasi Terbuka, Memberikan Informasi Secara Jelas Dan Sederhana, Serta Memvalidasi Perasaan Keluarga Sehingga Mereka Merasa Dihargai Dan Lebih Percaya Diri Dalam Mendukung Ibu Bersalin.

Beberapa Strategi Komunikasi Yang Efektif Meliputi Pemberian Edukasi Sejak Masa Antenatal, Penjelasan Mengenai Peran Keluarga Secara Spesifik Selama Persalinan, Serta Penggunaan Bahasa Yang Mudah Dipahami Oleh Keluarga Tanpa Mengurangi Kualitas Informasi Medis Yang Diberikan (Saputri Et Al., 2021). Dalam Praktik Klinis, Teknik Seperti Mendengarkan Aktif (*Active Listening*), Komunikasi Asertif Yang Sopan, Dan Memberikan Dorongan Verbal Positif Kepada Keluarga Juga Mampu Meningkatkan Kepercayaan Dan Partisipasi Aktif Mereka Selama Proses Persalinan (Hidayati Et Al., 2022).

### 3. Tantangan Budaya Dalam Mengimplementasikan Pendampingan Keluarga Di Indonesia

Implementasi Partisipasi Keluarga Dalam Proses Persalinan Di Indonesia Masih Menemui Sejumlah Tantangan, Terutama Terkait Aspek Sosial Dan Budaya. Di Beberapa Daerah, Tradisi Dan Kepercayaan Lokal Masih Menganggap Persalinan Sebagai Domain Yang Terbatas Bagi Perempuan Saja, Sehingga Partisipasi Pasangan Atau Anggota Keluarga Laki-Laki Sering Dianggap Tidak Pantas Atau Kurang Diterima Secara Sosial (Sulistyawati Et Al., 2020).

Selain Itu, Peran Keluarga Besar Yang Dominan Terkadang Dapat Menimbulkan Tekanan Psikologis Tersendiri Bagi Ibu Bersalin, Khususnya Ketika Ada Perbedaan Pandangan Mengenai Prosedur Persalinan Yang Dianggap Ideal Oleh Tenaga Kesehatan Dibandingkan Dengan Tradisi Keluarga (Kurniasari Et Al., 2022). Kondisi Ini Menuntut Bidan Memiliki Sensitivitas Budaya Yang Tinggi Serta Keterampilan Negosiasi Dan Mediasi Untuk Menyeimbangkan Antara Prinsip-Prinsip Klinis Dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Keluarga (Pratiwi & Purwandari, 2021).

Hambatan Lain Yang Diidentifikasi Oleh Penelitian Adalah Kurangnya Fasilitas Yang Memadai Di Beberapa Wilayah Layanan Primer Di Indonesia Yang Memungkinkan Kehadiran Keluarga Secara Fisik Selama Persalinan, Serta Keterbatasan Edukasi Mengenai Pentingnya Dukungan Keluarga Sejak Masa Antenatal (Andarini Et Al., 2021). Oleh Karena Itu, Diperlukan Edukasi Yang Sistematis Dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat, Sekaligus Pelatihan Khusus Bagi

Bidan Tentang Bagaimana Mengintegrasikan Pendekatan Keluarga Dalam Layanan Kebidanan Yang Berbasis Bukti.

Secara Keseluruhan, Meskipun Terdapat Tantangan Budaya Dalam Implementasi Pendampingan Keluarga, Dengan Pendekatan Komunikasi Yang Tepat, Pelatihan Bidan Yang Berkelanjutan, Serta Edukasi Masyarakat Yang Komprehensif, Partisipasi Keluarga Dalam Proses Persalinan Dapat Dioptimalkan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan Di Indonesia.

## **G. Manajemen Nyeri Selama Persalinan**

---

### **1. Pendekatan Holistik Dalam Manajemen Nyeri Persalinan**

Manajemen Nyeri Persalinan Merupakan Komponen Penting Dalam Pelayanan Kebidanan, Dengan Pendekatan Holistik Sebagai Metode Yang Semakin Banyak Dianjurkan Dalam Praktik Klinis. Pendekatan Holistik Memandang Nyeri Persalinan Bukan Hanya Sebagai Fenomena Fisik Semata, Tetapi Juga Melibatkan Aspek Emosional, Psikologis, Spiritual, Dan Sosial Dari Ibu Yang Bersalin. Beake Et Al. (2021) Dalam Penelitiannya Menjelaskan Bahwa Pendekatan Ini Dapat Meningkatkan Rasa Nyaman, Mengurangi Kecemasan, Dan Menciptakan Pengalaman Persalinan Yang Lebih Positif Bagi Ibu.

Pendekatan Holistik Mencakup Berbagai Teknik Seperti Dukungan Emosional Kontinu, Edukasi Prenatal Yang Menyeluruh, Intervensi Non-Farmakologis Seperti Pijat, Aromaterapi, Teknik Pernapasan, Meditasi Mindfulness, Hingga Teknik-Teknik Spiritual Sesuai Budaya Lokal (Smith Et Al., 2020). Kelebihan Utama Pendekatan Ini Adalah Membantu Ibu Bersalin Merasa Lebih Mampu Mengendalikan Pengalaman Persalinannya, Sehingga Persepsi Nyeri Menjadi Lebih Terkelola Dan Dampak Negatif Nyeri Terhadap Kondisi Psikologis Ibu Berkurang Secara Signifikan (Nilsson Et Al., 2020).

### **2. Kombinasi Teknik Farmakologis Dan Non-Farmakologis Yang Dapat Dilakukan Oleh Bidan**

Dalam Praktik Kebidanan, Kombinasi Antara Teknik Farmakologis Dan Non-Farmakologis Dianggap Sebagai Strategi Optimal Dalam Manajemen Nyeri Persalinan. Menurut Simkin Dan Bolding (2020), Teknik Farmakologis Seperti Analgesia Inhalasi, Penggunaan Analgesik Opioid Ringan, Atau Analgesia Regional Seperti Blok Pudendal Seringkali Dapat Dikombinasikan Secara Efektif Dengan Teknik Non-Farmakologis Seperti Hidroterapi, Perubahan Posisi, Mobilisasi, Dan Penggunaan Bola Persalinan (Birthing Ball).

Penelitian Terbaru Menunjukkan Bahwa Kombinasi Ini Mampu Meningkatkan Efektivitas Dalam Mengurangi Nyeri, Sambil Meminimalkan Efek Samping Yang Mungkin Timbul Akibat Penggunaan Obat-Obatan Analgesik (Madden Et Al., 2021). Peran Bidan Di Sini Adalah Menentukan Dan Mengkombinasikan Metode Mana Yang Paling Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Klinis, Preferensi Pribadi Ibu, Serta Situasi Persalinan Yang Sedang Berlangsung. Pemahaman Mendalam Bidan Terhadap Kelebihan Dan Keterbatasan Setiap Teknik Merupakan Faktor Kunci Keberhasilan Kombinasi Pendekatan Ini Dalam Mengelola Nyeri Persalinan (Hunter Et Al., 2021).

### 3. Strategi Edukasi Bidan Untuk Menyiapkan Mental Ibu Dalam Menghadapi Nyeri Persalinan

Edukasi Prenatal Yang Komprehensif Merupakan Bagian Integral Dari Manajemen Nyeri Selama Persalinan, Dengan Tujuan Utama Membantu Ibu Secara Mental Siap Menghadapi Proses Persalinan Yang Akan Dialami. Menurut Penelitian Yang Dilakukan Oleh Toohill Et Al. (2021), Ibu Yang Mendapatkan Edukasi Prenatal Yang Tepat Cenderung Memiliki Tingkat Ketakutan Dan Kecemasan Yang Lebih Rendah Serta Mampu Menghadapi Nyeri Persalinan Secara Lebih Baik.

Strategi Edukasi Bidan Mencakup Beberapa Elemen Penting, Antara Lain Pemberian Informasi Realistis Mengenai Proses Fisiologis Persalinan, Diskusi Terbuka Tentang Opsi Manajemen Nyeri Yang Tersedia, Latihan Teknik Relaksasi Dan Pernapasan, Serta Pemberian Dukungan Emosional Melalui Konseling Yang Berkelanjutan (Levett Et Al., 2021). Selain Itu, Bidan Juga Berperan Penting Dalam Membantu Ibu Mengembangkan Mindset Positif Terhadap Proses Persalinan, Meningkatkan Rasa Percaya Diri Ibu Terhadap Kemampuan Tubuhnya Sendiri, Serta Membangun Ekspektasi Realistis Mengenai Nyeri Dan Mekanisme Adaptasi Terhadap Nyeri Persalinan Tersebut (Fenwick Et Al., 2020).

Implementasi Edukasi Prenatal Yang Baik Oleh Bidan Akan Membantu Ibu Memiliki Keterampilan Coping Yang Efektif, Yang Pada Akhirnya Mampu Meningkatkan Kualitas Pengalaman Persalinan, Mengurangi Stres, Serta Meminimalisir Kebutuhan Intervensi Medis Yang Tidak Diperlukan (Levett Et Al., 2021).

## **H. Kompetensi Profesional Bidan Dalam Pendampingan Persalinan**

---

1. Standar Kompetensi Pendampingan Bidan Berdasarkan Kepmenkes No. 320 Tahun 2020

Kompetensi Profesional Merupakan Aspek Penting Dalam Pelaksanaan Praktik Kebidanan, Terutama Dalam Mendampingi Persalinan Normal Secara Aman Dan Efektif. Menurut Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan, Kompetensi Profesional Bidan Mencakup Berbagai Aspek Yang Meliputi Keterampilan Teknis, Interpersonal, Etika Profesi, Serta Kemampuan Dalam Mengambil Keputusan Klinis Secara Tepat Dan Berbasis Bukti Selama Proses Persalinan (Kementerian Kesehatan Ri, 2020).

Standar Ini Secara Spesifik Menegaskan Bahwa Seorang Bidan Harus Mampu Melakukan Pendampingan Secara Komprehensif Selama Proses Persalinan Dengan Berpedoman Pada Praktik Kebidanan Berbasis Bukti (Evidence-Based Midwifery Practice). Kompetensi Ini Meliputi Kemampuan Dalam Melakukan Asesmen Fisik Dan Psikologis Ibu, Pengelolaan Nyeri Secara Farmakologis Dan Non-Farmakologis, Pemantauan Ketat Progres Persalinan Menggunakan Alat Bantu Seperti Partograf, Serta Kemampuan Melakukan Komunikasi Efektif Dengan Ibu Dan Keluarga Selama Persalinan Berlangsung (Kemenkes Ri, 2020).

Selain Itu, Standar Kompetensi Ini Juga Mengamanatkan Bidan Untuk Mampu Mengenali Dan Mengelola Komplikasi Awal Yang Dapat Muncul Selama Proses Persalinan Serta Mampu Bekerja Sama Dengan Tenaga Kesehatan Lain Dalam Situasi Darurat Yang Memerlukan Intervensi Lebih Lanjut (Kementerian Kesehatan Ri, 2020).

## 2. Upaya Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Bidan (Cpd - Continuous Professional Development)

Continuous Professional Development (Cpd) Atau Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Adalah Upaya Penting Yang Harus Dilakukan Bidan Untuk Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan Secara Terus-Menerus. Hastuti Dan Nasution (2021) Dalam Penelitiannya Mengungkapkan Bahwa Cpd Efektif Dalam Meningkatkan Keterampilan Klinis, Pengetahuan Terbaru, Dan Praktik Kebidanan Berbasis Bukti Yang Sangat Penting Dalam Pendampingan Persalinan.

Cpd Dapat Dilakukan Melalui Berbagai Bentuk, Seperti Pelatihan Rutin, Seminar, Workshop, Pembelajaran Online, Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Secara Berkala. Studi Terbaru Menekankan Bahwa Pelatihan Berbasis Simulasi Dan Pembelajaran Aktif Mampu Meningkatkan Kepercayaan Diri, Keterampilan Praktis, Serta Kemampuan Berpikir Kritis Bidan Dalam Menghadapi Situasi Persalinan Yang Kompleks (Harahap Et Al., 2021).



Selain Aspek Teknis, Cpd Juga Mencakup Peningkatan Kemampuan Interpersonal Dan Komunikasi Efektif, Yang Merupakan Kompetensi Penting Dalam Menciptakan Hubungan Yang Positif Dan Saling Percaya Antara Bidan Dan Pasien (Sulistyorini & Prabandari, 2022). Upaya Cpd Yang Sistematis Dan Berkelanjutan Telah Terbukti Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persalinan, Keselamatan Ibu Dan Bayi, Serta Meningkatkan Profesionalisme Bidan Secara Keseluruhan.

### 3. Evaluasi Kompetensi Pendampingan Melalui Metode Observasi Klinik Dan Feedback Langsung

Evaluasi Kompetensi Profesional Bidan Dalam Pendampingan Persalinan Merupakan Langkah Penting Guna Memastikan Kualitas Pelayanan Yang Optimal Dan Sesuai Dengan Standar Profesi. Metode Evaluasi Kompetensi Yang Efektif Antara Lain Melalui Observasi Klinik Secara Langsung Dan Pemberian Feedback (Umpan Balik) Segera Setelah Observasi Dilakukan (Setyorini Et Al., 2020).

Melalui Observasi Klinik, Keterampilan Praktis, Teknik Komunikasi, Serta Kemampuan Pengambilan Keputusan Klinis Bidan Dapat Dinilai Secara Obyektif Dalam Situasi Nyata. Studi Oleh Setyorini Et Al. (2020) Menunjukkan Bahwa Observasi Langsung Oleh Supervisor Atau Senior Bidan Mampu Memberikan Gambaran Akurat Tentang Kemampuan Bidan Serta Area-Area Yang Perlu Peningkatan.

Feedback Langsung Yang Diberikan Setelah Observasi Klinik Juga Terbukti Efektif Dalam Meningkatkan Performa Profesional. Feedback Yang Bersifat Konstruktif, Spesifik, Dan Tepat Waktu Membantu Bidan Memahami Secara Jelas Kekuatan Dan Kelemahannya, Sehingga Mendorong Motivasi Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Secara Berkelanjutan (Nurmala Et Al., 2021). Strategi Evaluasi Ini Juga Menjadi Dasar Penting Dalam Menyusun Rencana Cpd Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Individu Bidan.

Secara Umum, Evaluasi Kompetensi Melalui Observasi Klinik Dan Feedback Langsung Merupakan Pendekatan Yang Efektif Untuk Menjaga Standar Kualitas Pendampingan Persalinan Dan Memastikan Bahwa Setiap Bidan Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Praktik Kebidanan Berbasis Bukti.

## **I. Hambatan Dan Tantangan Dalam Pendampingan Persalinan**

---

### 1. Hambatan Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pendampingan Bidan

Pelaksanaan Pendampingan Persalinan Oleh Bidan Di Indonesia Masih Menghadapi Berbagai Hambatan Yang Bersifat Internal Maupun Eksternal. Menurut Penelitian Yang Dilakukan Oleh Syafitri Et Al. (2021), Hambatan Internal

Mencakup Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Individu Bidan Itu Sendiri Seperti Keterbatasan Kompetensi Klinis, Kurangnya Keterampilan Komunikasi Interpersonal, Rendahnya Motivasi Kerja Akibat Beban Tugas Yang Tinggi, Serta Keterbatasan Pengetahuan Tentang Praktik Kebidanan Berbasis Bukti Terbaru.

Hambatan Eksternal Meliputi Faktor-Faktor Di Luar Kontrol Individu, Seperti Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rendahnya Dukungan Dari Institusi Tempat Bidan Bertugas, Serta Kurangnya Kebijakan Yang Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Pengembangan Profesi Secara Berkelanjutan. Selain Itu, Faktor Sosial-Budaya Yang Kuat, Seperti Preferensi Masyarakat Terhadap Layanan Persalinan Tradisional Atau Dukun Beranak, Juga Menjadi Tantangan Signifikan Dalam Implementasi Pendampingan Oleh Bidan Secara Optimal (Nugraheni Et Al., 2020).

## 2. Strategi Mengatasi Tantangan Dalam Pemberian Asuhan Persalinan Berbasis Bukti

Dalam Rangka Mengatasi Berbagai Tantangan Dalam Pelaksanaan Pendampingan Persalinan Berbasis Bukti, Diperlukan Strategi Komprehensif Yang Mencakup Aspek Pendidikan, Kebijakan, Serta Pengembangan Kompetensi Profesional. Menurut Rohmah Dan Supriyadi (2022), Salah Satu Strategi Efektif Adalah Meningkatkan Kapasitas Dan Kompetensi Bidan Melalui Pelatihan Rutin Berbasis Simulasi Klinik Dan Edukasi Berbasis Bukti Yang Terkini.

Selain Itu, Peningkatan Dukungan Institusional Berupa Penyediaan Fasilitas Yang Memadai, Akses Terhadap Sumber Informasi Kebidanan Terbaru, Serta Kebijakan Remunerasi Dan Jenjang Karir Yang Jelas Juga Penting Untuk Mempertahankan Motivasi Bidan Dalam Memberikan Asuhan Yang Optimal (Harahap Et Al., 2021). Edukasi Yang Masif Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Persalinan Yang Didampingi Oleh Tenaga Kesehatan Profesional Juga Diperlukan Guna Mengubah Persepsi Masyarakat Yang Selama Ini Masih Mengandalkan Dukun Bersalin.

Implementasi Pendekatan Pendampingan Berbasis Komunitas Yang Melibatkan Pemimpin Lokal Dan Tokoh Masyarakat Juga Terbukti Efektif Dalam Meningkatkan Penerimaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebidanan Modern, Terutama Di Daerah-Daerah Pedesaan Atau Terpencil (Kurniawati Et Al., 2021).

## 3. Kajian Kasus Tentang Tantangan Spesifik Di Berbagai Wilayah Di Indonesia

Tantangan Dalam Pendampingan Persalinan Oleh Bidan Di Indonesia Memiliki Karakteristik Yang Bervariasi Tergantung Pada Wilayah Geografis, Budaya, Dan Tingkat Aksesibilitas Terhadap Layanan Kesehatan. Sebagai Contoh,

Studi Di Wilayah Indonesia Timur Seperti Papua Dan Nusa Tenggara Timur Menunjukkan Bahwa Tantangan Utama Adalah Akses Yang Terbatas Akibat Kondisi Geografis Yang Sulit, Keterbatasan Infrastruktur Transportasi, Serta Rendahnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan, Termasuk Bidan (Handayani & Wulandari, 2022).

Sementara Itu, Di Wilayah Jawa Tengah Dan Yogyakarta, Tantangan Yang Dihadapi Lebih Berkaitan Dengan Preferensi Budaya Masyarakat Yang Kuat Terhadap Layanan Tradisional. Studi Oleh Nugroho Dan Rahayu (2021) Menemukan Bahwa Meskipun Fasilitas Kesehatan Tersedia, Preferensi Terhadap Layanan Persalinan Tradisional Masih Tinggi, Sehingga Diperlukan Upaya Edukasi Intensif Dan Strategi Integrasi Layanan Kesehatan Modern Dengan Pendekatan Budaya Lokal Agar Masyarakat Lebih Menerima Peran Bidan Secara Penuh.

Di Perkotaan Besar Seperti Jakarta Dan Surabaya, Tantangan Yang Muncul Lebih Didominasi Oleh Tingginya Angka Persalinan Yang Tidak Sesuai Indikasi Medis, Seperti Tingginya Angka Operasi Caesar Elektif Akibat Persepsi Ibu Mengenai Nyeri Dan Ketidaknyamanan Dalam Persalinan Normal. Di Wilayah Ini, Edukasi Publik Yang Lebih Intensif Mengenai Manfaat Persalinan Normal Serta Peran Bidan Dalam Mengelola Nyeri Secara Efektif Menjadi Sangat Penting (Setyowati Et Al., 2020).

Kajian Kasus Di Berbagai Wilayah Ini Memperlihatkan Bahwa Strategi Untuk Mengatasi Tantangan Dalam Pendampingan Persalinan Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Lokal Masing-Masing Wilayah Guna Mencapai Hasil Yang Optimal.

#### **J. Evaluasi Dan Monitoring Keberhasilan Pendampingan Oleh Bidan**

---

##### **1. Indikator Kualitas Pendampingan Dalam Persalinan Normal**

Evaluasi Kualitas Pendampingan Bidan Dalam Proses Persalinan Normal Memerlukan Indikator Spesifik Untuk Mengukur Sejauh Mana Intervensi Dan Layanan Yang Diberikan Telah Memenuhi Standar Praktik Terbaik. Menurut Handayani Dan Kusuma (2020), Indikator Kualitas Pendampingan Persalinan Normal Mencakup Beberapa Aspek Kunci, Antara Lain:

- a. **Kepuasan Ibu Terhadap Layanan Kebidanan**, Yang Mencerminkan Persepsi Positif Ibu Mengenai Kenyamanan Fisik, Emosional, Dan Psikologis Selama Proses Persalinan.
- b. **Tingkat Intervensi Medis Yang Minimal**, Ditandai Dengan Rendahnya Angka Penggunaan Analgesia Farmakologis Tanpa Indikasi Medis, Episiotomi Rutin, Atau Operasi Caesar Elektif.

- c. **Progres Persalinan Yang Optimal**, Yang Dinilai Melalui Pemantauan Ketat Dan Akurat Menggunakan Alat Bantu Seperti Partograf.
- d. **Kompetensi Interpersonal Bidan**, Seperti Keterampilan Komunikasi, Empati, Dan Kemampuan Memberikan Edukasi Yang Jelas Serta Menenangkan Ibu Dan Keluarga.
- e. **Kesejahteraan Ibu Dan Bayi**, Yang Meliputi Indikator Kesehatan Ibu Dan Bayi Segera Setelah Persalinan Seperti Apgar Score Bayi Yang Baik Dan Minimnya Komplikasi Maternal Seperti Perdarahan Postpartum.

Pemantauan Terhadap Indikator Ini Secara Berkala Penting Dilakukan Untuk Memastikan Bahwa Praktik Kebidanan Terus Meningkatkan Kualitasnya Dan Memenuhi Ekspektasi Ibu Serta Standar Profesi Yang Berlaku.

## 2. Model Evaluasi Asuhan Persalinan Berbasis Evidence-Based Midwifery Practice (Ebmp)

Evidence-Based Midwifery Practice (Ebmp) Merupakan Pendekatan Klinis Yang Menekankan Pada Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti Ilmiah Terbaru Dalam Praktik Kebidanan. Forster Et Al. (2020) Menjelaskan Bahwa Evaluasi Asuhan Persalinan Berbasis Ebmp Menggunakan Pendekatan Sistematis Dengan Langkah-Langkah Berikut:

- a. **Audit Klinis Rutin** Yang Mengevaluasi Sejauh Mana Praktik Yang Dilakukan Bidan Sesuai Dengan Panduan Klinis Terbaru Dan Bukti Ilmiah Yang Ada.
- b. **Penggunaan Indikator Outcome Klinis** Seperti Angka Komplikasi Persalinan, Tingkat Kepuasan Ibu, Dan Angka Keberhasilan Pemberian Asi Segera Setelah Lahir Sebagai Parameter Penilaian.
- c. **Evaluasi Umpan Balik Dari Pasien Dan Keluarga**, Yang Memberikan Wawasan Mengenai Kualitas Interaksi Interpersonal Serta Persepsi Terhadap Pengalaman Persalinan.
- d. **Diskusi Reflektif Reguler Antar Profesional** Yang Bertujuan Mengidentifikasi Tantangan Praktik Sehari-Hari Dan Menemukan Solusi Berbasis Bukti Yang Optimal.

Model Evaluasi Berbasis Ebmp Ini Tidak Hanya Memastikan Bahwa Layanan Yang Diberikan Telah Memenuhi Standar Klinis, Tetapi Juga Menciptakan Budaya Praktik Kebidanan Yang Adaptif, Reflektif, Dan Selalu Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan Secara Terus-Menerus (Forster Et Al., 2020).

## 3. Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Peningkatan Kualitas Pendampingan Bidan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Monitoring Kualitas Pendampingan Yang Dilakukan, Beberapa Rekomendasi Tindak Lanjut Dapat Diterapkan Untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan Secara Berkelanjutan. Beberapa Rekomendasi Penting Antara Lain:

- a. **Penguatan Program Pendidikan Dan Pelatihan Berkelanjutan (Cpd)** Yang Difokuskan Pada Peningkatan Kompetensi Klinis, Interpersonal, Dan Kemampuan Praktik Kebidanan Berbasis Bukti. Program Cpd Secara Sistematis Terbukti Mampu Meningkatkan Kualitas Praktik Kebidanan Dan Kepercayaan Diri Bidan Dalam Pendampingan Persalinan (Hastuti & Nasution, 2021).
- b. **Implementasi Evaluasi Berbasis Observasi Langsung** Dengan Pemberian Feedback Secara Konsisten Dan Konstruktif Kepada Bidan, Yang Telah Terbukti Efektif Dalam Meningkatkan Kompetensi Klinis Dan Interpersonal (Setyorini Et Al., 2020).
- c. **Penguatan Kebijakan Institusional**, Termasuk Pengadaan Fasilitas Yang Mendukung Praktik Kebidanan Yang Aman Dan Nyaman Serta Penyusunan Protokol Klinis Yang Jelas Sesuai Standar Terbaru Berbasis Bukti Ilmiah (Harahap Et Al., 2021).
- d. **Edukasi Publik Yang Lebih Intensif Dan Sistematis** Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pendampingan Persalinan Oleh Bidan Profesional Serta Manfaat Persalinan Normal Dengan Intervensi Minimal (Kurniawati Et Al., 2021).

Dengan Implementasi Rekomendasi Ini, Diharapkan Pelayanan Pendampingan Persalinan Oleh Bidan Semakin Optimal, Yang Pada Akhirnya Akan Meningkatkan Kualitas Pengalaman Persalinan Serta Menurunkan Angka Morbiditas Dan Mortalitas Ibu Dan Bayi Di Indonesia.

## K. Penutup

---

Persalinan Normal Yang Aman Merupakan Tujuan Utama Dari Praktik Kebidanan Modern. Dalam Konteks Ini, Peran Pendampingan Oleh Bidan Selama Proses Persalinan Terbukti Sangat Krusial Dalam Menentukan Pengalaman Ibu Melahirkan Serta Outcome Klinis Yang Optimal Bagi Ibu Dan Bayi. Pendampingan Yang Efektif Mencakup Aspek-Aspek Holistik Seperti Dukungan Emosional Dan Psikologis, Penggunaan Teknik Fisik Dan Non-Farmakologis, Serta Partisipasi Aktif Keluarga Selama Persalinan. Berbagai Kajian Penelitian Terbaru Menegaskan Bahwa Implementasi Pendekatan Holistik Ini Berhubungan Langsung Dengan Peningkatan Kepuasan Ibu, Penurunan Tingkat Intervensi Medis Yang Tidak Perlu, Dan Keselamatan Ibu-Bayi Yang Lebih Baik Secara Keseluruhan (Beake Et Al., 2021; Levett Et Al., 2021).

Implementasi Prinsip Continuity Of Care Dalam Kebidanan Juga Telah Menjadi Fokus Perhatian Global Karena Terbukti Memberikan Dampak Signifikan Terhadap

Pengalaman Ibu Dan Hasil Persalinan. Meskipun Terdapat Berbagai Tantangan Dalam Penerapan Continuity Of Care Di Indonesia, Terutama Terkait Dengan Hambatan Geografis, Budaya, Dan Sumber Daya Manusia, Studi Menunjukkan Bahwa Pendekatan Ini Layak Diperjuangkan Melalui Edukasi Intensif Dan Dukungan Kebijakan Pemerintah Yang Komprehensif (Rayment-Jones Et Al., 2022; Sutcliffe Et Al., 2021). Di Samping Itu, Kemampuan Komunikasi Efektif Bidan Dan Pemberdayaan Keluarga Juga Menjadi Aspek Kunci Dalam Kesuksesan Penerapan Model Pendampingan Ini (Hidayati Et Al., 2022).

Pengembangan Kompetensi Profesional Bidan Secara Terus-Menerus (Continuous Professional Development – Cpd) Menjadi Strategi Esensial Dalam Meningkatkan Kualitas Pendampingan Persalinan. Cpd, Yang Meliputi Pelatihan Rutin, Simulasi Klinis, Evaluasi Observasional, Dan Feedback Langsung, Telah Terbukti Efektif Dalam Memperbarui Pengetahuan Dan Keterampilan Bidan Sesuai Dengan Bukti Ilmiah Terbaru. Strategi Ini Membantu Mengatasi Berbagai Hambatan Internal Maupun Eksternal Yang Dihadapi Oleh Bidan Dalam Praktik Sehari-Hari, Seperti Beban Kerja Yang Tinggi, Keterbatasan Fasilitas, Serta Tantangan Sosial Budaya Yang Kompleks (Hastuti & Nasution, 2021; Syafitri Et Al., 2021).

Untuk Menjaga Kualitas Pelayanan Kebidanan, Evaluasi Dan Monitoring Secara Berkala Dengan Indikator Yang Jelas Serta Berbasis Evidence-Based Midwifery Practice (Ebmp) Merupakan Langkah Penting Yang Harus Terus Diimplementasikan. Penggunaan Model Evaluasi Ini Tidak Hanya Memberikan Gambaran Yang Jelas Tentang Efektivitas Praktik Kebidanan, Tetapi Juga Membantu Bidan Secara Konsisten Meningkatkan Kualitas Pelayanannya Melalui Pendekatan Reflektif Dan Adaptif Terhadap Praktik Klinis (Forster Et Al., 2020; Handayani & Kusuma, 2020).

Akhirnya, Rekomendasi Penting Yang Perlu Terus Dikembangkan Mencakup Peningkatan Kapasitas Profesional Bidan Melalui Pelatihan Berbasis Bukti, Penguatan Kebijakan Institusional, Dan Edukasi Masyarakat Yang Berkelanjutan. Upaya Ini Diharapkan Dapat Menciptakan Lingkungan Pelayanan Kebidanan Yang Aman, Berkualitas Tinggi, Dan Berorientasi Pada Kesejahteraan Ibu Dan Bayi Secara Komprehensif. Dengan Implementasi Yang Konsisten Dan Terintegrasi, Peran Bidan Dalam Persalinan Normal Yang Aman Akan Semakin Diakui Dan Dihargai Oleh Masyarakat Luas Serta Menjadi Bagian Integral Dari Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional Indonesia.

## Referensi

- Azizah, N., Ismail, R., & Nurhasanah, S. (2020). Pengaruh penggunaan partograf terhadap deteksi dini komplikasi persalinan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 156-163.
- Beake, S., Bick, D., Narracott, C., & Chang, Y. S. (2021). Holistic approaches to managing labour pain: a systematic review. *Midwifery*, 92, 102865.
- Beecher, C., Devane, D., White, M., & Greene, R. (2021). Communication strategies for midwives during labor and birth. *Journal of Clinical Nursing*, 30(9–10), 1369–1378.
- Fenwick, J., Sidebotham, M., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2020). Continuity of midwifery care: A systematic review. *Women and Birth*, 33(5), 411-418.
- Forster, D. A., McLachlan, H. L., Davey, M. A., & Newton, M. (2020). Evaluating midwifery practice through evidence-based clinical audits: a systematic approach. *Midwifery*, 85, 102678.
- Handayani, R., & Kusuma, M. A. (2020). Indikator kualitas pendampingan dalam pelayanan kebidanan persalinan normal. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(3), 160-167.
- Handelzalts, J. E., Krissi, H., Levy, S., Freund, Y., & Peled, Y. (2020). Maternal anxiety, fear of childbirth, and birth outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 780.
- Harahap, D. E., Sari, D. A., & Lestari, R. (2021). Pengaruh pelatihan simulasi terhadap peningkatan keterampilan klinis bidan dalam penatalaksanaan persalinan normal. *Journal of Midwifery Education and Practice*, 4(2), 110-118.
- Hastuti, E., & Nasution, N. H. (2021). Pengembangan kompetensi bidan melalui continuous professional development (CPD). *Journal of Indonesian Midwifery and Health Sciences*, 5(2), 88-95.
- Hidayati, L., Kurniawati, T., & Susanti, E. (2022). Komunikasi efektif bidan dalam meningkatkan partisipasi keluarga selama persalinan. *Journal of Midwifery Research*, 5(1), 41-49.
- Hunter, A., Devane, D., & Houghton, C. (2021). Enhancing midwives' confidence in non-pharmacological pain relief strategies. *Women and Birth*, 34(5), e482-e490.
- Kurniawati, S., Saputri, E., & Nugroho, W. (2021). Pendekatan komunitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan persalinan berbasis bidan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 110-117.
- Lawrence, A., Lewis, L., Hofmeyr, G. J., & Styles, C. (2020). Maternal positions and mobility during first stage labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 5.

- Levett, K. M., Smith, C. A., & Bensoussan, A. (2021). Non-pharmacological interventions for pain management in labour: A systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 6.
- Madden, K. L., Turnbull, D., Cyna, A. M., Adelson, P., & Wilkinson, C. (2021). The effectiveness of combined pharmacological and non-pharmacological pain relief methods during labour. *Birth*, 48(3), 391-401.
- Nilsson, C., Hessman, E., Sjöblom, H., Dencker, A., & Jangsten, E. (2020). Impact of midwives' emotional support on birth outcomes. *European Journal of Midwifery*, 4(4), 1-9.
- Nugraheni, D. R., Saputra, Y., & Handayani, L. (2020). Hambatan budaya dan sosial dalam pendampingan persalinan oleh bidan di Indonesia. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 5(1), 45-52.
- Pratiwi, R., & Purwandari, E. (2021). Peran keluarga dalam proses persalinan: Studi eksplorasi budaya. *Jurnal Sosial Budaya Kesehatan*, 8(2), 77-85.
- Rahmawati, D., Dewi, A. K., & Handayani, R. (2020). Pengaruh dukungan keluarga terhadap stres ibu selama persalinan. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 5(1), 33-40.
- Rahayu, I., & Irawaty, D. (2022). Indikator klinis pemantauan persalinan fisiologis di pelayanan primer. *Journal of Midwifery Science*, 6(2), 121-129.
- Rayment-Jones, H., Harris, J., Harden, A., & Sandall, J. (2022). Midwifery continuity of care and experiences of childbirth: a systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 3.
- Rohmah, A. L., & Supriyadi, S. (2022). Strategi implementasi praktik kebidanan berbasis bukti di fasilitas kesehatan primer. *Midwifery Journal of Indonesia*, 4(1), 40-48.
- Setyorini, A., Ambarwati, E. R., & Hapsari, E. D. (2020). Evaluasi kompetensi klinis bidan melalui observasi praktik klinik dan feedback langsung. *Journal of Midwifery Research*, 3(2), 67-73.
- Sutarmi, S., & Prabandari, Y. S. (2021). Efektivitas penggunaan partograf dalam meningkatkan mutu pelayanan persalinan. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 15(1), 1-10.
- Sutcliffe, K., Caird, J., & Rees, R. (2021). Continuity of midwife care and maternal outcomes: a meta-analysis. *Lancet Global Health*, 9(1), e12-e13.
- Syafitri, R., Kusumawati, A., & Lestari, A. (2021). Hambatan internal dan eksternal dalam pendampingan persalinan normal. *Indonesian Journal of Midwifery Science*, 5(2), 75-82.
- Toohill, J., Fenwick, J., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2021). Reducing childbirth fear and anxiety using psychoeducation: A randomized controlled trial. *Birth*, 48(2), 207-217.



- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2020). *Pedoman Evaluasi Praktik Kebidanan Berbasis Bukti*. Jakarta: PP IBI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Setyowati, S., Prabandari, Y. S., & Astuti, E. D. (2020). *Asuhan Kebidanan Berbasis Budaya di Indonesia: Strategi Integrasi Budaya Lokal dalam Praktik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sulistyawati, S., Purwandari, E., & Hapsari, D. (2020). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Berbasis Komunitas dan Kontinuitas Asuhan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO Press.

# BAB III

## TEKNIK RELAKSASI UNTUK MENDUKUNG PERSALINAN NORMAL

---

### A. Pendahuluan

---

Persalinan merupakan proses fisiologis yang melibatkan serangkaian perubahan fisik dan emosional yang kompleks pada ibu hamil. Pada proses ini, nyeri dan stres merupakan kondisi umum yang sering dialami ibu bersalin, yang apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat kemajuan persalinan serta meningkatkan risiko intervensi medis yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penerapan teknik relaksasi sebagai pendekatan non-farmakologis semakin direkomendasikan guna mengurangi nyeri dan stres selama persalinan normal (Oktaviani & Kurniawati, 2021; Akgün et al., 2020).

Relaksasi dalam persalinan berperan penting dalam memodulasi respons tubuh terhadap nyeri dan stres. Secara fisiologis, teknik relaksasi mampu menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan kerja sistem saraf parasimpatis, yang ditandai dengan penurunan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, serta laju pernapasan (Safitri & Handayani, 2021; Khavandizadeh et al., 2022). Selain itu, relaksasi turut memicu produksi hormon oksitosin dan endorfin yang memiliki peran utama dalam meningkatkan kontraksi rahim secara efektif sekaligus mengurangi persepsi nyeri. Efek fisiologis ini secara nyata membantu memperlancar proses persalinan normal dan mempersingkat durasi persalinan (Riyanti et al., 2023).

Dari perspektif psikologis, relaksasi membantu ibu hamil dalam mengelola kecemasan, ketakutan, dan stres emosional yang umum terjadi selama persalinan. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, hypnobirthing, aromaterapi, dan musik relaksasi, terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan serta meningkatkan rasa percaya diri ibu hamil dalam menghadapi persalinan (Wardani & Sugiarti, 2020; Lubis et al., 2020; Mulyani & Dewi, 2021). Dengan kondisi psikologis yang lebih tenang dan terkendali, ibu mampu menghadapi proses persalinan dengan lebih baik, sehingga mampu mendukung tercapainya persalinan normal yang aman dan nyaman.

Secara keseluruhan, integrasi teknik relaksasi dalam praktik kebidanan tidak hanya menawarkan solusi praktis dalam pengelolaan nyeri dan stres selama persalinan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dari aspek fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta keterampilan bidan

dalam mengaplikasikan berbagai teknik relaksasi secara efektif sangat diperlukan guna mencapai hasil persalinan optimal serta pengalaman persalinan yang positif bagi ibu (Handayani & Wahyuningsih, 2021; Abdulaziz et al., 2022).

## **B. Konsep Dasar Teknik Relaksasi dalam Persalinan**

---

### **1. Definisi dan Prinsip Dasar Teknik Relaksasi dalam Konteks Kebidanan**

Teknik relaksasi dalam kebidanan didefinisikan sebagai berbagai metode non-farmakologis yang digunakan untuk mengurangi nyeri, stres, dan kecemasan ibu selama proses persalinan dengan tujuan menciptakan kondisi nyaman dan aman bagi ibu dan bayi (Akgün et al., 2020). Relaksasi bertujuan membantu ibu bersalin mencapai kondisi tubuh dan pikiran yang tenang serta rileks, sehingga mempermudah kontraksi rahim dan memperlancar proses persalinan normal (Oktaviani & Kurniawati, 2021). Secara prinsip, teknik relaksasi bekerja dengan menstimulasi sistem saraf parasimpatis yang berfungsi mengurangi aktivitas stres dalam tubuh, sehingga menghasilkan efek menenangkan, mengurangi rasa sakit, dan memperlancar proses fisiologis persalinan.

Beberapa prinsip utama dalam penerapan teknik relaksasi meliputi fokus pada pernapasan yang dalam dan teratur, penggunaan sugesti positif, visualisasi positif, pelepasan otot secara progresif, serta menciptakan lingkungan persalinan yang kondusif dan tenang (Lubis et al., 2020; Safitri & Handayani, 2021). Teknik-teknik ini harus diterapkan secara individual, disesuaikan dengan kondisi ibu dan tahap persalinan yang sedang berlangsung agar dapat memberikan hasil yang optimal (Sanjaya et al., 2021).

### **2. Hubungan antara Respon Stres, Hormon Oksitosin, dan Endorfin dalam Proses Persalinan**

Proses persalinan dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi kompleks antara respon stres tubuh dengan hormon oksitosin dan endorfin. Ketika ibu mengalami stres yang tinggi selama persalinan, tubuh merespon dengan meningkatkan produksi hormon kortisol dan adrenalin yang dapat menghambat pelepasan oksitosin alami, hormon utama yang memicu kontraksi rahim yang efektif dan lancarnya persalinan (Özkan & Arslan, 2022). Sebaliknya, ketika ibu dalam kondisi rileks, tubuh akan secara alami meningkatkan produksi oksitosin dan endorfin.

Oksitosin tidak hanya berperan penting dalam memicu kontraksi uterus yang kuat dan teratur, tetapi juga berkontribusi pada rasa tenang dan ikatan emosional antara ibu dan bayi setelah persalinan (Handayani & Wahyuningsih, 2021). Hormon endorfin yang dilepaskan selama kondisi relaksasi bertindak

sebagai analgesik alami yang efektif meredakan rasa nyeri selama persalinan, menciptakan rasa nyaman dan membantu ibu menjalani persalinan dengan lebih tenang (Wardani & Sugiarti, 2020).

### 3. Manfaat Relaksasi terhadap Kelancaran Persalinan Normal

Penggunaan teknik relaksasi secara efektif telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan terhadap kelancaran persalinan normal. Studi yang dilakukan oleh Khavandizadeh et al. (2022) menemukan bahwa ibu yang menggunakan teknik relaksasi selama persalinan mengalami penurunan intensitas nyeri, durasi persalinan yang lebih pendek, serta berkurangnya kebutuhan terhadap intervensi medis seperti induksi atau operasi sesar.

Selain itu, penelitian oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu yang rutin mempraktikkan teknik relaksasi menjelang persalinan melaporkan tingkat kecemasan dan stres yang lebih rendah selama proses persalinan. Kondisi psikologis yang lebih tenang ini membantu ibu untuk lebih kooperatif selama persalinan, sehingga proses kelahiran berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, teknik relaksasi sangat direkomendasikan sebagai intervensi non-farmakologis untuk mendukung persalinan normal yang lebih positif bagi ibu maupun bayi.

## **C. Jenis-jenis Teknik Relaksasi dalam Persalinan Normal**

---

Dalam upaya mendukung persalinan normal yang lancar dan aman, bidan dapat menerapkan berbagai teknik relaksasi non-farmakologis yang terbukti efektif dalam mengurangi rasa nyeri, stres, serta kecemasan yang dialami ibu bersalin. Teknik relaksasi ini meliputi metode pernapasan, relaksasi otot progresif, hypnobirthing, aromaterapi, dan terapi musik. Berikut penjelasan lengkap dari berbagai teknik relaksasi tersebut:

### 1. Teknik Pernapasan

Teknik pernapasan merupakan metode relaksasi paling umum yang diterapkan selama persalinan. Teknik ini meliputi berbagai variasi, seperti pernapasan dalam (deep breathing), pernapasan perut (abdominal breathing), dan pernapasan berpola (patterned breathing). Pernapasan dalam bertujuan untuk memperlambat ritme pernapasan ibu sehingga memicu respons relaksasi tubuh, membantu mengurangi stres, dan menurunkan intensitas nyeri (Safitri & Handayani, 2021). Sementara pernapasan perut membantu memaksimalkan suplai oksigen ke otot rahim, mengurangi ketegangan otot, dan memfasilitasi kontraksi rahim yang efektif (Riyanti et al., 2023). Pernapasan berpola (patterned

breathing) umumnya diajarkan melalui pola tertentu untuk membantu ibu mengalihkan perhatian dari nyeri dan menjaga fokus selama proses persalinan.

## 2. Teknik Relaksasi Otot Progresif (Progressive Muscle Relaxation/PMR)

Teknik relaksasi otot progresif (PMR) dilakukan dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot secara bertahap di seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki atau sebaliknya. Prosedur ini bertujuan meningkatkan kesadaran tubuh terhadap ketegangan otot sehingga ibu dapat secara sadar melepas ketegangan tersebut, menciptakan perasaan nyaman dan tenang (Sanjaya et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa penerapan PMR selama persalinan mampu secara signifikan menurunkan intensitas nyeri serta memperpendek durasi persalinan, karena kondisi tubuh ibu menjadi lebih rileks dan siap menghadapi kontraksi persalinan secara optimal (Akgün et al., 2020).

## 3. Hypnobirthing sebagai Metode Relaksasi Berbasis Sugesti Positif dan Visualisasi

Hypnobirthing merupakan metode relaksasi yang menggunakan teknik sugesti positif, afirmasi, serta visualisasi untuk mengatasi rasa takut, cemas, dan nyeri selama persalinan. Teknik ini membantu ibu memasuki kondisi relaksasi mendalam melalui meditasi, relaksasi mental, dan visualisasi yang positif terkait proses persalinan (Wardani & Sugiarti, 2020). Penelitian oleh Dahlen et al. (2022) menunjukkan bahwa ibu yang menggunakan hypnobirthing memiliki tingkat nyeri yang lebih rendah, merasa lebih percaya diri, serta mengalami persalinan yang lebih singkat dan lancar dibandingkan ibu yang tidak menerapkan teknik tersebut.

## 4. Aromaterapi dalam Menunjang Relaksasi dan Pengurangan Nyeri Selama Persalinan

Aromaterapi merupakan teknik relaksasi yang menggunakan minyak esensial alami dari tanaman untuk merangsang respons relaksasi serta menurunkan tingkat kecemasan dan rasa nyeri pada ibu bersalin. Minyak esensial seperti lavender, peppermint, mawar, dan jasmine telah terbukti secara klinis mampu menurunkan intensitas nyeri serta meningkatkan kenyamanan selama proses persalinan (Mulyani & Dewi, 2021). Mekanisme aromaterapi bekerja melalui stimulasi saraf penciuman yang langsung mengaktifkan sistem limbik di otak, yang bertanggung jawab atas regulasi emosi, suasana hati, serta persepsi nyeri, sehingga menciptakan efek relaksasi dan kenyamanan yang optimal selama persalinan (Khavandizadeh et al., 2022).

## 5. Musik Relaksasi sebagai Metode Non-farmakologis dalam Mengelola Nyeri Persalinan

Musik relaksasi digunakan sebagai metode sederhana dan efektif untuk mengurangi kecemasan serta nyeri selama persalinan. Musik mampu merangsang pelepasan hormon endorfin, menciptakan efek menenangkan, serta mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri yang dialaminya (Lubis et al., 2020). Studi menemukan bahwa ibu yang mendengarkan musik relaksasi selama persalinan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, persepsi nyeri yang berkurang, serta proses persalinan yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan terapi musik (Sari et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan teknik-teknik relaksasi di atas menjadi pendekatan penting dalam kebidanan yang mendukung persalinan normal secara aman, nyaman, dan efektif. Bidan diharapkan dapat memahami dan menguasai berbagai teknik ini agar mampu memberikan dukungan optimal kepada ibu bersalin.

### **D. Implementasi Teknik Relaksasi dalam Praktik Kebidanan**

---

Implementasi teknik relaksasi dalam praktik kebidanan merupakan bagian penting dari asuhan persalinan yang berorientasi pada kenyamanan, keamanan, dan keberhasilan proses persalinan normal. Dalam hal ini, bidan memiliki peran sentral mulai dari tahap edukasi hingga pelaksanaan relaksasi di ruang persalinan. Selain itu, kolaborasi tim kebidanan yang efektif turut mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif, yang menjadi kunci utama keberhasilan teknik relaksasi.

#### 1. Peran Bidan dalam Edukasi Teknik Relaksasi kepada Ibu Hamil

Bidan memiliki tanggung jawab utama dalam mengedukasi ibu hamil mengenai berbagai teknik relaksasi yang dapat diterapkan selama proses persalinan. Edukasi ini sebaiknya dilakukan sejak masa antenatal, sehingga ibu dapat berlatih teknik relaksasi secara rutin sebelum persalinan tiba. Studi yang dilakukan oleh Handayani dan Wahyuningsih (2021) menunjukkan bahwa edukasi yang tepat dan terencana mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan ibu dalam menerapkan teknik relaksasi, sehingga membantu ibu lebih siap secara mental maupun fisik saat menghadapi persalinan.

Dalam edukasi tersebut, bidan memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat teknik relaksasi, jenis-jenis metode yang bisa dipilih sesuai kebutuhan individu ibu, serta cara praktiknya secara mandiri di rumah. Edukasi ini tidak hanya dilakukan melalui konseling secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media edukasi digital seperti video tutorial dan leaflet yang informatif, sehingga

ibu hamil lebih termotivasi dan mampu melakukan teknik tersebut dengan benar (Pratiwi et al., 2020).

## 2. Strategi Bidan dalam Penerapan Teknik Relaksasi Selama Persalinan Aktif

Pada tahap persalinan aktif, strategi penerapan teknik relaksasi oleh bidan berfokus pada mendampingi ibu bersalin dalam menerapkan teknik secara efektif untuk mengurangi rasa nyeri dan stres yang dialami. Strategi utama mencakup penggunaan komunikasi yang lembut, jelas, dan mendukung; membimbing ibu untuk tetap fokus melalui pola pernapasan yang teratur; serta memberikan afirmasi positif yang membantu ibu merasa tenang, percaya diri, dan rileks selama persalinan (Abdulaziz et al., 2022).

Selain itu, bidan dapat menerapkan teknik sentuhan terapeutik seperti pijatan lembut atau pressure point massage, serta membantu ibu bersalin mengatur posisi tubuh yang nyaman untuk mengurangi nyeri kontraksi. Keberhasilan implementasi teknik relaksasi juga bergantung pada pemahaman bidan terhadap kondisi psikologis dan fisik ibu, sehingga teknik yang diterapkan dapat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan respons tubuh ibu saat itu (Riyanti et al., 2023).

## 3. Kolaborasi Tim Kebidanan dalam Menyediakan Lingkungan Kondusif untuk Relaksasi

Penciptaan lingkungan yang kondusif untuk relaksasi memerlukan kolaborasi yang efektif di antara anggota tim kebidanan yang mencakup bidan, perawat, dokter, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya. Lingkungannya harus memenuhi aspek fisik, psikologis, serta emosional ibu, seperti suasana ruangan yang tenang, pencahayaan yang lembut, suhu ruangan yang nyaman, serta tersedianya fasilitas pendukung seperti bola persalinan, matras, aromaterapi, dan musik relaksasi (Pratiwi et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tim yang baik secara signifikan meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan, mengurangi rasa nyeri, dan memperpendek durasi persalinan karena kondisi relaksasi ibu terjaga dengan optimal (Sanjaya et al., 2021). Pentingnya komunikasi antar profesional dalam tim kebidanan serta kesiapan tim dalam merespon kebutuhan ibu secara cepat juga menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi teknik relaksasi berhasil dengan maksimal.

Dengan demikian, implementasi teknik relaksasi dalam praktik kebidanan merupakan bagian integral dari asuhan persalinan yang holistik dan humanistik. Kesuksesannya bergantung pada peran aktif bidan dalam edukasi sejak masa

antenatal, strategi efektif selama persalinan aktif, serta kolaborasi tim kebidanan yang solid dalam menciptakan lingkungan persalinan yang nyaman dan mendukung relaksasi.

#### **E. Efektivitas Teknik Relaksasi dalam Menurunkan Nyeri Persalinan**

---

Nyeri merupakan pengalaman yang umum dirasakan oleh setiap ibu yang menjalani proses persalinan. Pengelolaan nyeri secara efektif menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan persalinan normal. Berbagai teknik relaksasi non-farmakologis telah banyak diteliti efektivitasnya dalam mengurangi intensitas nyeri persalinan, termasuk teknik pernapasan, hypnobirthing, aromaterapi, serta musik relaksasi.

##### **1. Tinjauan Studi tentang Efektivitas Pernapasan dalam Mengurangi Intensitas Nyeri Persalinan**

Teknik pernapasan merupakan metode relaksasi sederhana yang paling sering digunakan oleh ibu bersalin. Studi terbaru oleh Safitri dan Handayani (2021) menunjukkan bahwa teknik pernapasan dalam (deep breathing) dan pernapasan perut (abdominal breathing) secara signifikan menurunkan persepsi nyeri persalinan pada ibu yang menerapkannya secara konsisten. Mekanisme utama teknik ini adalah melalui peningkatan suplai oksigen ke jaringan tubuh, terutama otot rahim, serta menstimulasi respons sistem saraf parasimpatis yang menghasilkan relaksasi dan penurunan tingkat stres (Riyanti et al., 2023).

Efektivitas teknik pernapasan juga terbukti mampu membantu ibu dalam mengontrol rasa nyeri sehingga mengurangi kecemasan selama persalinan. Penggunaan teknik pernapasan berpola juga membantu ibu mengalihkan perhatian dari rasa nyeri, menciptakan fokus yang positif selama kontraksi rahim, serta membantu ibu merasa lebih nyaman dan percaya diri menghadapi persalinan (Safitri & Handayani, 2021).

##### **2. Dampak Hypnobirthing terhadap Penurunan Nyeri dan Durasi Persalinan**

Hypnobirthing telah dikenal luas sebagai metode relaksasi berbasis sugesti positif dan visualisasi. Studi yang dilakukan oleh Wardani dan Sugiarti (2020) mengungkapkan bahwa ibu yang menerapkan hypnobirthing mengalami penurunan signifikan dalam tingkat nyeri dan kecemasan, serta memiliki durasi persalinan yang lebih singkat dibandingkan ibu yang tidak menggunakan metode tersebut. Temuan ini diperkuat oleh penelitian sistematis oleh Dahlen et al. (2022) yang menyatakan bahwa hypnobirthing secara konsisten membantu ibu memasuki keadaan relaksasi mendalam, yang berdampak pada peningkatan



produksi hormon oksitosin serta endorfin yang membantu mengurangi persepsi nyeri.

Hypnobirthing juga menciptakan kondisi psikologis yang stabil, tenang, dan positif bagi ibu selama persalinan. Hal ini pada akhirnya turut memperlancar proses persalinan dan mengurangi kebutuhan terhadap intervensi medis tambahan (Dahlen et al., 2022).

### 3. Efek Aromaterapi terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan

Aromaterapi merupakan pendekatan relaksasi yang menggunakan minyak esensial alami untuk merangsang respon relaksasi dan mengurangi nyeri. Studi oleh Mulyani dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa pemberian aromaterapi seperti minyak esensial lavender, peppermint, dan jasmine mampu menurunkan intensitas nyeri persalinan secara signifikan. Aromaterapi bekerja melalui stimulasi sistem limbik otak, yang memodulasi emosi, stres, serta persepsi rasa nyeri, sehingga menghasilkan sensasi nyaman dan relaksasi mendalam selama kontraksi persalinan.

Selain itu, aromaterapi juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu, yang berhubungan langsung dengan penurunan nyeri serta kelancaran proses persalinan secara keseluruhan (Khavandizadeh et al., 2022).

### 4. Efektivitas Musik Relaksasi terhadap Kecemasan dan Rasa Nyeri

Musik relaksasi merupakan metode sederhana dan efektif untuk mengurangi kecemasan serta rasa nyeri pada ibu bersalin. Lubis et al. (2020) dalam studinya menemukan bahwa ibu yang mendengarkan musik relaksasi selama persalinan melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Mekanisme kerja musik relaksasi dikaitkan dengan pelepasan hormon endorfin dan penurunan hormon stres seperti kortisol, yang membantu ibu merasa lebih tenang dan nyaman.

Penelitian ini juga mencatat bahwa penggunaan musik relaksasi turut membantu memperpendek durasi persalinan, dengan menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan positif bagi ibu (Lubis et al., 2020; Sari et al., 2020).

Secara keseluruhan, berbagai studi terkini mendukung bahwa teknik relaksasi seperti pernapasan, hypnobirthing, aromaterapi, dan musik relaksasi merupakan metode efektif dan penting dalam manajemen nyeri persalinan. Penerapan yang tepat dari teknik-teknik ini oleh bidan dalam praktik kebidanan dapat membantu ibu menjalani proses persalinan dengan lebih nyaman, tenang, serta meminimalisir intervensi medis yang tidak diperlukan.

## **F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Teknik Relaksasi**

---

Keberhasilan penerapan teknik relaksasi dalam persalinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan penerapan teknik relaksasi secara optimal dalam praktik kebidanan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek psikologis ibu hamil, dukungan sosial dari pasangan dan keluarga, serta kesiapan bidan dan tim kesehatan dalam memberikan dukungan selama proses persalinan.

### **1. Faktor Psikologis Ibu Hamil: Kecemasan dan Self-Efficacy**

Faktor psikologis memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat efektivitas teknik relaksasi selama persalinan. Salah satu faktor psikologis utama adalah tingkat kecemasan yang dialami ibu. Penelitian oleh Özkan dan Arslan (2022) menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam merasakan manfaat penuh dari teknik relaksasi, karena kecemasan berlebih dapat mengganggu kemampuan ibu untuk fokus dan menerapkan metode secara efektif. Sebaliknya, ibu yang mampu mengelola kecemasan dengan baik melalui persiapan mental sejak masa antenatal memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menerapkan teknik relaksasi selama proses persalinan.

Selain kecemasan, self-efficacy atau keyakinan diri ibu terhadap kemampuannya dalam menghadapi persalinan juga menjadi penentu penting keberhasilan teknik relaksasi. Ibu dengan self-efficacy tinggi cenderung lebih optimis, tenang, serta mampu secara efektif menggunakan teknik relaksasi untuk mengontrol nyeri dan rasa tidak nyaman selama proses persalinan (Özkan & Arslan, 2022; Riyanti et al., 2023).

### **2. Dukungan Sosial dan Peran Pasangan dalam Memfasilitasi Relaksasi**

Dukungan sosial, khususnya dari pasangan atau anggota keluarga terdekat, juga berpengaruh besar terhadap efektivitas penerapan teknik relaksasi selama persalinan. Kehadiran dan dukungan pasangan terbukti meningkatkan rasa aman, nyaman, dan percaya diri ibu saat menjalani persalinan (Khavandizadeh et al., 2022). Pasangan yang aktif terlibat dalam mendukung teknik relaksasi, seperti membantu ibu dalam menerapkan teknik pernapasan atau memberikan sentuhan fisik yang menenangkan, secara nyata mampu memperkuat efektivitas relaksasi dalam mengurangi nyeri dan kecemasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khavandizadeh et al. (2022) menemukan bahwa ibu yang mendapat dukungan emosional, fisik, maupun psikologis dari pasangan atau pendamping mengalami tingkat nyeri persalinan yang lebih rendah, durasi persalinan yang lebih singkat, serta pengalaman persalinan yang

lebih positif secara keseluruhan dibandingkan ibu yang kurang mendapatkan dukungan.

### 3. Kesiapan Bidan dan Tim Kesehatan dalam Memberikan Dukungan Relaksasi

Kesiapan serta kompetensi bidan dan tim kesehatan dalam menerapkan teknik relaksasi juga sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Bidan yang terampil, terlatih, dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai berbagai metode relaksasi cenderung lebih mampu memberikan dukungan yang optimal kepada ibu selama persalinan (Pratiwi et al., 2020). Kesiapan ini meliputi kemampuan komunikasi yang efektif, pemahaman mendalam tentang kebutuhan psikologis ibu, serta keterampilan praktis dalam membimbing teknik relaksasi yang sesuai dengan kondisi ibu.

Selain keterampilan individu bidan, kesiapan tim kesehatan secara kolektif turut memainkan peran penting. Lingkungan persalinan yang kondusif dan dukungan tim yang responsif terhadap kebutuhan ibu secara signifikan meningkatkan efektivitas relaksasi dalam mengurangi nyeri dan stres persalinan (Pratiwi et al., 2020; Handayani & Wahyuningsih, 2021).

Secara keseluruhan, efektivitas teknik relaksasi dalam persalinan sangat bergantung pada kombinasi faktor internal seperti kondisi psikologis ibu, faktor eksternal seperti dukungan sosial pasangan, serta kesiapan tim kebidanan yang mendukung secara optimal. Pemahaman dan pengelolaan terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas asuhan persalinan berbasis teknik relaksasi.

## **G. Tantangan dalam Implementasi Teknik Relaksasi di Praktik Klinik**

---

Implementasi teknik relaksasi sebagai bagian dari asuhan persalinan normal menghadapi berbagai tantangan di praktik klinik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi efektivitas penerapan teknik relaksasi dalam mendukung persalinan yang aman, nyaman, dan minim intervensi medis. Dengan mengenali tantangan ini, bidan dan institusi kesehatan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan kualitas pelayanan kebidanan.

### 1. Hambatan Internal: Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Bidan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan teknik relaksasi di praktik klinik adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan bidan yang masih bervariasi. Studi oleh Abdulaziz et al. (2022) menunjukkan bahwa tidak semua bidan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai tentang berbagai teknik relaksasi yang dapat digunakan selama persalinan. Hal ini disebabkan kurangnya

pelatihan formal dan edukasi berkelanjutan bagi bidan terkait teknik-teknik non-farmakologis, sehingga banyak bidan merasa kurang percaya diri untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Kurangnya keterampilan tersebut berdampak pada rendahnya motivasi bidan dalam mengaplikasikan teknik relaksasi secara efektif. Selain itu, minimnya pengalaman bidan dalam menggunakan metode seperti hypnobirthing, relaksasi otot progresif, atau aromaterapi juga menjadi faktor penghambat implementasi yang optimal di lapangan (Sanjaya et al., 2021). Untuk mengatasi hambatan ini, institusi pelayanan kesehatan perlu secara rutin mengadakan pelatihan serta workshop yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri bidan dalam menerapkan teknik relaksasi secara optimal selama persalinan.

## 2. Hambatan Eksternal: Fasilitas yang Kurang Memadai dan Dukungan Institusional

Selain hambatan internal, tantangan eksternal berupa keterbatasan fasilitas dan dukungan institusional juga menjadi kendala besar dalam implementasi teknik relaksasi di klinik. Studi oleh Handayani dan Wahyuningsih (2021) mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti ruang persalinan yang nyaman, ketersediaan peralatan pendukung seperti bola persalinan (birthing ball), matras, aromaterapi, musik relaksasi, serta pencahayaan yang kondusif masih seringkali kurang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Kurangnya fasilitas ini mengakibatkan ibu sulit mencapai kondisi relaksasi optimal selama proses persalinan.

Di sisi lain, minimnya dukungan institusional seperti kebijakan dan prosedur operasional yang jelas tentang penggunaan teknik relaksasi dalam protokol persalinan juga menjadi hambatan yang signifikan. Dukungan yang lemah dari institusi terhadap implementasi praktik berbasis bukti menyebabkan bidan enggan atau kurang termotivasi menerapkan teknik-teknik relaksasi yang dianggap belum menjadi standar pelayanan yang baku di institusi tempat mereka bekerja (Pratiwi et al., 2020).

## 3. Strategi Mengatasi Tantangan dalam Implementasi Teknik Relaksasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengadaan fasilitas yang memadai, serta penguatan dukungan institusional. Institusi kesehatan harus menyusun kebijakan yang jelas tentang integrasi teknik relaksasi sebagai standar praktik kebidanan. Pengembangan fasilitas fisik seperti ruang persalinan yang nyaman dengan fasilitas relaksasi memadai, serta pelatihan rutin bagi bidan harus menjadi prioritas utama (Handayani & Wahyuningsih, 2021; Abdulaziz et al., 2022).

Selain itu, pentingnya penguatan budaya kerja interprofesional di antara tim kebidanan dapat membantu terciptanya dukungan yang lebih kuat terhadap penerapan teknik relaksasi. Dengan sinergi ini, implementasi teknik relaksasi dalam praktik klinik dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi ibu dan bayi selama persalinan (Pratiwi et al., 2020).

Dengan mengenali serta mengatasi hambatan-hambatan ini secara sistematis, diharapkan penerapan teknik relaksasi di klinik kebidanan dapat lebih optimal, efektif, dan memberikan dampak positif bagi pengalaman persalinan ibu secara menyeluruh.

## **H. Evaluasi Keberhasilan Teknik Relaksasi dalam Persalinan Normal**

---

Evaluasi keberhasilan teknik relaksasi dalam persalinan normal sangat penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana intervensi non-farmakologis ini memberikan dampak positif terhadap proses persalinan. Evaluasi tersebut bertujuan agar bidan dan tenaga kesehatan dapat secara objektif menilai efektivitas implementasi teknik relaksasi serta meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara keseluruhan. Dalam mengevaluasi keberhasilan teknik relaksasi, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan serta pendekatan evaluasi berbasis bukti yang direkomendasikan.

### **1. Indikator Keberhasilan Teknik Relaksasi**

Beberapa indikator penting yang digunakan dalam menilai efektivitas teknik relaksasi selama persalinan normal meliputi durasi persalinan, intensitas nyeri, serta tingkat kecemasan ibu bersalin (Lubis et al., 2020; Riyanti et al., 2023). Indikator ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama penerapan relaksasi yaitu mengurangi nyeri, memperlancar proses persalinan, serta menciptakan kondisi psikologis yang nyaman bagi ibu bersalin.

- a. **Durasi persalinan** menjadi indikator penting karena waktu persalinan yang lebih singkat umumnya menunjukkan bahwa ibu berada dalam kondisi fisik dan mental yang lebih baik, sehingga persalinan berlangsung lancar tanpa hambatan psikologis maupun fisiologis. Penelitian oleh Riyanti et al. (2023) menunjukkan bahwa ibu yang menerapkan teknik pernapasan secara teratur mengalami durasi persalinan yang lebih pendek dibandingkan dengan ibu yang tidak menerapkan teknik tersebut.
- b. **Intensitas nyeri** merupakan indikator utama lainnya yang mencerminkan efektivitas teknik relaksasi. Studi oleh Lubis et al. (2020) menemukan bahwa ibu yang diberikan intervensi berupa musik relaksasi melaporkan penurunan intensitas nyeri secara signifikan dibandingkan ibu yang menjalani persalinan tanpa intervensi relaksasi. Penurunan nyeri ini diukur melalui skala nyeri yang

valid seperti Visual Analog Scale (VAS), Numeric Rating Scale (NRS), atau Faces Pain Scale (FPS).

- c. **Tingkat kecemasan** juga menjadi indikator kunci dalam evaluasi ini. Ibu yang mengalami tingkat kecemasan rendah selama persalinan umumnya lebih mampu mengelola nyeri, bekerja sama dengan tenaga kesehatan, dan lebih efektif menggunakan teknik relaksasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik relaksasi efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan ibu bersalin, yang diukur menggunakan instrumen standar seperti Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) atau State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Lubis et al., 2020).

## 2. Metode Evaluasi Berbasis Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Evaluasi keberhasilan teknik relaksasi dalam persalinan sebaiknya dilakukan menggunakan pendekatan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP). EBMP adalah pendekatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru dengan keahlian klinis bidan serta nilai dan preferensi ibu yang menerima layanan kebidanan (Forster et al., 2020). Melalui EBMP, bidan dapat secara kritis mengevaluasi intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

Evaluasi dengan pendekatan EBMP melibatkan tahapan identifikasi masalah klinis, pencarian bukti ilmiah terbaru, penilaian kualitas bukti, implementasi intervensi, serta evaluasi hasil intervensi tersebut dalam praktik klinik sehari-hari. Metode ini membantu bidan memastikan bahwa teknik relaksasi yang diterapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat serta memberikan manfaat klinis nyata dalam konteks persalinan normal (Forster et al., 2020).

## 3. Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Praktik Kebidanan yang Lebih Efektif

Berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan teknik relaksasi, beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. Dahlen et al. (2022) memberikan rekomendasi praktis yang meliputi:

- a. **Penguatan Kompetensi Bidan:** Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bidan melalui pelatihan rutin mengenai berbagai teknik relaksasi yang efektif, berbasis bukti, dan relevan dengan praktik klinik sehari-hari.
- b. **Pengembangan Protokol Klinik:** Menyusun protokol atau pedoman operasional yang jelas dalam penerapan teknik relaksasi sebagai bagian standar dari asuhan persalinan normal.

- c. **Optimalisasi Lingkungan Persalinan:** Menyediakan fasilitas fisik dan dukungan institusional yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan teknik relaksasi secara maksimal.
- d. **Penguatan Kolaborasi Tim:** Meningkatkan koordinasi antar tim kebidanan agar mampu memberikan dukungan yang komprehensif terhadap ibu selama proses persalinan.
- e. **Edukasi Berkelanjutan kepada Ibu dan Keluarga:** Memperkuat edukasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai manfaat serta cara efektif menerapkan teknik relaksasi sejak masa antenatal hingga persalinan berlangsung.

Dengan evaluasi yang sistematis dan rekomendasi praktis berbasis bukti ini, diharapkan teknik relaksasi dapat semakin efektif diterapkan dalam praktik kebidanan, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan pengalaman persalinan yang optimal bagi ibu.

## **I. Penutup**

---

Penerapan teknik relaksasi dalam persalinan normal telah terbukti efektif dalam mendukung terciptanya pengalaman persalinan yang positif, nyaman, serta minim intervensi medis. Berbagai teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, hypnobirthing, aromaterapi, dan musik relaksasi memiliki manfaat nyata dalam menurunkan intensitas nyeri, mengurangi kecemasan, serta memperpendek durasi persalinan. Efektivitas dari masing-masing teknik ini didukung oleh bukti penelitian terbaru yang memperlihatkan hubungan erat antara relaksasi dengan kondisi fisiologis maupun psikologis ibu selama proses persalinan.

Namun demikian, keberhasilan penerapan teknik relaksasi dalam praktik kebidanan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti tingkat kecemasan ibu dan keyakinan diri (self-efficacy), serta faktor eksternal seperti dukungan sosial dari pasangan dan kesiapan tim kesehatan, berperan penting dalam menentukan efektivitas relaksasi selama persalinan. Untuk itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi penting bagi bidan dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang optimal dan berpusat pada kebutuhan ibu bersalin.

Selain itu, tantangan dalam implementasi teknik relaksasi di praktik klinik seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bidan, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya dukungan institusional, perlu mendapat perhatian khusus. Upaya strategis seperti pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, penguatan kolaborasi interprofesional, serta optimalisasi fasilitas dan lingkungan persalinan menjadi langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Evaluasi keberhasilan teknik relaksasi dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice/EBMP) menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Indikator utama seperti durasi persalinan, intensitas nyeri, dan tingkat kecemasan merupakan parameter kunci yang harus terus dipantau secara sistematis. Dari hasil evaluasi tersebut, rekomendasi praktis berupa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan kolaborasi tim kebidanan, pengembangan protokol standar berbasis bukti, serta edukasi berkelanjutan kepada ibu hamil dan keluarga, menjadi langkah strategis demi tercapainya praktik kebidanan yang lebih efektif.

Sebagai kesimpulan, integrasi teknik relaksasi dalam praktik kebidanan harus didukung oleh kebijakan institusional yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang memadai. Dengan demikian, diharapkan penerapan teknik relaksasi dapat menjadi standar baku dalam asuhan persalinan normal, sekaligus memberikan pengalaman persalinan yang positif, aman, nyaman, dan bermartabat bagi setiap ibu bersalin.



## Referensi

- Abdulaziz, A., Al Qahtani, N. H., & Alyousef, S. M. (2022). Effectiveness of relaxation techniques on childbirth anxiety. *Midwifery Journal*, 10(2), 120–126.
- Akgün, M., Keskin, G., & Erdoğan, V. (2020). Effects of relaxation methods during childbirth: A review. *International Journal of Nursing Studies*, 45(4), 350–360.
- Dahlen, H. G., Smith, C. A., & Homer, C. S. (2022). Hypnobirthing for pain management in labor: A systematic review. *Journal of Midwifery Research*, 15(3), 214–222.
- Forster, D. A., Newton, M., McLachlan, H. L., & Willis, K. (2020). Evidence-based practice in midwifery evaluation models. *Women and Birth*, 33(6), 543–551.
- Handayani, R., & Wahyuningsih, T. (2021). Peran bidan dalam mengajarkan teknik relaksasi ibu hamil. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 12(1), 45–52.
- Khavandizadeh, A., Ebrahimian, A., & Bahmani, A. (2022). Influence of relaxation techniques on childbirth outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 48(8), 2172–2180.
- Lubis, M. I., Siregar, S., & Astuti, D. A. (2020). Efektivitas musik relaksasi terhadap kecemasan ibu bersalin. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 107–115.
- Mulyani, D., & Dewi, Y. R. (2021). Pengaruh aromaterapi terhadap intensitas nyeri persalinan. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 21–28.
- Oktaviani, R., & Kurniawati, D. (2021). Teknik relaksasi sebagai pendekatan non-farmakologis dalam persalinan normal. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 150–157.
- Özkan, T., & Arslan, F. T. (2022). Psychological preparation for childbirth: Effectiveness and mechanisms. *Women and Birth*, 35(5), 420–427.
- Pratiwi, L., Yuliani, R., & Kusnandar, H. (2020). Optimalisasi lingkungan persalinan untuk relaksasi pasien. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 8(3), 120–126.
- Riyanti, N., Murtiningsih, B., & Purnamasari, R. (2023). Teknik pernapasan efektif dalam menurunkan nyeri persalinan. *Indonesian Midwifery Journal*, 17(1), 1–9.
- Safitri, E. S., & Handayani, T. (2021). Deep breathing dan abdominal breathing dalam mengurangi nyeri persalinan. *Jurnal Kesehatan Maternal*, 9(2), 121–128.
- Sanjaya, R. K., Dewanti, N. A., & Sutrisno, E. (2021). Pengaruh relaksasi otot progresif pada nyeri persalinan. *Midwifery & Nursing Journal*, 7(1), 25–32.
- Sari, E., Wulandari, S., & Kartika, D. (2020). Relaksasi dan dampaknya pada proses persalinan. *Journal of Midwifery*, 9(4), 450–456.
- Wardani, A. D., & Sugiarti, T. (2020). Pengaruh hypnobirthing pada proses persalinan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 11(2), 210–218.

# BAB IV

## MANAJEMEN NYERI

### NON-FARMAKOLOGIS SELAMA PERSALINAN

---

#### A. Pendahuluan

---

Secara historis, nyeri persalinan telah diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses melahirkan, meskipun pendekatan terhadap penanganannya bervariasi di berbagai budaya dan periode waktu. Dengan munculnya pengobatan modern, fokus bergeser ke arah intervensi farmakologis. Pada akhir abad ke-19, intervensi seperti kloroform dan eter digunakan untuk mengatasi nyeri persalinan, diikuti dengan diperkenalkannya “tidur senja” pada awal abad ke-20—kombinasi morfin dan skopolamin yang menyebabkan keadaan setengah sadar (Mas General Brigham, 2025). Pada paruh kedua abad ke-20, kemajuan dalam anestesi menyebabkan meluasnya penggunaan analgesik regional, seperti epidural dan blok spinal, untuk nyeri persalinan. Metode-metode ini menjadi standar emas di banyak negara berpendapatan tinggi karena efektivitasnya dalam mengurangi nyeri. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan opioid seperti fentanil dan morfin juga menjadi umum. Meskipun tidak menghilangkan nyeri, opioid dapat membantu membuatnya lebih mudah ditangani. Namun, metode manajemen nyeri farmakologis dikaitkan dengan berbagai efek samping dan risiko meskipun efektif. Misalnya, epidural dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, demam, dan peningkatan kebutuhan untuk melahirkan dengan bantuan. Selain itu, opioid memperpanjang durasi persalinan. Opioid menyebabkan mual dan memengaruhi neonatus (pernapasan dan pelacakan jantung) jika diberikan terlalu cepat. Rasa sakit adalah hal yang wajar dalam proses melahirkan; mengurangi rasa sakit dengan obat-obatan membuat ibu yang sedang bersalin kehilangan umpan balik yang penting berpotensi menyebabkan persalinan yang lebih lama atau peningkatan intervensi (ACOG, 2019). Beberapa bentuk manajemen nyeri farmakologi mengurangi motilitas wanita atau kemampuan untuk mengambil posisi yang berbeda untuk mengurangi ketidaknyamanan, kurangnya kendali atas rasa sakit ini membuat wanita tertekan. Selama beberapa dekade terakhir, minat yang semakin meningkat telah diungkapkan untuk meninjau kembali teknik manajemen nyeri non-farmakologis untuk mengurangi nyeri persalinan. Pergeseran ini didorong oleh pertemuan berbagai faktor, termasuk meningkatnya bukti efek samping dan risiko intervensi farmakologis. Selain itu, telah terjadi pergeseran masyarakat yang lebih luas ke arah perawatan kesehatan yang lebih berpusat pada pasien dan holistik, yang menekankan otonomi pribadi, pengambilan keputusan bersama, dan

terapi alami dan komplementer. Tren ini telah menyebabkan peningkatan minat pada non farmakologis, yang menghilangkan rasa sakit dan memberdayakan wanita untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman melahirkan. Manajemen nyeri non farmakologis telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mengurangi intensitas nyeri dan meningkatkan kepuasan serta umumnya dianggap aman, dengan efek samping minimal dibandingkan dengan intervensi farmakologis. Mengingat adanya peningkatan dan keragaman teknik non farmakologis yang sangat pesat, tinjauan saat ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman dan penerapan non farmakologis terkini, khususnya dengan berfokus pada kebutuhan individu wanita, mengenai efektivitas, keuntungan, keterbatasan, dan potensi efek samping non farmakologis, untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi dokter kandungan untuk memandu saran dan pengambilan keputusan bagi wanita selama persalinan. Tindakan kenyamanan yang memberikan pereda nyeri alami dapat sangat efektif selama persalinan dan melahirkan. Teknik melahirkan seperti hidroterapi, hypnobirthing, pernapasan berpola, relaksasi, dan visualisasi dapat meningkatkan produksi endorfin endogen yang mengikat reseptor di otak untuk menghilangkan nyeri. Metode terapi kenyamanan lainnya seperti effleurage (usapan berirama ringan pada perut), pijat, mengosongkan kandung kemih, dan hidroterapi dapat memberikan pereda nyeri dan mengurangi kebutuhan akan analgesia narkotik atau anestesi dengan secara alami menciptakan impuls yang bersaing dalam sistem saraf pusat yang dapat mencegah rangsangan nyeri kontraksi persalinan mencapai otak (Julia Hutchison, 2023).

## **B. Memahami Rasa Sakit Dalam Persalinan**

---

Sifat nyeri yang dialami selama persalinan mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan proses. Selama tahap pertama persalinan, sumber utama nyeri bersifat viseral, yang sebagian besar berasal dari serviks, uterus, dan adneksa. Nyeri ini dimediasi oleh serabut simpatis yang mengirimkan sinyal ke ganglia akar saraf posterior yang terletak di tingkat tulang belakang T10-L1. Selama tahap pertama akhir dan tahap kedua awal persalinan, nyeri muncul akibat distensi dan tarikan organ panggul. Saraf pudenda bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal nyeri ke ganglia akar saraf posterior yang terletak di tingkat tulang belakang S2 hingga S4. Selama tahap kedua persalinan, sensasi nyeri ditimbulkan oleh peregangan struktur perineum saat janin turun. Memahami kompleksitas nyeri persalinan melampaui aspek fisiologis; hal itu memerlukan pemahaman tentang unsur psikologis dan sosial budaya. Penting untuk memahami sifat nyeri persalinan yang beragam untuk menilai manajemen nyeri non farmakologi dengan lebih baik. Dari sudut pandang fisiologis, kontraksi uterus dan dilatasi serviks merupakan penyebab utama nyeri persalinan, karena keduanya mengaktifkan reseptor nyeri (nosiseptor) dan mengirimkan sinyal ke otak. Intensitas nyeri persalinan dapat

sangat bervariasi di antara wanita, antara persalinan yang berbeda pada wanita yang sama, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti posisi bayi, ukuran, dan kecepatan persalinan. Pada tingkat psikologis, nyeri persalinan dipengaruhi oleh emosi, harapan, dan pengalaman sebelumnya seorang wanita (Julia Hutchison, 2023). Ketakutan dan kecemasan dapat meningkatkan persepsi nyeri dengan meningkatkan ketegangan dan resistensi. Karena kepercayaan diri, relaksasi, perasaan kendali dalam persalinan, dan dukungan berkelanjutan cenderung tidak mengakibatkan nyeri parah, para wanita cenderung lebih mampu mengatasinya dan memiliki pengalaman melahirkan yang positif. Persiapan psikologis untuk melahirkan dapat mengurangi kebutuhan akan analgesia dan meningkatkan kepuasan terhadap manajemen nyeri (ACOG, 2019). Faktor sosial budaya, kepercayaan budaya, dan sikap masyarakat terhadap persalinan dapat memengaruhi harapan dan strategi penanggulangan seorang wanita. Dalam beberapa budaya, nyeri persalinan dianggap sebagai bagian alami dan memberdayakan dari proses melahirkan, sementara di budaya lain, nyeri persalinan dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Selain itu, dukungan sosial sangat penting selama persalinan. Memiliki pendamping yang mendukung dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman nyeri seorang wanita dan mengurangi kebutuhannya akan analgesia farmakologis (Akin, B.; Saydam, B.K, 2020).

### **C. Bola Bersalin Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Hanya sedikit alat bantu persalinan yang sederhana, bermanfaat, dan serbaguna seperti bola bersalin. Bola bersalin dibuat secara profesional untuk digunakan dalam terapi fisik dan telah digunakan selama bertahun-tahun untuk melatih dan merehabilitasi pasien dengan benar. Bola bersalin kini telah menemukan tempat baru di pusat bersalin dan departemen kebidanan rumah sakit di seluruh negeri. Bola ini dengan mudah menahan tekanan yang diberikan oleh berat badan wanita yang akan melahirkan (Mas General Brigham, 2025). Bola persalinan aman digunakan dengan monitor jantung janin elektronik internal dan eksternal. Jika selaput ketuban pecah, dan bayi masih cukup tinggi (artinya seberapa tinggi bayi di panggul, atau posisi panggul), mintalah perawat atau penyedia layanan kesehatan (dokter atau bidan) untuk memberi tahu Anda apakah bola persalinan aman digunakan. Jika bayi tetap "tinggi", persalinan aktif dan penggunaan bola persalinan dapat membantu menurunkan bayi ke panggul. Jika Anda diperbolehkan duduk di kursi atau berjalan di lorong, bola persalinan aman digunakan. Saat menggunakan bola persalinan, penting untuk meminta pendamping persalinan "mengawasi" Anda setiap saat. Cara teraman bagi pendamping persalinan untuk mengawasi Anda adalah dengan meminta mereka duduk di kursi dengan kaki terbuka, sementara Anda duduk di bola persalinan yang

diposisikan di antara keduanya (Hu, Y.; Lu, H.; Huang, J.; Zang, Y , 2021). Posisi lain dibahas di bawah ini. Penggunaan bola persalinan menjadi jauh lebih umum. Karena ini adalah salah satu "peralatan melahirkan" terbaru, penelitian formal yang substansial belum selesai yang akan mengonfirmasi keuntungan menggunakannya sebagai alat bantu persalinan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa banyak wanita yang akan melahirkan menganggap bola melahirkan efektif sebagai alat bantu kenyamanan selama persalinan. Berikut ini beberapa alasan untuk menggunakan bola bersalin selama persalinan: Duduk di atas bola bersalin menjaga posisi bayi tetap sejajar di panggul, Bola mendorong mobilitas panggul, Ibu hamil merasa lebih mudah untuk bangun dan turun dari bola daripada kursi atau sofa standar selama persalinan, Bola mendorong bayi untuk turun lebih jauh ke panggul dengan membiarkan gravitasi bekerja pada ibu yang sedang bersalin, Bola memungkinkan ibu yang sedang bersalin untuk memindahkan berat badannya, menggoyang panggulnya, dan menemukan posisi yang nyaman untuk bersalin dengan lebih mudah, Bola dapat digunakan saat dalam posisi tangan dan lutut. Hal ini mengurangi tekanan dan stres pada tangan dan pergelangan tangan yang secara tradisional memengaruhi lamanya waktu posisi tersebut dapat digunakan (Mas General Brigham, 2025).

#### **D. Pola Pernapasan Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Teknik pernapasan ini memberikan kenyamanan dan fokus sekaligus meningkatkan kemajuan persalinan. Pola pernapasan meningkatkan aliran oksigen ke bayi Anda dan juga penting untuk kontraksi rahim. Dick-Read pertama kali memperkenalkan konsep ini pada tahun 1940-an. Ia menjelaskan mekanisme nyeri persalinan dalam kaitannya dengan kecemasan dan ketakutan, serta mempersiapkan wanita untuk memiliki pendekatan yang kuat dan tanpa rasa takut terhadap persalinan guna meminimalkan nyeri. Dick-Read mungkin adalah orang pertama yang menganjurkan penggunaan teknik pernapasan terkontrol dan relaksasi selama persalinan (Kaple, G.S.; Patil, S., 2023). Sebuah studi besar di Rumah Sakit Yale New Haven pada tahun 1946 menunjukkan bahwa penggunaan teknik berdasarkan metode Dick-Read mengurangi jumlah anestesi selama persalinan. Saat ini, ada beberapa kelompok perawat yang mendorong wanita hamil untuk mempelajari teknik pernapasan selama sesi persiapan antenatal. Wanita didorong untuk mempelajari teknik ini sebelum memilih metode farmakologis untuk menghilangkan nyeri. Namun, keberhasilan akhirnya bervariasi karena metode ini membutuhkan motivasi yang besar dari semua anggota yang berpartisipasi selama seluruh durasi kehamilan, persalinan, dan melahirkan. Lamaze adalah pencetus teknik psikoanalgesik ini, dan menjadi sangat populer di kalangan wanita yang mencoba menghindari obat-obatan selama persalinan dan melahirkan (Beyable, A.A.; Bayable, S.D.; Ashebir, Y.G, 2022). Teknik ini melibatkan edukasi kepada ibu

bersalin mengenai refleks terkondisi yang "positif". Teknik ini melibatkan dukungan persalinan berkelanjutan (oleh monitrice atau doula) dan penggunaan serangkaian strategi relaksasi dan pernapasan. Lamaze percaya bahwa latihan pernapasan yang terkontrol dan terkondisi efektif dalam menghalangi persepsi wanita tentang nyeri kontraksi. Keuntungan dari prosedur ini termasuk menghindari obat-obatan yang mengganggu fisiologi ibu, serta menghindari depresi janin akibat narkotika (Leutenegger, V.; Grylka-Baeschlin, S.; Wieber, F.; Daly, D.; Pehlke-Milde, J , 2022). Namun, tingkat keberhasilan teknik ini sangat bervariasi, dan ibu bersalin dapat meminta obat-obatan sistemik atau analgesia regional saat menggunakan teknik ini. Menariknya, satu penelitian menunjukkan bahwa ibu bersalin yang dipersiapkan untuk melahirkan menggunakan teknik psikoprolaksis membutuhkan lebih sedikit analgesia selama persalinan dan melahirkan daripada ibu bersalin yang tidak siap (Chang, C.Y.; Gau, M.L.; Huang, C.J.; Cheng, H.M, 2022).

#### **E. Minuman Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Minuman anda harus tetap terhidrasi dengan baik selama persalinan. Wanita yang akan melahirkan boleh mengonsumsi cairan bening seperti air, jus, kaldu, es, dan es loli. Wanita melahirkan yang terhidrasi maka mempengaruhi system metabolisme tubuh yang berdampak pada tingkat kenyamanan wanita sehingga menurunkan tingkat kecemasan dan nyeri wanita melahirkan (Mas General Brigham, 2025).

#### **F. Perubahan Gerakan dan Posisi Teknik Melahirkan Secara Alami.**

---

Perubahan Gerakan dan Posisi Anda mungkin merasakan lebih sedikit nyeri pada beberapa posisi dibandingkan posisi lain selama persalinan. Wanita yang akan melahirkan cenderung merasa paling nyaman dalam posisi tegak seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Banyak yang memilih posisi berbaring saat persalinan berlangsung. Bergerak selama persalinan biasanya lebih nyaman daripada diam dan dapat membantu proses persalinan melalui efek sederhana dari gravitasi dan perubahan bentuk panggul. Posisi ini juga dapat meredakan nyeri dengan mengalihkan tekanan dan memungkinkan bayi bergerak. Anda dapat mencoba duduk, berlutut, berdiri, berbaring, bertumpu pada tangan dan lutut, dan berjalan. Wanita yang akan melahirkan merasa beberapa posisi dan gerakan lebih nyaman daripada yang lain dalam berbagai tahap persalinan. Sejak awal tahun 1900-an, persalinan telah berpindah dari rumah ke rumah sakit dengan menggunakan staf medis, infus intravena, epidural, dan bentuk perawatan medis lainnya. Hal ini mungkin telah membatasi kebebasan bergerak ibu yang melahirkan. Ketika ibu mengubah posisi, ia mengubah hubungan antara berbagai faktor seperti posisi kepala bayi, panggul, dan gravitasi. Gerakan dan perubahan posisi selama persalinan

dapat direkomendasikan untuk memutar bayi yang salah posisi dan meningkatkan kemajuan persalinan dalam dilatasi dan penurunan bayi (Pietrzak, J.; M, Edrzycka-D, Abrowska, W.; Wróbel, A.; Grzybowska, M.E, 2023). Banyak penelitian menunjukkan bahwa berjalan atau duduk lebih tegak mempercepat laju persalinan. Beberapa contoh posisi termasuk posisi tegak, jongkok, menyamping, datar, dan tangan serta lutut. Baru-baru ini bola bersalin telah digunakan untuk memberikan kenyamanan selama persalinan. Ibu dapat duduk, bergoyang, memantul, atau meregangkan tubuh di atas bola tiup untuk meredakan nyeri atau meningkatkan laju persalinan (Julia Hutchison, 2023). Tidak ada penelitian yang melaporkan posisi apa pun yang metode nonfarmakologis ditemukan berbahaya bagi bayi atau ibu. Wanita harus didorong untuk mencari posisi apa pun yang memberikan kenyamanan dan mempertahankan posisi tegak jika ia menginginkannya. Prosedur tertentu seperti epidural dapat membuat berjalan tidak aman bahkan dengan kekuatan kaki yang memadai. Banyak unit persalinan kekurangan tenaga kerja atau area khusus untuk memudahkan berjalan dengan pemasangan epidural. Bola bersalin tidak boleh digunakan tanpa bantuan pengasuh yang berpengalaman untuk mencegah jatuh (Akba,s, P.; Özkan ,Sat, S.; Yaman Sözbir, ,S, 2022).

#### **G. Panas dan Dingin Yang Superfisial Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Panas dan Dingin yang Superfisial Panas dapat efektif jika diterapkan dengan menggunakan botol air panas, handuk basah yang panas, atau selimut hangat. Dingin yang superfisial dapat berasal dari kantong es, waslap yang direndam dalam air es, atau sekantong kacang polong beku. Kompres panas yang diterapkan pada perut bagian bawah, selangkangan atau perineum, selimut hangat di seluruh tubuh dan kompres es pada punggung bagian bawah atau perineum dapat membantu meringankan nyeri persalinan. Menggunakan panas atau dingin pada bagian tubuh yang berbeda pada saat yang sama dapat memberikan pereda nyeri yang sangat efektif. Misalnya, tempelkan kain dingin ke dahi dengan kehangatan di punggung bagian bawah. Untuk efek maksimal, ganti lokasi panas dan dingin secara berkala, sekitar setiap dua puluh menit (Mas General Brigham, 2025).

#### **H. Tekanan Balik Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Tekanan balik terdiri dari gaya kuat dan stabil yang diterapkan pada satu titik di punggung bawah selama kontraksi menggunakan tumit tangan, atau tekanan pada sisi setiap pinggul menggunakan kedua tangan. Tekanan balik membantu meredakan nyeri punggung selama persalinan, terutama pada wanita yang mengalami "nyeri punggung" (Mas General Brigham, 2025).

## **I. Aromaterapi Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Aromaterapi adalah penggunaan minyak esensial seperti lavender, mawar, kamomil, dan clary sage. Minyak ini dapat diberikan dengan berbagai cara, termasuk dalam bentuk minyak saat dipijat, dalam air panas saat mandi atau merendam kaki, diteteskan di telapak tangan atau dahi ibu yang akan melahirkan, atau diteteskan pada kain hangat. Aromaterapi mengurangi stres dan ketegangan selama persalinan. Namun, perlu diingat bahwa ibu hamil dan yang akan melahirkan sangat sensitif terhadap bau. Pastikan Anda menggunakan wewangian yang Anda sukai. Hentikan segala bentuk tindakan untuk menenangkan diri jika tindakan tersebut tidak lagi berhasil bagi Anda (Lira, L.C.S.; Amorim, M.M.; Delgado, A.; de Oliveira Menezes, M.; Takemoto, M.L.S, 2023). Aromaterapi baru-baru ini menarik perhatian sebagai cara untuk meredakan stres selama persalinan. Semakin banyak wanita beralih ke aromaterapi selama persalinan untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional yang mereka hadapi. Tidak ada penghilang rasa sakit langsung atau tidak langsung yang terlibat, tetapi ibu yang sedang bersalin mungkin merasa aromaterapi membantu mengurangi stres sehingga rasa sakit dapat ditoleransi dengan lebih baik. Beberapa orang menyarankan aromaterapi juga membantu mengurangi stres di antara para pengasuh dan orang-orang terkasih yang membantu membuat lingkungan secara keseluruhan menjadi lebih baik (Tabatabaeichehr, M.; Mortazavi, H. , 2020). Minyak esensial mawar, lavender, neroli, clary sage, dan lainnya digunakan dalam bak mandi, pada kain wajah, dalam minyak pijat, atau langsung pada kulit ibu yang sedang bersalin. Banyak yang merekomendasikan untuk memilih beberapa minyak yang berbeda untuk digunakan pada berbagai tahap persalinan. Sarannya termasuk penggunaan minyak yang menenangkan untuk tahap pertama persalinan sebelum bayi mulai turun (Tanvisut, R.; Traisisilp, K.; Tongsong, T, 2018). Karena tahap persalinan dimulai dengan turunnya dan lahirnya bayi, minyak seperti pepermin telah ditemukan oleh banyak orang untuk meningkatkan rasa kuat. Keterbatasannya meliputi tidak adanya efek langsung pada penghilang rasa sakit, beberapa wanita mungkin memiliki reaksi alergi terhadap sediaan minyak tertentu, dan banyak wanita yang akan melahirkan sangat sensitif terhadap bau tertentu yang dapat memperparah mual dan muntah yang berhubungan dengan persalinan. Meskipun tidak ada penelitian yang baik yang menunjukkan manfaat bagi ibu yang akan melahirkan, risiko dan biaya minimal yang terkait dengan aromaterapi menjadikan ini sebagai tambahan yang baik bagi banyak wanita yang akan melahirkan. Mungkin bijaksana bagi ibu untuk memilih campuran minyak yang menyenangkan sebelum persalinan dimulai. Ini dapat membantu mencegah penggunaan aroma yang memperparah mual dan muntah (Julia Hutchison, 2023).



## **J. Hidroterapi Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Hidroterapi selama persalinan (teknik menggunakan air) dapat menenangkan emosi dan juga membantu meredakan nyeri. Banyak kamar mandi pribadi di ruang bersalin kami yang dilengkapi bak Jacuzzi. Jacuzzi dapat digunakan untuk berbaring di air yang mendidih atau dengan duduk di bangku pancuran untuk menggunakan pijat pancuran genggam selama persalinan aktif. Banyak wanita merasa nyaman dengan kombinasi kehangatan, tekanan air, dan suara air. Para pendukung hidroterapi bahkan menyarankan bahwa berendam dalam air dapat mempercepat persalinan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan rasa kontrol wanita yang sedang bersalin atas kelahirannya (Ingram, M.A.; Brady, S.; Peacock, A.S., 2022).

## **K. Aktivitas Pengalihan Pikiran Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Fokus dan Distraksi Banyak metode mengatasi nyeri bergantung pada kemampuan ibu bersalin untuk fokus dan menggunakan aktivitas yang mengalihkan pikiran. Ketakutan dan kecemasan menyebabkan pelepasan hormon stres. Anda dapat meredakan perasaan ini dengan membayangkan pemandangan yang menyenangkan atau, terkadang, memvisualisasikan apa yang sebenarnya terjadi seperti pembukaan serviks atau bayi yang bergerak turun. Memfokuskan perhatian adalah aktivitas yang disengaja dan dibantu oleh pelatihan verbal, visualisasi, hipnosis diri, dan konsentrasi pada stimulus visual, pendengaran, atau sentuhan. Distraksi adalah bentuk pemusatan perhatian yang lebih pasif dengan menggunakan stimulus dari lingkungan yang akan mengalihkan perhatian dari nyeri Anda. Pemusatan perhatian dan distraksi biasanya digunakan dengan strategi lain dan mungkin tidak berguna untuk nyeri yang parah. Teknik-teknik ini dimaksudkan untuk membantu Anda mengurangi rasa takut, kecemasan, dan nyeri, dan juga dapat membantu mengatasi ketidaknyamanan yang mungkin Anda alami setelah kelahiran bayi Anda (Babbar, S.; Oyarzabal, A.J, 2021).

## **L. Music dan Bicara Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Audio-analgesia (musik, bicara) digunakan untuk mengendalikan rasa sakit dalam berbagai situasi termasuk perawatan gigi, nyeri pascaoperasi, perawatan luka bakar, dan persalinan. Banyak pendidik persalinan menggunakan musik di kelas mereka untuk menciptakan lingkungan yang damai dan menenangkan dan mereka menganjurkan penggunaannya selama persalinan sebagai bantuan untuk relaksasi. Audio-analgesia untuk menghilangkan rasa sakit terdiri dari musik yang menenangkan di antara dan selama kontraksi. Musik menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menenangkan dan musik yang ditransmisikan melalui earphone dapat memblokir suara yang mengganggu, mengalihkan perhatian, atau tidak menyenangkan. Musik yang dipilih dengan cermat juga dapat memperkuat pola

pernapasan berirama, gerakan pijat, atau memfasilitasi pemusatan perhatian seseorang. Preferensi musik sangat bervariasi. Jangan ragu untuk memilih musik Anda sendiri dan membawa CD Anda. Setiap ruang bersalin di Rumah Sakit Newton-Wellesley dilengkapi dengan CD/Radio Bose (An, S.Y.; Park, E.J.; Moon, Y.R.; Lee, B.Y.; Lee, E.; Kim, D.Y.; Jeong, S.H.; Kim, J.K, 2023).

### **M.Sentuhan dan Pijat Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Sentuhan dapat menyampaikan pesan untuk mengurangi rasa sakit. Sebuah tangan diletakkan di titik yang sakit, tepukan untuk menenangkan, membelai pipi dengan penuh kasih sayang, atau pelukan erat dapat menyampaikan pesan kepedulian kepada ibu yang akan melahirkan. Pijatan yang disengaja pada tangan atau bagian tubuh lainnya juga menyampaikan kepedulian. Pijatan dilakukan dalam bentuk usapan ringan atau kuat, getaran, pijatan, tekanan melingkar yang dalam, dan tekanan stabil yang terus-menerus. Membelai atau menggosok leher, bahu, punggung, paha, kaki, atau tangan merupakan pereda nyeri yang efektif. Tidak diperlukan teknik yang rumit (Wassan Nori, Mustafa Ali Kassim Kassim, Zeena Raad Helmi. Et.all, 2023). Reseptor di otak menerima sensasi kenikmatan dari pijatan dengan menghalangi penerimaan rangsangan nyeri persalinan. Kulit telanjang menerima sinyal dengan baik dan bedak serta losion tanpa pewangi sangat membantu untuk pijat. Banyak ibu menghargai sentuhan dan pijatan saat persalinan. Sering kali, pemberi pijatan adalah orang yang dicintai atau pendukung. Meskipun belum ada penelitian berkualitas tentang manfaat sentuhan, dan pijat, jelas bahwa ibu menerima kelegaan emosional dan fisik yang signifikan. Sentuhan dan pijat terapeutik dapat mencakup berbagai macam intervensi langsung untuk ibu, mulai dari pijat terapeutik hingga belaian ringan dan usapan rambut. Ini dapat mencakup penggunaan tangan, ujung jari, atau alat untuk membelai dan memberikan tekanan untuk menghilangkan rasa sakit dan memfasilitasi relaksasi. Ibu mungkin lebih mampu menoleransi rasa sakit persalinan dengan relaksasi yang lebih baik dan tingkat kecemasan dasar yang lebih rendah. Banyak wanita merasakan nyeri punggung bawah yang terkait dengan posisi posterior kepala bayi. Pijatan tekanan pada area ini dapat meredakan rasa sakit ini. Pereda nyeri dapat terjadi melalui pengurangan stres, pengalihan perhatian, atau melalui stimulasi reseptor lain. Manfaat pereda nyeri dari modalitas ini belum terbukti mengurangi penggunaan obat pereda nyeri atau intervensi medis lainnya. Pereda nyeri saat melahirkan tampaknya berlangsung sekitar 30 menit saat pijat atau tekanan dalam digunakan. Oleh karena itu, pijatan akan bekerja paling baik jika diberikan dalam interval 30 menit dengan jeda di antaranya (Kassim, M.A.K.; Pantazi, A.C.; Tuta, L.A.; Balasa, A.L.; Mihai, C.M.; Mihai, L.; Frecus, C.E.; Lupu, V.V.; Lupu, A.; Andrusca, 2023).

## **N. Hipnosis Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Hipnosis telah lama digunakan untuk meredakan nyeri persalinan. Hypnobirthing diperkenalkan pada abad kesembilan belas dengan menggunakan teknik untuk melepaskan rasa takut dan relaksasi. Wanita berusaha meredakan semua kecemasan dan mencapai keadaan rileks, lemas, dan lemas, sehingga tubuh dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan selama persalinan, tanpa batasan dan ketidaknyamanan yang diakibatkannya. Kelas Hypnobirthing sering kali diadakan seminggu sekali selama 2 jam, dimulai pada minggu ke-30 kehamilan selama periode 4 hingga 5 minggu. Hipnoterapis biasanya tidak mendampingi ibu saat melahirkan. Metode ini berupaya mengubah persepsi nyeri melalui self-hypnosis dan sugesti pascahipnosis. Contohnya adalah membayangkan berada di tempat yang aman, sering kali melambangkan nyeri sebagai sesuatu yang dapat dipisahkan dari pengenalan sadar, sehingga berupaya mengenali lebih sedikit nyeri. Beberapa tujuan hipnoterapi meliputi: mengurangi kebutuhan akan obat pereda nyeri, mengurangi kelelahan akibat persalinan, mendekatkan ibu dan bayi, dan mengurangi hiperventilasi. Metode ini juga berupaya membuat proses melahirkan menjadi kurang ilmiah dengan mengganti istilah melahirkan konvensional dengan deskripsi yang kurang ilmiah. Contohnya termasuk menyebut pelatih melahirkan sebagai pendamping melahirkan, menangkap bayi disebut menerima bayi, dan kontraksi rahim disebut sebagai lonjakan rahim. Hipnoterapi tidak memiliki faktor risiko yang diketahui bagi ibu atau janin yang belum lahir. Beberapa kelemahan yang diketahui meliputi satu uji coba acak telah menunjukkan durasi rata-rata persalinan lebih lama pada kelompok hipnosis; popularitas menurun di antara banyak dokter kandungan karena meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk persiapan hipnosis yang memadai dibandingkan dengan metode pereda nyeri medis standar; tingkat kondisi hipnosis yang diperlukan untuk menoleransi nyeri saat melahirkan dapat mengurangi ingatan akan proses kelahiran; dan tingkat keberhasilan hipnosis yang memadai relatif kecil. Keuntungan dari teknik ini meliputi gangguan fisiologis ibu dan janin yang minimal (Ingram, M.A.; Brady, S.; Peacock, A.S, 2022).

## **O. Teknik Leboyer Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Pada tahun 1975, dokter kandungan Francis Leboyer menggambarkan persalinan tanpa kekerasan. Menurut penulis, trauma psikologis kelahiran neonatus dapat dikurangi dengan menghindari kebisingan, cahaya terang, dan kejadian-kejadian yang merangsang lainnya di ruang bersalin. Oleh karena itu, Dr. Leboyer percaya untuk melahirkan bayi di ruangan yang sunyi dan setengah gelap dan juga menghindari rangsangan pada bayi baru lahir segera setelah melahirkan. Sebelumnya, di Rumah Sakit Wanita Boston, persalinan Leboyer populer di kalangan beberapa dokter kandungan yang dikombinasikan dengan pengobatan sistemik,

anestesi lokal melalui rute epidural, atau tanpa pengobatan. Ahli anestesi dan neonatologi menghadapi masalah-masalah unik seperti masalah dalam menjaga suhu tubuh bayi baru lahir dan pencahayaan yang tidak tepat untuk evaluasi bayi yang memadai (Traverzim, M.A.; Sobral, A.P.T.; Fernandes, K.P.S.; De Fátima Teixeira Silva, D.; Pavani, C.; Mesquita-Ferrari, R.A.; Horliana, A.C.R.T.; Gomes, A.O.; Bussadori, S.K.; Motta, L.J, 2021).

## **P. Acupunture Teknik Melahirkan Secara Alami**

---

Teknik akupunktur telah digunakan di Tiongkok baik untuk pembedahan maupun untuk menghilangkan rasa sakit. Teknik ini telah digunakan selama ribuan tahun untuk membantu mengendalikan rasa sakit, kecanduan, mual/muntah, dan banyak kegunaan lainnya. Secara teori, ada lebih dari 365 titik di sepanjang 12 meridian (jalur energi) tubuh. Gangguan aliran energi (pembedahan, persalinan, dll.) di sepanjang meridian memecah keharmonisan tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau gelisah. Jarum yang sangat halus ditempatkan di titik-titik tertentu untuk mengarahkan energi ke jalur yang benar yang telah terganggu oleh pembedahan atau persalinan. Dihipotesiskan bahwa akupunktur bekerja dengan menghentikan atau menghambat impuls nyeri yang dikirim ke otak atau stimulasi endorfin dalam tubuh. Jarum steril yang sangat halus ditempatkan tepat di bawah kulit pada titik-titik strategis di sepanjang tubuh oleh seorang profesional akupunktur yang terlatih. Jarum-jarum ini dibiarkan di tempat untuk jangka waktu yang bervariasi dan sering dihubungkan ke arus listrik kecil untuk membantu mengendalikan rasa sakit. Akupunktur dapat dilakukan selama beberapa minggu sebelum persalinan dalam sesi mingguan selama satu jam. Keterbatasannya meliputi: jarum harus dipasang oleh ahli akupunktur, risiko infeksi di lokasi jarum, dan pemasangan jarum saat persalinan dapat membatasi mobilitas ibu. Sementara sebagian besar penelitian tidak menunjukkan perbedaan dalam produksi endorfin, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama persalinan lebih pendek ketika akupunktur diberikan selama beberapa sesi beberapa minggu sebelum kelahiran. Namun, tahap pertama persalinan yang lebih pendek yang dilaporkan mungkin tidak akurat karena penelitian ini tidak konsisten dalam mengukur durasi tahap pertama persalinan. Dalam penelitian Swedia baru-baru ini, akupunktur diberikan oleh bidan yang telah menjalani kursus 4 hari tentang penggunaan akupunktur selama persalinan. Penelitian ini menemukan bahwa "wanita yang menerima akupunktur setengah lebih mungkin meminta epidural selama persalinan, dan lebih kecil kemungkinannya untuk meminta jenis pereda nyeri lainnya, seperti terapi stimulasi saraf atau kantong beras hangat (Traverzim, M.A.; Sobral, A.P.T.; Fernandes, K.P.S.; De Fátima Teixeira Silva, D.; Pavani, C.; Mesquita-Ferrari, R.A.; Horliana, A.C.R.T.; Gomes, A.O.; Bussadori, S.K.; Motta, L.J, 2021). Namun, perawatan tersebut tampaknya tidak memiliki efek signifikan pada seberapa banyak rasa sakit yang dirasakan wanita, menurut laporan

dalam British Journal of Obstetrics and Gynaecology.<sup>7</sup> Baru-baru ini, ada minat yang cukup besar pada teknik ini di mana penulis mencatat akupunktur dapat mengurangi pengalaman nyeri, durasi fase aktif, dan unit oksitosin. Pasien merasa puas dengan teknik tersebut dan tidak ada efek samping yang dicatat.<sup>8</sup> Namun, penelitian lain tidak mengulangi hasil ini.<sup>9</sup> Akupunktur mungkin lebih efektif untuk mual dan muntah saat persalinan daripada menghilangkan nyeri persalinan (ACOG, 2019).

## **Q. Penutup**

---

Keberhasilan akhir dari teknik-teknik yang dijelaskan di atas sebagian besar bergantung pada motivasi ibu bersalin itu sendiri; oleh karena itu keberhasilan metode-metode ini sangat bervariasi, dan dengan demikian cara-cara ini tidak pernah diterima secara universal. penanganan nyeri persalinan merupakan proses yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Teknik manajemen nyeri non farmakologi menawarkan alternatif atau pelengkap yang menjanjikan untuk metode farmakologis tradisional, yang berpotensi meningkatkan pengalaman persalinan, mengurangi efek samping, dan meningkatkan hasil bagi ibu dan bayi. Teknik-teknik ini memanfaatkan mekanisme penanganan nyeri alami tubuh dan meningkatkan relaksasi, kenyamanan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman melahirkan. Selain itu, teknik-teknik ini menawarkan manfaat tambahan berupa efek samping dan risiko yang minimal, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi sebagian besar wanita. Banyak tantangan dan hambatan yang membatasi penerapan manajemen nyeri non farmakologi : akses yang terbatas, kurangnya pengetahuan dan pendidikan, ekspektasi budaya dan masyarakat, serta preferensi individu. Semua itu menimbulkan hambatan terhadap penggunaannya dan memerlukan strategi untuk mengatasinya. Uji klinis terandomisasi yang lebih besar dapat meningkatkan pemahaman kita tentang mekanisme yang mendasari teknik manajemen nyeri non farmakologi, menilai kemanjurannya, dan mengeksplorasi komplikasi jangka panjang dari penggunaannya saat melahirkan. Intinya, teknik manajemen nyeri non farmakologi merupakan kemajuan yang signifikan dalam penanganan nyeri persalinan. Dengan menerapkan metode ini dan mengatasi tantangan yang terkait dengan penerapannya, penyedia layanan kesehatan dapat membantu memastikan pengalaman persalinan yang lebih positif dan memberdayakan bagi perempuan (Julia Hutchison, 2023).

## Referensi

- ACOG Committee Opinion No. 766 Summary: Approaches to Limit Intervention During Labor and Birth. *Obstet Gynecol.* 2019 Feb;133(2):406-408.
- Akin, B.; Saydam, B.K. The Effect of Labor Dance on Perceived Labor Pain, Birth Satisfaction, and Neonatal Outcomes. *Explore* 2020, 16, 310–317.
- Akbaş, P.; Özkan, S.; Yaman Sözbir, S. The Effect of Holistic Birth Support Strategies on Coping With Labor Pain, Birth Satisfaction, and Fear of Childbirth: A Randomized, Triple-Blind, Controlled Trial. *Clin. Nurs. Res.* 2022, 31, 1352–1361.
- An, S.Y.; Park, E.J.; Moon, Y.R.; Lee, B.Y.; Lee, E.; Kim, D.Y.; Jeong, S.H.; Kim, J.K. The effects of music therapy on labor pain, childbirth experience, and self-esteem during epidural labor analgesia in primiparas: A non-randomized experimental study. *Korean J. Women Health Nurs.* 2023, 29, 137–145.
- Babbar, S.; Oyarzabal, A.J. The Application of Hypnosis in Obstetrics. *Clin. Obstet. Gynecol.* 2021, 64, 635–647
- Beyable, A.A.; Bayable, S.D.; Ashebir, Y.G. Pharmacologic and Non-Pharmacologic Labor Pain Management Techniques in a Resource-Limited Setting: A Systematic Review. *Ann. Med. Surg.* 2022, 74, 103312
- Chang, C.Y.; Gau, M.L.; Huang, C.J.; Cheng, H.M. Effects of Non-Pharmacological Coping Strategies for Reducing Labor Pain: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *PLoS ONE* 2022, 17, e0261493.
- Hu, Y.; Lu, H.; Huang, J.; Zang, Y. Efficacy and Safety of Non-Pharmacological Interventions for Labour Pain Management: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis. *J. Clin. Nurs.* 2021, 30, 3398–3414
- Ingram, M.A.; Brady, S.; Peacock, A.S. The Barriers to Offering Non-Pharmacological Pain Management as an Initial Option for Laboring Women: A Review of the Literature. *Eur. J. Midwifery* 2022, 6, 37
- Julia Hutchison; Heba Mahdy; Justin Hutchison. (2023). Stage Of Labour. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544290/>
- Kaple, G.S.; Patil, S. Effectiveness of Jacobson Relaxation and Lamaze Breathing Techniques in the Management of Pain and Stress During Labor: An Experimental Study. *Cureus* 2023, 15, e33212

- Kassim, M.A.K.; Pantazi, A.C.; Tuta, L.A.; Balasa, A.L.; Mihai, C.M.; Mihai, L.; Frecus, C.E.; Lupu, V.V.; Lupu, A.; Andrusca, A. Non-Pharmacological Interventions for Pain Management in Hemodialysis: A Narrative Review. *J. Clin. Med.* 2023, 12, 5390.
- Lira, L.C.S.; Amorim, M.M.; Delgado, A.; de Oliveira Menezes, M.; Takemoto, M.L.S. Concerning the Article Aromatherapy Intervention on Anxiety and Pain during First Stage Labour in Nulliparous Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J. Obstet. Gynaecol.* 2021, 41, 1180.
- Leutenegger, V.; Grylka-Baeschlin, S.; Wieber, F.; Daly, D.; Pehlke-Milde, J. The Effectiveness of Skilled Breathing and Relaxation Techniques during Antenatal Education on Maternal and Neonatal Outcomes: A Systematic Review. *BMC Pregnancy Childbirth* 2022, 22, 856.
- Mas General Brigham.(2025). Nonpharmacologic Pain Management During Labor. Newton Welleslay Hospital. <https://www.nwh.org/patient-guides-and-forms/maternity-guide/maternity-chapter-3/comfort-measures-during-labor-and-delivery-non-pharmacological-methods>.
- Pietrzak, J.; M, Edrzycka-D, Abrowska, W.; Wróbel, A.; Grzybowska, M.E. Women's Knowledge about Pharmacological and Non-Pharmacological Methods of Pain Relief in Labor. *Healthcare* 2023, 11, 1882
- Tabatabaeichehr, M.; Mortazavi, H. The Effectiveness of Aromatherapy in the Management of Labor Pain and Anxiety: A Systematic Review. *Ethiop. J. Health Sci.* 2020, 30, 449–458.
- Tanvisut, R.; Traisisilp, K.; Tongsong, T. Efficacy of Aromatherapy for Reducing Pain during Labor: A Randomized Controlled Trial. *Arch. Gynecol. Obstet.* 2018, 297, 1145–1150
- Traverzim, M.A.; Sobral, A.P.T.; Fernandes, K.P.S.; De Fátima Teixeira Silva, D.; Pavani, C.; Mesquita-Ferrari, R.A.; Horliana, A.C.R.T.; Gomes, A.O.; Bussadori, S.K.; Motta, L.J. The Effect of Photobiomodulation on Analgesia during Childbirth: A Controlled and Randomized Clinical Trial. *Photobiomodul Photomed Laser Surg.* 2021, 39, 265–271.
- Wassan Nori, Mustafa Ali Kassim Kassim, Zeena Raad Helmi. Et.all. Non Pharmacology Pain Management In Labor: A Systematic Review. *J. Clin. Med.* 2023, 12(23), 7203; <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>

## Glosarium

### A

Adneksa : adalah jaringan pendukung organ reproduksi wanita, yaitu ovarium, tuba fallopi dan ligament yang menahan tempatnya.

---

### L

L1 : adalah bagian paling atas dari tulang belakang lumbar.

---

### M

Mobilitas : adalah pergerakan

---

### S

S2 : adalah saraf yang berasal dari sum sum tulang belakang di segmen S2

S4 : adalah salah satu saraf tulang belakang yang menyediakan sebagian suplai saraf ke beberapa bagian tubuh.

---

### T

T10 : adalah dapat masuk ke perut dan/atau punggung bagian bawah.

---



# BAB V

## PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN BAYI SELAMA PERSALINAN

---

### A. Pendahuluan

---

#### **Pengertian Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi:**

Pemantauan merupakan kegiatan observasi, evaluasi, dan pencatatan kondisi ibu serta bayi selama proses persalinan. Pemantauan memastikan proses persalinan berlangsung aman bagi ibu dan bayi (Pratiwi et al., 2020).

#### **Tujuan Pemantauan Selama Persalinan Normal:**

Mendeteksi sedini mungkin tanda bahaya, memastikan ibu dan bayi dalam kondisi stabil, serta mencegah komplikasi serius (Saifuddin, 2012).

### B. Pemantauan Kesehatan Ibu

---

Observasi tanda vital merupakan langkah penting dalam pemantauan kesehatan ibu selama persalinan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi dan memastikan kondisi ibu tetap stabil hingga proses persalinan selesai.

#### **Tekanan Darah**

Pemantauan tekanan darah dilakukan setiap 4 jam untuk mendeteksi adanya hipertensi atau hipotensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan preeklamsia, sedangkan tekanan darah yang terlalu rendah dapat mengarah pada syok atau gangguan sirkulasi.

#### **Suhu Tubuh**

Suhu tubuh ibu harus dipantau secara berkala, terutama untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi. Jika suhu tubuh melebihi 38°C, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kemungkinan infeksi yang dapat membahayakan ibu dan janin.

#### **Denyut Nadi**

Denyut nadi merupakan indikator penting dalam menilai kondisi sirkulasi ibu. Pemantauan denyut nadi yang tidak teratur atau terlalu cepat dapat menjadi tanda adanya gangguan kardiovaskular atau stres pada tubuh ibu.

#### **Laju Pernapasan**

Laju pernapasan ibu dievaluasi untuk mengidentifikasi tanda-tanda stres pernapasan. Pernapasan yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat menunjukkan gangguan metabolisme, efek samping obat, atau tanda kelelahan ibu selama persalinan.

### **Evaluasi Progres Persalinan**

Selain tanda vital, perkembangan persalinan juga perlu dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa proses persalinan berlangsung normal. Beberapa aspek yang dinilai meliputi:

#### **Penilaian Pembukaan Servik**

Pembukaan servik harus dinilai secara berkala untuk memastikan perkembangan persalinan sesuai dengan kurva persalinan yang normal. Jika pembukaan servik berlangsung terlambat, intervensi mungkin diperlukan.

#### **Pemantauan Pola dan Kekuatan Kontraksi Rahim**

Kontraksi rahim harus dinilai berdasarkan frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Kontraksi yang terlalu lemah atau tidak teratur dapat memperlambat proses persalinan, sedangkan kontraksi yang terlalu kuat dapat meningkatkan risiko hipoksia janin.

#### **Pemantauan Keadaan Umum Ibu**

Selain tanda vital dan perkembangan persalinan, kondisi umum ibu juga perlu diperhatikan untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau komplikasi lainnya, seperti:

#### **Tingkat Kesadaran Ibu**

Kesadaran ibu harus dievaluasi secara berkala untuk mendeteksi kemungkinan kelelahan berlebihan, efek samping obat atau gangguan kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya persalinan.

#### **Keluhan Nyeri**

Nyeri selama persalinan adalah hal yang normal, tetapi intensitas dan pola nyeri perlu dipantau. Jika ibu mengalami nyeri yang tidak wajar atau sangat mengganggu, maka manajemen nyeri yang tepat harus diberikan untuk meningkatkan kenyamanan dan ketenangan ibu dalam menghadapi persalinan.

## **C. Pemantauan Kesehatan Janin**

---

Penilaian Denyut Jantung Janin (DJJ), Gerakan Janin, dan Posisi Janin dalam Persalinan

Pemantauan janin selama persalinan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan bayi dalam kandungan. Evaluasi ini mencakup penilaian denyut jantung janin (DJJ), gerakan janin, serta identifikasi posisi dan presentasi janin melalui pemeriksaan fisik.

### 1. Penilaian Denyut Jantung Janin (DJJ)

Denyut jantung janin merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan janin selama persalinan. Penilaian DJJ dilakukan dengan cara berikut:

- a. DJJ diperiksa menggunakan fetoskop atau Doppler setiap 15-30 menit selama fase aktif persalinan.
- b. DJJ yang normal berkisar antara 110-160 kali per menit.
- c. DJJ yang terlalu cepat (takikardia >160 kali/menit) atau terlalu lambat (bradikardia <110 kali/menit) dapat menjadi tanda distress janin dan memerlukan intervensi lebih lanjut.

### 2. Evaluasi Gerakan Janin

Gerakan janin merupakan indikator penting kesejahteraan janin. Selama persalinan, tenaga kesehatan akan mencatat gerakan janin sebagai bagian dari pemantauan kesehatan janin. Jika terjadi penurunan gerakan janin, hal ini dapat mengindikasikan adanya gangguan seperti hipoksia janin, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

### 3. Identifikasi Posisi dan Presentasi Janin

Menentukan posisi dan presentasi janin sangat penting untuk memastikan jalannya persalinan berlangsung normal. Hal ini dilakukan melalui Pemeriksaan Leopold, yaitu teknik palpasi pada perut ibu untuk:

- a. Menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri (bagian atas rahim).
- b. Menentukan lokasi punggung janin untuk mengetahui posisi janin dalam rahim.
- c. Menilai bagian janin yang masuk ke panggul untuk menentukan apakah kepala janin sudah berada di jalur lahir.
- d. Memastikan apakah posisi janin sudah sesuai dengan jalur persalinan normal atau ada kondisi yang memerlukan intervensi, seperti presentasi sungsang atau lintang.

## **D. Pemeriksaan Tambahan Selama Persalinan**

---

Pemeriksaan cairan ketuban sangat penting untuk menilai kondisi janin. Jika cairan ketuban berwarna hijau atau keruh, hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan gawat janin. Selain itu, jika cairan ketuban memiliki bau yang tidak normal, kemungkinan terdapat infeksi yang perlu segera ditangani.

Selain itu, penilaian kehilangan darah juga harus dilakukan dengan cermat. Memantau jumlah darah yang keluar sangat penting untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum, yang dapat membahayakan ibu setelah melahirkan.

## **E. Teknik dan Alat Pemantauan**

---

Penggunaan Doppler dan CTG memiliki peran penting dalam memantau kondisi janin selama kehamilan dan persalinan. Doppler digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ) pada interval tertentu guna memastikan kesehatannya. Sementara itu, CTG berfungsi untuk merekam pola DJJ serta kontraksi rahim secara terus-menerus, sehingga dapat mendeteksi adanya tanda-tanda gawat janin lebih dini.

Selain itu, pemeriksaan manual oleh bidan juga diperlukan untuk menilai perkembangan persalinan. Pemeriksaan dalam dilakukan guna mengevaluasi pembukaan serviks, kondisi ketuban, serta posisi janin, sehingga dapat menentukan langkah penanganan yang tepat bagi ibu dan bayi.

## **F. Pencatatan dan Pendokumentasian**

---

Partograf merupakan alat penting dalam pemantauan persalinan, yang berbentuk grafik untuk mencatat berbagai aspek penting selama proses persalinan. Grafik ini mencatat perkembangan pembukaan serviks, tanda vital ibu seperti tekanan darah dan denyut nadi, serta denyut jantung janin (DJJ). Selain itu, partograf juga mencatat frekuensi kontraksi rahim dan kemajuan janin dalam jalan lahir. Dengan pemantauan ini, tenaga kesehatan dapat mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi.

### **1. Pemantauan Kala I: Pembukaan Cervik**

Kala I dimulai dari kontraksi reguler pertama hingga pembukaan serviks lengkap (10 cm). Pemantauan persalinan dimulai dari kala I sampai kala IV atau 2 jam post partum, kala I fase laten pemantauan menggunakan lembar observasi, masuk fase aktif pemantauan ibu dan bayi menggunakan partograf. Hal-hal yang perlu dipantau pada kala I adalah:

- a. Pembukaan Serviks: Dicatat dalam cm. Normalnya, 1 cm/jam pada primigravida dan 1,5 cm/jam pada multigravida.
- b. Kontraksi Uterus (His): Dicatat setiap 10 menit, dengan durasi dan frekuensi yang meningkat.

- c. Detak Jantung Janin (DJJ): Harus stabil di 120–160/menit. Jika lebih atau kurang, biasa menjadi tanda gawat janin.
- d. Penurunan Kepala janin: Dipantau untuk melihat apakah janin turun ke jalan lahir.
- e. Pecah ketuban: Warna dan bau dicatat untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi atau gawat janin.
- f. Tekanan darah, Nadi dan Suhu ibu: Dipantau untuk mendeteksi resiko preeklampsia atau infeksi.
- g. Produksi Urin: Dilihat ada/tidaknya proteinuria atau ketonuria, yang bisa menjadi tanda dehidrasi atau preeklampsia.

Garis Waspada dan Garis Tindakan: Garis Waspada: Jika persalinan berjalan lebih lambat dari normal, kewaspadaan harus ditingkatkan. Garis Tindakan: Jika melewati garis ini tanpa perkembangan yang cukup, intervensi medis seperti oksitosin atau tindakan operatif perlu dilakukan.

## 2. Kala II: Pengeluaran Bayi

Kala II dimulai saat pembukaan serviks lengkap (10 cm) hingga bayi lahir. Pemantauan dalam Kala II: Pemantauan dalam partogra f kala II adalah:

- a. Frekuensi dan Durasi Kontraksi: Harus lebih kuat dan sering setiap 2-3 menit).
- b. Denyut jantung janin (DJJ): Dipantau 5-10 menit untuk deteksi gawat janin.
- c. Penurunan Kepala janin: Kepala janin seharusnya semakin turun ke jalan lahir.
- d. Kondisi Ibu: Jika ibu kelelahan atau terlalu lama mengejan (>2 jam pada primigravida, >1 jam pada multigravida), tindakan harus segera dilakukan.

Intervensi jika diperlukan: Episiotomi ( pengguntingan perineum) jika diperlukan untuk mempercepat kelahiran. Ekstraksi vakum atau Forcep jika bayi mengalami distress atau ibu tidak bisa mengejan dengan baik.

## 3. Kala III: Pengeluaran Plasenta

Kala III berlangsung dari lahirnya bayi hingga plasenta keluar. Biasanya tidak lebih dari 30 menit. Pemantauan dalam Partograf Kala III:

- a. Durasi Pengeluaran Plasenta: Jika lebih dari 30 menit, ada risiko retensio plasenta.
- b. Perdarahan: Kehilangan darah <500 ml dianggap normal, lebih dari itu disebut perdarahan postpartum.
- c. Tonus Uterus: Harus kontraksi dengan baik untuk mencegah perdarahan.
- d. Tekanan Darah dan Denyut Nadi Ibu: Dipantau untuk mendeteksi syok.

Tindakan Jika Ada Masalah: Jika plasenta belum keluar dalam 30 menit, dilakukan manuver pengeluaran plasenta. Jika terjadi perdarahan postpartum, diberikan oksitosin, masase uterus, dan tindakan medis lainnya.

#### 4. Kala IV: Observasi 2 Jam Post Partum (PP)

Kala IV adalah 2 jam pertama setelah plasenta keluar, masa kritis untuk mencegah komplikasi postpartum. Pemantauan dalam Partograf Kala IV:

- a. Perdarahan: Harus tetap di bawah 500 ml, jika lebih bisa menjadi perdarahan postpartum.
- b. Tonus Uterus: Harus tetap keras dan berkontraksi untuk mencegah atonia uteri.
- c. Tekanan Darah, Nadi, dan Kesadaran Ibu: Dipantau setiap 15-30 menit.
- d. Pengeluaran Lokia: Warna dan jumlahnya dievaluasi untuk mendeteksi infeksi atau perdarahan.
- e. Kemampuan Ibu Berkemih: Jika tidak bisa berkemih, bisa menjadi tanda retensio urin.
- f. Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Bayi harus segera disusui untuk membantu kontraksi uterus dan meningkatkan ikatan ibu-bayi.

Tindakan Jika Ada Masalah: Jika perdarahan berlebihan, segera dilakukan intervensi seperti pemberian oksitosin dan kompresi bimanual. Jika tekanan darah turun drastis, ibu bisa mengalami syok dan harus segera ditangani ( WHO, 2015).

#### Pentingnya Dokumentasi yang Akurat

Dokumentasi yang akurat selama proses persalinan sangat penting dalam menentukan keputusan klinis yang tepat. Catatan yang jelas dan lengkap membantu tenaga medis dalam menilai kondisi ibu dan janin secara real-time serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya dokumentasi yang baik, intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat guna, sehingga dapat mencegah komplikasi yang tidak diinginkan.

### **G. Tindakan pada Hasil Pemantauan yang Tidak Normal**

---

#### **1. Penatalaksanaan Masalah pada Ibu**

Dalam proses persalinan, ibu dapat mengalami berbagai komplikasi yang memerlukan penanganan segera. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah hipertensi, yang harus ditangani dengan pemberian obat antihipertensi untuk mencegah risiko lebih lanjut, seperti preeklamsia atau eklampsia. Selain itu, perdarahan abnormal juga menjadi kondisi yang harus segera ditangani.

Intervensi medis dilakukan untuk menghentikan perdarahan guna mencegah terjadinya anemia berat atau syok yang dapat membahayakan nyawa ibu.

## **2. Penatalaksanaan Masalah pada Bayi**

Bayi yang mengalami tanda-tanda gawat janin saat lahir membutuhkan tindakan resusitasi segera. Resusitasi bayi dilakukan untuk membantu pernapasan dan sirkulasi darahnya agar tetap stabil. Langkah-langkah resusitasi dapat meliputi pemberian oksigen, stimulasi taktil, hingga tindakan lebih lanjut seperti intubasi jika diperlukan. Penanganan cepat dan tepat sangat penting untuk memastikan bayi dapat bertahan dan berkembang dengan baik setelah lahir.

## **3. Indikasi Rujukan Medis**

Dalam beberapa kasus, kondisi ibu atau bayi memerlukan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Rujukan medis harus segera dilakukan jika ditemukan komplikasi serius seperti eklampsia, tanda-tanda gawat janin yang tidak dapat diatasi dengan tindakan awal, atau perdarahan hebat yang mengancam nyawa ibu. Dengan rujukan yang cepat dan tepat, ibu dan bayi dapat memperoleh perawatan intensif yang diperlukan untuk menghindari risiko komplikasi lebih lanjut.

## **H. Etika Dalam Pemantauan**

---

### **1. Memberikan Informasi kepada Ibu dan Keluarga**

Komunikasi yang jelas dan efektif antara tenaga kesehatan, ibu, serta keluarganya sangat penting dalam proses persalinan. Menjelaskan kondisi ibu dan bayi, serta tindakan medis yang akan dilakukan, harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan atau kecemasan. Dengan memberikan informasi yang jelas, ibu dan keluarga dapat lebih tenang, memahami prosedur yang dijalani, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk memastikan kelancaran persalinan.

### **2. Menjaga Privasi dan Kenyamanan Pasien**

Kenyamanan dan privasi ibu saat persalinan harus selalu dijaga agar proses persalinan berlangsung dengan lebih tenang dan aman. Ruang persalinan harus disiapkan agar nyaman, bersih, serta bebas dari gangguan yang tidak perlu. Selain itu, jumlah orang yang berada di dalam ruangan harus dibatasi sesuai kebutuhan, sehingga ibu merasa lebih leluasa dan tidak stres. Dengan menjaga privasi dan

kenyamanan pasien, proses persalinan dapat berlangsung lebih lancar, serta membantu ibu tetap fokus dan rileks selama menjalani persalinan.

## **I. Penutup**

---

### **Kesimpulan tentang Pentingnya Pemantauan**

Pemantauan yang baik selama kehamilan dan persalinan memiliki peran krusial dalam mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Dengan pemantauan yang tepat, tanda-tanda bahaya dapat dideteksi lebih awal, sehingga intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Hal ini tidak hanya memastikan proses persalinan yang lebih aman, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi ibu, mengurangi risiko stres, dan meningkatkan keberhasilan persalinan.

### **Implikasi bagi Kesejahteraan Ibu dan Bayi**

Pemantauan yang optimal memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ibu dan bayi. Ibu akan merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi persalinan karena mengetahui bahwa kondisinya terus dipantau dan ditangani dengan baik. Selain itu, dukungan yang diberikan selama proses persalinan membantu ibu menjalani persalinan dengan lebih lancar. Bagi bayi, pemantauan yang baik memastikan ia lahir dalam kondisi sehat, dengan intervensi segera jika diperlukan, sehingga peluang tumbuh kembang yang optimal dapat tercapai sejak awal kehidupannya.



## Referensi

- Departemen Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Saifuddin, A. B. (2010). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- WHO. (2018). Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Geneva: World Health Organization.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2018). Williams Obstetrics, 25th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- RCOG. (2022). Green-Top Guidelines: Intrapartum Fetal Surveillance. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
- Oxorn, H., & Foote, C. E. (2010). Human Labor and Birth. Connecticut: Appleton & Lange.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2019). Varney's Midwifery, 6th Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Mochtar, R. (2010). Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi dan Obstetri Patologi. Jakarta: EGC.
- NICE. (2017). Intrapartum Care: Care of Healthy Women and Their Babies during Childbirth. London: National Institute for Health and Care Excellence.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020). Practice Bulletin on Fetal Monitoring. Washington, DC: ACOG.
- ICM. (2014). International Standards for Midwifery Practice. Hague: International Confederation of Midwives.
- WHO. (2015). WHO Partograph Guidelines. Geneva: World Health Organization.
- Bennet, V. R., & Brown, L. K. (2017). Myles Textbook for Midwives, 17th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Panduan Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- NMC. (2015). The Code: Professional Standards of Practice and Behaviour for Nurses and Midwives. London: Nursing and Midwifery Council.
- Buku Kode Etik Profesi Bidan Indonesia (Ikatan Bidan Indonesia).
- WHO. (2019). Maternal and Perinatal Health Guidelines. Geneva: World Health Organization.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewi, R. K., & Suryoputro, A. (2021). Antenatal Care dan Komplikasi Persalinan di Indonesia: Analisis Data SDKI 2017. *Jurnal Bidan Indonesia*, 7(1), 78-85.

- Sari, D. P., & Wulandari, R. D. (2021). Indikator Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Karanganyar Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 9(3), 417-425.
- Pratiwi, I. N., & Kusumastuti, M. (2020). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Kabupaten Semarang. *International Journal of Public Health and Nutrition*, 2(1), 45-52.

## Glosarium

1. **Air Ketuban** – Cairan yang mengelilingi janin dalam rahim dan berfungsi melindungi serta mendukung perkembangan janin.
2. **Anemia** – Kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah ibu lebih rendah dari normal, yang dapat menyebabkan kelelahan dan risiko komplikasi persalinan.
3. **Angka Kematian Ibu (AKI)** – Jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau nifas per 100.000 kelahiran hidup.
4. **Angka Kematian Bayi (AKB)** – Jumlah kematian bayi sebelum usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.
5. **Apgar Score** – Skor yang digunakan untuk menilai kondisi bayi baru lahir berdasarkan lima parameter: warna kulit, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan pernapasan.
6. **Asfiksia Neonatorum** – Kondisi di mana bayi mengalami kesulitan bernapas atau tidak bernapas saat lahir, yang memerlukan resusitasi segera.
7. **Bidan** – Tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian dalam membantu persalinan serta memberikan perawatan ibu dan bayi baru lahir.
8. **CTG (Cardiotocography)** – Alat untuk memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim selama persalinan.
9. **Distosia** – Persalinan sulit atau terhambat yang disebabkan oleh faktor ibu, janin, atau kombinasi keduanya.
10. **Eklampsia** – Kondisi serius pada ibu hamil yang ditandai dengan kejang akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol.
11. **Episiotomi** – Prosedur medis berupa sayatan di perineum untuk memperbesar jalan lahir guna mencegah robekan yang tidak terkontrol.
12. **Fase Aktif** – Tahapan dalam persalinan di mana pembukaan serviks terjadi lebih cepat (sekitar 4-10 cm) dan kontraksi semakin kuat.
13. **Fase Laten** – Tahap awal persalinan ketika pembukaan serviks masih lambat (0-3 cm) dengan kontraksi yang tidak terlalu kuat.
14. **Fetal Distress (Gawat Janin)** – Kondisi di mana janin mengalami kekurangan oksigen yang dapat diketahui melalui perubahan detak jantung janin.
15. **Garis Waspada** – Garis pada partograf yang menunjukkan batas aman dalam pemantauan persalinan sebelum membutuhkan intervensi medis.
16. **Garis Tindakan** – Garis pada partograf yang menandakan bahwa persalinan mengalami penyimpangan dan intervensi segera diperlukan.
17. **Hipoksia Janin** – Kondisi kekurangan oksigen pada janin yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani.

18. **Induksi Persalinan** – Tindakan medis untuk merangsang kontraksi rahim guna memulai atau mempercepat persalinan.
19. **Kala I** – Tahapan pertama dalam proses persalinan yang ditandai dengan pembukaan serviks hingga lengkap (10 cm).
20. **Kala II** – Tahapan persalinan di mana ibu mulai mengejan hingga bayi lahir.
21. **Kala III** – Tahap di mana plasenta keluar setelah bayi lahir.
22. **Kala IV** – Masa pemulihan ibu setelah melahirkan yang berlangsung selama dua jam pertama postpartum.
23. **Kontraksi Uterus** – Gerakan otot rahim yang terjadi selama persalinan untuk membantu bayi keluar dari rahim.
24. **Malpresentasi** – Posisi abnormal janin dalam rahim yang dapat menyulitkan persalinan normal, seperti sungsang atau lintang.
25. **Meconium** – Kotoran pertama bayi yang berwarna hijau kehitaman, bisa menjadi tanda stres janin jika ditemukan dalam air ketuban sebelum lahir.
26. **Obstetri** – Cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kehamilan, persalinan, dan periode postpartum.
27. **Oxytocin** – Hormon yang merangsang kontraksi rahim dan sering digunakan dalam induksi atau augmentasi persalinan.
28. **Partograf** – Alat pencatatan visual yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan serta kondisi ibu dan janin.
29. **Perdarahan Postpartum** – Kehilangan darah lebih dari 500 mL setelah persalinan normal atau lebih dari 1.000 mL setelah operasi caesar.
30. **Perineum** – Daerah antara vagina dan anus yang dapat mengalami robekan saat melahirkan.
31. **Plasenta Previa** – Kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, menyebabkan risiko perdarahan.
32. **Postpartum** – Periode setelah melahirkan yang berlangsung hingga enam minggu pertama setelah persalinan.
33. **Preeklamsia** – Kondisi tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin.
34. **Presentasi Janin** – Bagian tubuh janin yang pertama kali memasuki jalan lahir, misalnya kepala (presentasi kepala) atau bokong (presentasi sungsang).
35. **Primigravida** – Wanita yang sedang hamil untuk pertama kalinya.
36. **Prolapsus Tali Pusat** – Kondisi di mana tali pusat keluar lebih dahulu sebelum janin, yang bisa menyebabkan gangguan oksigenasi janin.
37. **Puerperium** – Masa setelah persalinan hingga tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil.

38. **Sectio Caesarea (SC)** – Operasi caesar, prosedur bedah untuk melahirkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim ibu.
39. **Serviks** – Bagian bawah rahim yang mengalami pembukaan selama persalinan agar bayi bisa keluar.
40. **Tekanan Darah Ibu** – Parameter yang harus dipantau selama kehamilan dan persalinan karena dapat menunjukkan kondisi seperti preeklamsia.
41. **Uterotonika** – Obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim, sering diberikan untuk mencegah perdarahan postpartum.
42. **Vaginal Toucher (VT)** – Pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan serviks dan posisi janin selama persalinan.
43. **Vulva** – Bagian luar dari sistem reproduksi wanita yang meliputi labia dan klitoris.

# BAB VI

## EDUKASI TENTANG PERAWATAN PASCA PERSALINAN

---

### A. Pendahuluan

---

Edukasi merupakan proses belajar yang sudah direncanakan untuk mengubah perilaku dan menambah pengetahuan seseorang. Dengan edukasi kita dapat mempengaruhi seseorang agar melakukan apa yang kita harapkan (KBBI). Edukasi ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada buku ini kita akan membahas edukasi tentang pasca persalinan, strategi pendidikan kesehatan yang dilanjutkan setelah kelahiran terbukti berkontribusi pada peningkatan hasil kesehatan ibu dan anak. Orang tua perlu diberikan materi pendidikan setelah kelahiran untuk membantu memberikan pengetahuan dalam mengidentifikasi potensi masalah kesehatan.

### B. Edukasi Tentang Pasca Persalinan

---

Menjadi ibu baru atau ibu setelah bersalin adalah masa transisi kehidupan utama bagi perempuan. Diharapkan dalam masa transisi ini ibu sehat dan mengetahui apa yang harus dilakukan pada pasca bersalin (Jueningsih dkk,2022). Edukasi pasca persalinan sangat diperlukan oleh ibu demi menjalani proses pasca persalinan dengan sehat dan aman.

### C. Macam – Macam Edukasi Tentang Perawatan Pasca Persalinan

---

Ada beberapa Edukasi yang harus diberikan kepada ibu pasca persalinan diantaranya adalah:

1. Edukasi perawatan jahitan perineum
2. Edukasi perawatan payudara dan cara meneteki yang benar
3. Edukasi perawatan bayi sehari-hari
4. Edukasi gizi ibu pasca persalinan
5. Edukasi pemakaian alat kontrasepsi.
6. Edukasi pemberian ASI Eksklusif

Edukasi suportif sangatlah diperlukan dalam masa pasca persalinan agar ibu dapat melakukan perawatan pasca persalinan secara mandiri, edukasi pendidikan tentang perawatan pasca persalinan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, demonstrasi, ceramah dan media cetak seperti leaflet, lembar balik juga poster, (Bobak,2015)

Pemahaman ibu mengenai perawatan diri setelah melahirkan sebaiknya dimulai lebih awal agar ibu siap untuk melewatinya. Dengan meningkatkan pendidikan pengetahuan dan keterampilan ibu tentang perawatan setelah melahirkan maka terbentuk kepercayaan diri ibu dalam merawat dirinya sendiri dan bayi yang dilahirkan, membentuk ikatan batin antara ibu dan bayi(bonding) serta ibu menjadi lebih maksimal dalam merawat anaknya. (Saleh A, 2010)

#### D. Edukasi Perawatan Jahitan Perineum

---



**D.1 Gambar** edukasi perawatan jahitan perineum

Penjahitan perineum adalah tindakan untuk merapatkan atau mendekatkan jaringan tubuh dan mencegah terjadinya pendarahan hingga terjadi proses Penjahitan luka adalah proses menghubungkan jaringan tubuh (mendekatkan) dan mencegah hilangnya darah yang berlebihan (memastikan hemostasis) sampai luka tersebut sembuh dengan baik. Ruptur perineum adalah robekan pada perineum selama proses kelahiran.(Luh Putih Widiastini, 2018)

Lama penyembuhan luka perineum secara normal memerlukan waktu antara 7 hingga 10 hari, namun jika terjadi infeksi, proses penyembuhannya akan terhambat, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor yaitu, umur ibu, indeks masa tubuh (IMT), hemoglobin (Hb). (Supiani, 2024)

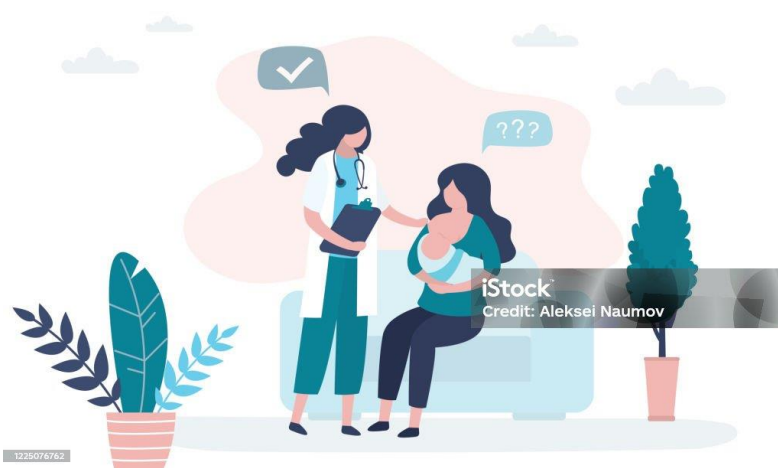
Luka episiotomy pada ibu pasca bersalin adalah area yang harus dijaga kebersihannya dan tetap kering. Infeksi dapat terjadi pada jahitan perineum sehingga jahitan perineum harus dirawat dengan baik. Dalam hal ini tenaga kesehatan harus memberikan edukasi tentang perawatan jahitan perineum termasuk memberikan nasehat kepada ibu pasca persalinan agar selalu menjaga perineum tetap bersih untuk mencegah terjadinya infeksi.

Cara perawatan jahitan perineum yang bisa dilakukan pada ibu nifas selama 10 hari :

1. Mengganti softek setiap 4-6 jam.
  2. Melepaskan softek dari arah depan ke belakang untuk menghindari penyebaran bakteri dari anus ke vagina.
  3. Membersihkan daerah sekitar vulva dari depan ke belakang, membersihkan daerah sekitar anus. bilas dengan air hangat atau cairan anti septik pada area perineum setelah buang air besar. Keringkan dengan handuk dari arah depan ke belakang.
  4. Jangan dipegang sampai area tersebut pulih.
  5. Membersihkan vulva dan vagina setiap selesai BAK dan BAB
  6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan genetalia
  7. Rasa gatal di sekitar jahitan adalah hal yang wajar dan menandakan proses penyembuhan. Akan tetapi, untuk mengurangi ketidaknyamanan, Tangani dengan berendam di air hangat atau menggunakan kompres dingin dari kain yang telah didinginkan.
  8. Berbaringlah miring Untuk mengurangi tekanan pada daerah tersebut, hindari berdiri dan duduk terlalu lama
  9. Lakukan Latihan kegel, untuk merangsang peredaran daerah disekitar perineum guna mempercepat penyembuhan dan memperbaiki fungsi otot-otot.
- (Riza Savita, 2022)

## **E. Edukasi Perawatan Payudara Dan Cara Meneteki Yang Benar**

---



**E.1 Gambar** edukasi perawatan payudara

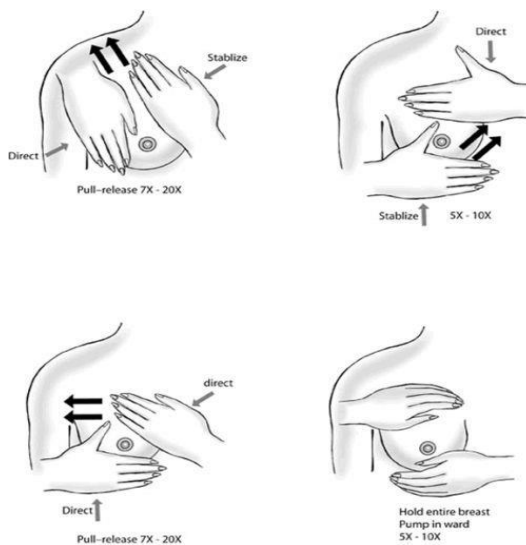
Perawatan payudara adalah tehknik perawatan payudara khususnya pada pasca persalinan agar ASI keluar dengan lancar. Payudara dirawat tidak hanya



dilakukan saat hamil, tetapi perlu dilakukan pada pasca persalinan. (Riza Savita, 2022)

Merawat payudara bertujuan agar sirkulasi darah lancar, mencegah sumbatan saluran susu sehingga ASI keluar dengan lancar. Selain itu Kebersihan payudara juga harus dijaga, daerah areola dan papilla mammae (puting susu) harus dalam keadaan bersih sebelum disusukan bayi karena payudara yang bersih dapat mencegah infeksi yang disebabkan kotoran, jamur dan bakteri. Isapan bayi dapat merangsang kelenjar dan hormon prolactin serta oksitosin (Yenni Auliya, 2021)

Cara merawat payudara yaitu dimulai dengan memakai 2 handuk, handuk yang pertama dipasang dari bahu ke daerah ketiak, kemudian handuk yang ke dua diletakkan dipangkuan ibu. Selanjutnya, puting dikompres dengan kapas yang di beri baby oil / minyak kelapa biarkan selama 3-5 menit, kemudian bersihkan dengan cara memutar. Perhatikan apakah puting kotor, bila kotor bersihkan kembali menggunakan kapas yang telah diberi baby oil / minyak kelapa. Tuangkan minyak kelapa / baby oil pada kedua telapak tangan, lakukan gerakan pengurutan 20-30 kali untuk tiap payudara sebanyak 2 kali sehari, bila ibu sudah memahami meminta ibu untuk melakukan perawatan payudara pagi dan sore (Mufdlilah, 2017)

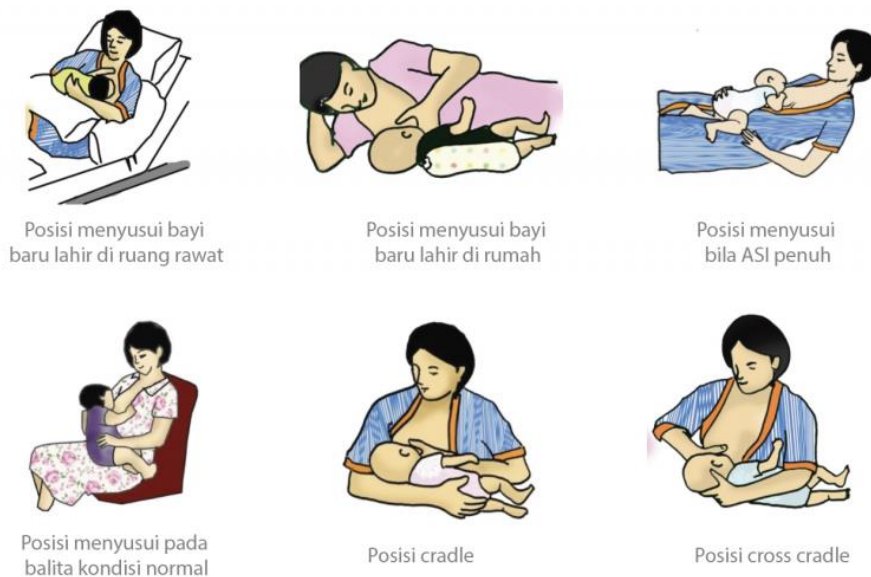


**E.2 Gambar** cara perawatan payudara



**E.3 Gambar** posisi menyusui dengan benar

Langkah-langkah teknik atau cara menyusui dengan baik dan benar :



#### E.4 Gambar posisi ibu menyusui dengan benar

1. Ibu duduk di kursi dengan bersandar. Perhatikan posisi kaki ibu pada saat duduk jika kaki ibu tergantung maka kaki ibu harus disanggah sehingga ibu merasa nyaman pada saat menyusui bayinya.
2. Sebelum disusukan bayi keluarkan ASI secukupnya dan oleskan pada puting dan areola. Hal ini dapat menjaga kelembapan puting susu sehingga terhindar dari puting lecet.
3. Bayi diletakkan di atas pangkuan ibu dengan menyanggah menggunakan bantal sehingga dapat menopang bayi dengan cara
  - a. Satu lengan ibu (kiri) memegang bayi dengan posisi kepala bayi diletakkan pada lengkungan siku ibu.
  - b. Lengan bayi sebelah kanan diletakkan di belakang badan ibu serta satu tangan lagi (kiri) berada di depan ibu.
  - c. Posisi perut bayi harus menempel ke badan ibu sehingga kepala bayi menghadap payudara ibu.
  - d. Lengan dan telinga bayi terletak pada satu garis lurus.
  - e. Pada saat proses menyusui sebaiknya ibu menatap dan memberikan asupan pada bayi dengan penuh kasih sayang.
4. Salah satu tangan (kanan) menyangga payudara bagian kiri dan keempat jari dan ibu jari menekan payudara bagian atas aerola atau tangan membentuk huruf "C" dan sebaliknya bergantian antara payudara kiri dan kanan.
5. Bayi diberikan rangsangan untuk membuka mulutnya (rooting refleks) dengan teknik atau cara menyentuh salah satu bagian pipi dan mendekatkan ke puting

atau melakukan sentuhan pada bagian atau sudut mulut bayi dengan menggunakan jari kelingking.

6. Segera dekatkan mulut bayi ke payudara ibu setelah bayi membuka mulutnya.
7. Dianjurkan puting serta aerola sekitarnya masuk semua ke dalam mulut bayi, sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi yang akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan atau penyampinan ASI yang terletak dibawah aerola.
8. Usahakan bayi menyusui sampai payudara terasa kosong, dan lanjutkan susui bayi pada payudara yang lain atau masih terasa penuh.
9. Setelah selesai bayi menyusui lepaskan isapan dengan cara ;
  - a. Letakkan jari kelingking ibu pada satu sisi atau sudut mulut bayi dan tekan sedikit sampai bayi melepaskan payudara kemudian tarik payudara secara perlahan atau
  - b. Tarik atau tekan dagu bayi ke arah bawah
  - c. Setelah isapan bayi lepas selanjutnya keluarkan ASI sedikit dan oleskan pada sekitar areola dan puting susu, biarkan sampai kering.
  - d. Selanjutnya sendawakan bayi dengan tujuan agar bayi tidak muntah atau gumoh karena pada saat disendawakan maka udara dari lambung keluar dengan cara atau teknik berikut ini:
    - 1) Gendong bayi dengan posisi tegak dan bersandar di bahu ibu selanjutnya tepuk perlahan-lahan punggung bayi.
    - 2) Letakkan bayi pada pangkuan ibu dengan posisi terlungkup, kemudian punggung bayi di usap secara perlahan-lahan sehingga bayi bersendawa.



E.5 Gambar variasi posisi menyusui

10. Setelah isapan bayi lepas selanjutnya keluarkan asi sedikit dan oleskan pada sekitar aerola dan puting susu, biarkan sampai kering.

11. Selanjutnya sendawakan bayi dengan tujuan agar bayi tidak muntah dan gumoh karena pada saat disendawakan maka udara dari lambung keluar dengan cara atau tehnik berikut ini:
  - a. Gendong bayi dengan posisi tegak dan bersandar dibahu ibu selanjutnya tepuk perlahan-lahan punggung bayi
  - b. Letakkan bayi pada pangkuan ibu dengan posisi telungkup, kemudian punggung bayi diusap secara perlahan-lahan sehingga bayi bersendawa. (Junaida Rahmi, 2024)

## **F. Edukasi Perawatan Bayi Sehari -hari**

---



**F.1 Gambar** edukasi perawatan bayi sehari-hari

Bayi merupakan anak yang berumur antara 0 hingga 12 bulan. Perawatan bayi merupakan tindakan menjaga dan merawat dan memperhatikan kesehatan bayi di aspek preventif dan kuratif. Merawat bayi baru lahir sangat krusial dilakukan setelah kelahiran dan bermanfaat bagi ibu serta bayi, seperti mempercepat pemulihan organ tubuh ibu yang mengalami perubahan selama kehamilan serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak (bonding).



**F.2 Gambar** perawatan bayi sehari-hari

Memandikan bayi adalah salah satu perawatan bayi sehari-hari yang dilakukan oleh seorang ibu. Memandikan bayi baru lahir dilakukan pada saat suhu tubuh bayi stabil yaitu 36,5o celcius - 37,5o celcius. Tujuan perawatan bayi sehari-hari memelihara perasaan aman dan nyaman pada bayi, menurunkan angka mortalitas dan morbiditas, bayi yang sehat harus mendapatkan perawatan yang optimal. Memandikan bayi membuat bayi tetap bersih, bayi merasa nyaman dan juga mengurangi risiko terjadinya infeksi, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga dan merawat integritas kulit, dan menjaga suhu dan kenyamanan bayi. (Firda Fadilah dkk, 2023)



**F.3 Gambar** cara memandikan bayi

**Cara memandikan bayi yaitu sebagai berikut :**

1. Siapkan alat –alat terlebih dahulu sebelum mulai memandikan bayi.
2. Memandikan bayi dengan air hangat 2 kali sehari atau 1 kali sehari sesuai kebutuhan.
3. Bila perlu, ukurlah suhu bayi sebelum memandikannya. Suhu bayi normal adalah 36,5-37,5 derajat celsius.
4. Bersihkan mata bayi dengan kapas mata dari dalam keluar
5. Bersihkan pantat dari tinja sebelum dimandikan agar air mandi tetap bersih
6. Bayi disabun mulai dari leher, dada, perut (tali pusat di sabun dari ujung ke pangkal) dilanjutkan ke bagian kaki, terakhir kepala dan lengan.
7. Kemudian di bilas dengan air bersih
8. Keringkan bayi dengan handuk
9. Setelah mandi, hindari penggunaan bedak dan gurita pada bayi.
10. Rawat tali pusat, dikeringkan dengan kasa steril
11. Bayi diberikan pakaian lengkap. (Firda Fadilah dkk, 2023)

Perawatan tali pusat adalah langkah perawatan yang bertujuan menjaga tali pusat bayi baru lahir tetap kering dan mencegah infeksi. Perawatan tali pusat yang tidak tepat pada bayi dapat mengakibatkan infeksi yang dapat berujung pada kematian. Penyakit ini disebabkan oleh masuknya spora kuman tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat yang tidak steril, penggunaan obat-obatan, atau bubuk dan daun yang ditaburkan ke tali pusat sehingga dapat memicu infeksi. Waktu merawat tali pusat adalah setelah mandi pagi atau sore, serta kapan saja jika penutup tali pusat basah karena kencing, lakukan ini hingga tali pusat puput atau kering. (Ika Suherlin dkk, 2024)

Gejala infeksi tali pusat meliputi bagian pangkal tali pusat atau daerah sekitarnya berwarna merah, keluarnya cairan berbau dan bernanah, adanya darah yang terus-menerus keluar, kejang, serta bayi mengalami demam. (Ika Suherlin dkk, 2024)



**F.4 Gambar** cara perawatan tali pusat



**Cara perawatan tali pusat yaitu sebagai berikut :**

1. Selalu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat dan alat kelamin.
2. Biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering.
3. Saat mandi, bersihkan tali pusat dengan sabun.
4. Setelah selesai, keringkan dengan handuk lembut atau cukup diangin-anginkan.
5. Jangan membungkus tali pusat dengan apapun. Jaga agar tali pusat selalu kering.
6. Jaga selalu kebersihannya apabila tali pusat sudah lepas (puput).
7. Perhatikan kebersihan pada lipatan paha. Jaga agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak.
8. Hindari:
  - a. Sering menyentuh tali pusat dan tangan tidak bersih
  - b. Menutupi tali pusat dengan apapun
  - c. Membersihkan dengan alkohol ( Gusti Ayu Marhaeni dkk, 2017)

**G. Edukasi Gizi Pasca Persalinan**

---



**G.1 Gambar** edukasi gizi pasca persalinan

Gizi adalah rangkaian atau proses pemanfaatan makanan yang biasanya dikonsumsi oleh organisme melalui berbagai tahap, yaitu pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran. Gizi mengandung zat gizi yang merupakan senyawa kimia penting yang dibutuhkan oleh organ tubuh agar dapat menjalankan fungsi masing-masing organ tersebut. Peran zat gizi meliputi menghasilkan energi, membangun, memelihara, dan mengatur berbagai proses kehidupan. (Ana Samiatul Milah, 2019)

Nutrisi sangat penting bagi ibu setelah melahirkan karena dapat memengaruhi produksi ASI dan proses pemulihan ibu pasca persalinan. Jika ibu setelah melahirkan mengalami malnutrisi, maka ibu tersebut berisiko terkena penyakit seperti anemia. Peristiwa tersebut menyebabkan bayinya mengalami masalah pertumbuhan dan

perkembangan, sehingga bayi rentan sakit dan terjangkit infeksi. Kekurangan gizi dapat dihindari dengan merancang menu yang seimbang untuk ibu setelah melahirkan. (Itiyani 2013)

Zat gizi yang dianjurkan setelah melahirkan:

**Perbandingan Kebutuhan Zat Gizi Wanita Tidak Hamil, Hamil dan Menyusui**

| Makanan        | Normal | Hamil | Menyusui |
|----------------|--------|-------|----------|
| Kalori (kal)   | 2500   | 2500  | 2500     |
| Protein (grm)  | 60     | 85    | 100      |
| Kalsium (grm)  | 0,8    | 1,5   | 2        |
| Feerum (Fe)    | 12     | 15    | 15       |
| Vitamin A (IU) | 5000   | 6000  | 8000     |
| Vitamin B (mg) | 1,5    | 1,8   | 2,3      |
| Vitamin C (mg) | 70     | 100   | 150      |
| Vitamin D (SI) | 2,2    | 2,5   | 3        |
| Riboflavin     | 15     | 18    | 23       |
| Asam nikotin   | -      | 600   | 700      |

**Kebutuhan Makanan Ibu Menyusui dalam Sehari**

| Bahan Makanan   | Bayi Umur 0-6 Bulan | Bayi Umur 7-12 Bulan | Bayi Umur 13-24 Bulan |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Nasi/pengganti  | 5 piring            | 4 ½ piring           | 4 piring              |
| Ikan/pengganti  | 2 ½ ptg             | 2 ptg                | 3 ptg                 |
| Tempe/pengganti | 5 ptg               | 4 ptg                | 5 ptg                 |
| Sayuran         | 3 mangkuk           | 3 mangkuk            | 3 mangkuk             |
| Buah            | 2 ptg               | 2 ptg                | 2 ptg                 |
| Susu/pengganti  | 1 gls               | 1 gls                | 1 gls                 |
| Air             | 8 gls               | 8 gls                | 8 gls                 |

## **G.2 Gambar** contoh kebutuhan makanan ibu setelah melahirkan

Sumber: Mayang Chyntaka, Dewi Eka Stia Murni, 2023

### 1. Karbohidrat

Berfungsi untuk memenuhi energi tubuh setelah kelahiran. karbohidrat komplek seperti sereal roti gandum, dan nasi merah lebih dianjurkan daripada karbohidrat sederhana seperti permen permen manis.

### 2. Protein

Sangat diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga massa otot. Sumber protein terdiri dari putih telur daging tanpa lemak, susu, kacang kacangan, tahu, dan tempe. Dibutuhkan 100 gram/hari.

### 3. Lemak

Berperan dalam menjaga suhu tubuh dan meningkatkan penyerapan vitamin a,d,e, dan k, sumber lemak sehat antara lain minyak zaitun, minyak ikan, minyak kenola, dan alpukat.



#### 4. Omega >3

Digunakan senyawa antiradang yang juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan berperan meningkatkan kecerdasan anak sumbernya berasal dari lele sarden, tuna, salmon, serta minyak ikan.

#### 5. Vitamin dan Mineral

Berfungsi dalam proses pemulihan tubuh serta meningkatkan kualitas dan jumlah ASI, menjaga sistem kekebalan tubuh, berperan juga dalam tumbuh kembang bayi, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumbernya berasal dari sayuran hijau, buah buahan, telur, produk susu, rendah lemak, dan suplemen

#### 6. Zat besi

Berperan meningkatkan dan menjaga kepadatan tulang pada ibu menyusui dan juga mendukung pertumbuhan tulang si kecil, sumber kalsium yang baik antara lain produk susu serta sayuran berwarna hijau gelap seperti brokoli dan bayam

#### 7. Kalsium

Berfungsi menjaga kepadatan tulang ibu menyusui dan juga mendukung pertumbuhan tulang si kecil. Sumber kalsium berasal dari sayuran berwarna hijau gelap brokoli dan bayam. Dibutuhkan 2 gram/harinya. (Mayang Chyntaka, Dewi Eka Stia Murni, 2023)

### H. Edukasi Tanda Bahaya Pasca Persalinan

---



**H.1** Edukasi tanda bahaya pasca persalinan

Masa Pasca Persalinan adalah periode yang berisiko tinggi untuk kematian ibu, sekitar 60% kematian ibu berlangsung setelah melahirkan, dan hampir 50% dari kematian pasca persalinan ibu terjadi dalam 24 jam pertama. Faktor penyebab kematian ibu antara lain disebabkan oleh komplikasi setelah melahirkan, seperti pendarahan pasca persalinan dan infeksi. (Riadinata Shinta Puspitasari, 2023)

Tanda bahaya pasca persalinan adalah tanda abnormal yang mengindikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. (Riadinata Shinta Puspitasari, 2023)

Sebagian besar kematian ibu terjadi selama masa pasca persalinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu dan keluarganya mengenal tanda bahaya dan perlu mencari pertolongan kesehatan. Beberapa macam bahaya ibu nifas, meliputi:



**H.2 Gambar** Tanda bahaya pada ibu pasca persalinan

1. Perdarahan pervaginam yang luar biasa banyak atau tiba-tiba bertambah banyak (lebih banyak dari perdarahan haid biasa atau bila memerlukan penggantian pembalut dua kali dalam setengah jam atau yang melebihi 500 ml)
2. Pengeluaran pervaginam yang baunya menusuk
3. Rasa sakit bagian bawah abdomen atau punggung
4. Sakit kepala yang terus menerus, nyeri ulu hati, atau masalah penglihatan
5. Pembengkakan di wajah atau tangan
6. Demam, muntah, rasa sakit waktu buang air kecil, atau merasa tidak enak badan
7. Payudara yang berubah merah, panas, dan terasa sakit
8. Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama
9. Rasa sakit, merah, nyeri tekan, atau pembengkakan kaki
10. Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya atau diri sendiri
11. Merasa sangat letih atau nafas terengah-engah (Buku KIA, Hal 28)

## I. Edukasi Pemakaian Alat Kontrasepsi

---



**I.1 Gambar** Edukasi pemakaian alat kontrasepsi

Kontrasepsi diartikan sebagai pencegahan konsepsi yang di sengaja melalui penggunaan berbagai perangkat, praktik seksual, bahan kimia, obat-obatan atau prosedur bedah. Dengan demikian setiap alat atau Tindakan yang bertujuan untuk mencegah seorang Wanita hamil dapat dianggap sebagai alat kontrasepsi dalam konteks social apapun, kontrasepsi yang efektif memungkinkan pasangan untuk melakukan hubungan fisik tanpa rasa takut akan kehamilan yang tidak di inginkan dan memastikan kebebasan untuk memiliki anak bila di inginkan. ( Arif Rohman Mansyur 2022)

Tujuan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan yaitu :

1. Mengatur kehamilan yang tidak di inginkan pada Perempuan muda dan tua  
Ketika besarnya resiko kematian ibu dan bayi
2. Mengurangi angka kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi
3. Mengurangi kejadian aborsi khususnya aborsi tidak aman
4. Memberikan waktu pemulihan
5. Mengatur jarak kehamilan
6. Meningkatkan kesehatan mental
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
8. (DR. Yunita amraeni S.KM.M.KES 2022)

Macam-macam alat kontrasepsi yang bisa digunakan pasca persalinan yaitu :

1. MAL (Metode Amenore Laktasi)

Metode MAL merupakan metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif, artinya hanya memberikan asi saja tanpa memberikan makanan dan minuman lainnya. Metode

ini dapat dikatakan metode KB alamiah apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain.

## 2. Suntik progestin

Suntik bahan yang menyerupai hormon progesterone ini tidak mengganggu prosuksi ASI. Terdapat dua macam suntik progestin yaitu: Depo medroksiprogesteron Asetat yang diberikan setiap 3 bulan di daerah bokong dan Depo Noretisteron Enatat yang diberikan setiap 2 bulan. (Lizar Ananda, 2023)

## 3. Pil KB

Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang mekanisme kerjanya mencegah pelepasan sel telur yang telah di reproduksi sehingga tidak terjadi pembuahan. Komposisi pil KB berbentuk kemasan untuk dikonsumsi selama 28 hari terdiri dari 21 tablet berwarna kuning, setiap tablet mengandung 0,15 Gr hormon progestin 0,03 MI mengandung hormon ekstrogen dan 7 tablet salut gula berwarna putih tidak mengandung hormon. Pil KB diminum setiap hari sampai pil habis.

Dari selain 3 metode diatas ada juga metode jangka Panjang yang dapat digunakan yaitu :

### 1. IUD (intra uteri device)

Alat kontrasepsi kecil yang dimasukkan kedalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD bekerja dengan mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur serta mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau bisa ditunda sampai 4 minggu pasca melahirkan. IUD bisa digunakan selama 5-10 tahun.

### 2. Implant

Kontrasepsi implant merupakan kontrasepsi hormonal jangka Panjang yang efektif mampu mencegah kehamilan antara 3-5 tahun. Implant bekerja dengan menghambat ovulasi, menebalkan lender serviks, menipiskan lapisan endometrium sehingga mencegah pertemuan sperma dan sel telur. Bagi ibu yang melahirkan secara normal pemasangan implanat bisa dilakukan segera setelah melahirkan asalkan tidak ada kontraindikasi medis. Jika ibu menyusui implant bisa dipasang 6 minggu- 6 bulan pasca melahirkan tanpa memerlukan kontrasepsi tambahan terutama ibu jika menyusui secara eksklusif. (Setiasih 2020)

## J. Edukasi Pemberian Asi Eksklusif

---



**J.1 Gambar** Edukasi pemberian ASI eksklusif

ASI adalah makanan ideal yang memiliki kandungan nutrisi yang cocok dengan kebutuhan bayi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. ASI eksklusif adalah memberikan ASI tanpa makanan atau minuman lain. ASI disarankan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. (Edita Linda, 2019)

ASI mengandung nutrisi untuk pertumbuhan, kecerdasan, zat imun (melindungi dari berbagai penyakit) dan mampu membangun ikatan kasih sayang antara bayi dan ibu, menunda kehamilan, mengurangi risiko kanker payudara serta menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi ibu; di sisi ekonomi, bagi keluarga, ASI juga dapat menekan pengeluaran untuk pembelian susu. (Edita Linda, 2019)

Kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan *superfood* yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI pada dasarnya mengandung komponen makro dan mikro nutreins. ASI sendiri terdiri dari 90% nya air. Komposisi dan volume ASI berbeda tergantung kebutuhan dari bayi itu sendiri. Berikut adalah kandungan ASI:

### 1. Karbohidrat

Salah satu bagian utama dari karbohidrat dalam ASI adalah laktosa yang berguna sebagai sumber energi untuk otak bayi. Laktosa dalam asi memiliki konsentrasi paling tinggi jika dibandingkan dengan susu formula.

### 2. Protein

Protein yang terkandung pada ASI mengandung protein *whey* dan *casein*. Kandungan protein pada ASI lebih tinggi jika dibandingkan dengan komposisi susu formula.

3. Lemak

Bayi juga membutuhkan kadar lemak yang tinggi yang berguna untuk mendukung pertumbuhan otak. Asam lemak esensial juga merupakan bagian yang sangat diperlukan bayi untuk sintesis membran sel.

4. Karnitin

ASI juga mengandung karnitin yang memiliki fungsi dalam proses membantu pembentukan energi yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh bayi. Kadar karnitin pada kolostrum lebih tinggi dibandingkan ASI peralihan dan matur

5. Vitamin A

Vitamin A dalam ASI memiliki fungsi untuk kesehatan mata, mendukung pembelahan sel, kekebalan tubuh dan pertumbuhan bayi.

6. Vitamin D

Kandungan vitamin D pada ASI jumlahnya sedikit. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan vitamin D yaitu dengan berjemur di pagi hari supaya bayi terhindar dari kekurangan vitamin D yang menyebabkan penyakit tulang

7. Vitamin E

Vitamin E berperan dalam mempertahankan dinding sel darah merah bayi yang jika kekurangan vitamin E akan menyebabkan terjadinya kekurangan darah (anemia hemolitik)

8. Vitamin K

Vitamin K memiliki fungsi dalam faktor pembekuan darah. Pada ASI kadar vitamin K lebih sedikit jika dibandingkan susu formula. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah membuat program dimana setiap bayi yang baru lahir harus diberikan vitamin K baik yang diberikan suntikan maupun oral.

9. Vitamin yang larut dalam air

Vitamin B, asam folat, vitamin C merupakan kandungan vitamin yang larut dalam air.

10. Mineral

Kandungan mineral utama yang terdapat di dalam ASI adalah kalsium. Pertumbuhan jaringan otot, pembekuan darah, transmisi jaringan saraf merupakan fungsi dari pemberian kalsium yang ada pada ASI. (Junaida Rahmi,2024)

Cara pemberian ASI eksklusif adalah:

1. Menyusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama usia bayi, yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman lainnya



- Memperhatikan kecukupan gizi dalam makanan ibu menyusui sehari-hari. Ibu menyusui perlu makan 1 ½ kali lebih banyak dari biasanya (4-6 piring) dan minum minimal 10 gelas sehari
- Cukup istirahat (tidur siang/ berbaring 1-2 jam), menjaga ketenangan pikiran dan menghindari kelelahan fisik yang berlebihan agar produksi ASI tidak terhambat
- Jika bayi tidur, ibu ikut tidur atau istirahat juga
- Pengertian dan dukungan keluarga terutama suami penting untuk menunjang keberhasilan menyusui
- Mengatasi bila ada masalah menyusui (payudara bengkak, bayi tidak mau menyusu, puting lecet dan lain-lain) (Marni Br Karo, 2021)

Cara pemerahan ASI:

IBU MENYUSUI

**CARA MEMERAH DAN MENYIMPAN ASI** ☐



Cuci tangan dengan sabun sebelum pemerahan ASI



Sebelum diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat













Gunakan gelas kaca/keramik dan mangkok kaca/keramik jangan menggunakan bahan dari plastik ataupun melamin.

**Penyimpanan ASI Perah (ASIP)**

| Tempat Penyimpanan                         | Suhu              | Lama Penyimpanan     |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ASI baru diperah disimpan dalam cooler bag | 15 °C             | 24 jam               |
| Dalam Ruangan (ASIP Segar)                 | 27°C s/d 32 °C    | 4 jam                |
|                                            | < 25 °C           | 6 – 8 jam            |
| Kulkas                                     | < 4 °C            | 48–72 jam (2–3 hari) |
| Freezer pada lemari es 1 pintu             | –15 °C s/d 0 °C   | 2 minggu             |
| Freezer pada lemari es 2 pintu             | –20 °C s/d –18 °C | 3 – 6 bulan          |

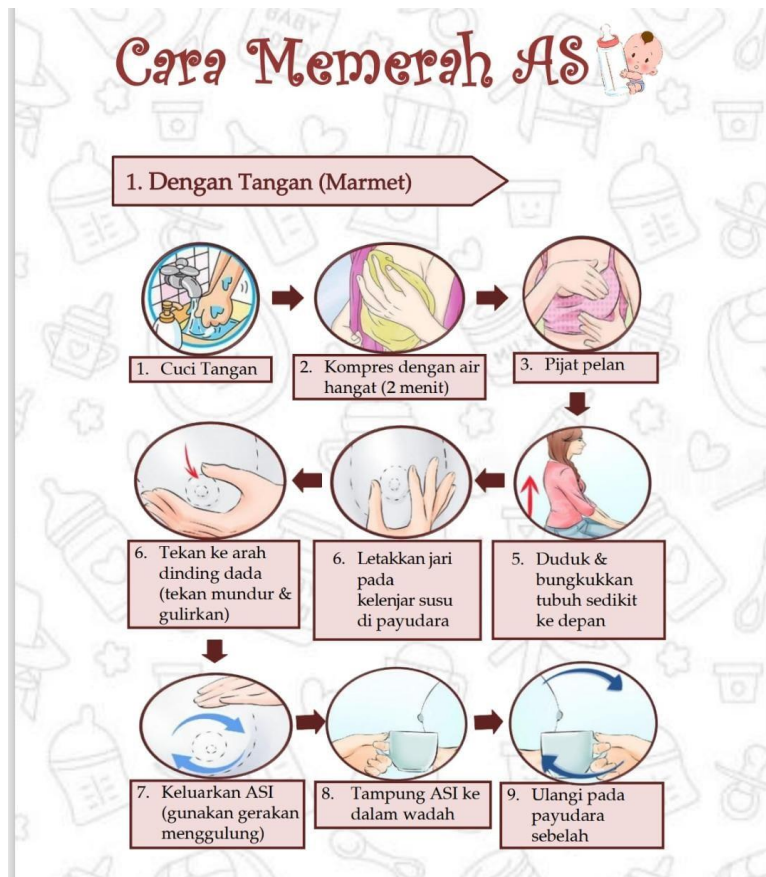
*Catatan:*

- Simpan ASI Perah sebanyak 15–60ml per wadah untuk menghindari ASI Perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi.
- Hindari ASI Perah mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrem

31

## J.2 Gambar Cara pemerahan ASI

Sumber: Buku KIA Hal 31



### J.3 Gambar Cara memerah ASI 2

Sumber: Dewi Andarianingsih dkk, 2021

Cara memompa ASI dengan pompa asi (Breast Pump):

1. Cuci tangan
2. Pastikan alat yang akan digunakan bersih
3. Pastikan posisi yang nyaman
4. Letakkan alat isapnya di payudara
5. Tekan pegangannya jika menggunakan pompa ASI manual, atau hanya cukup menghidupkan mesin untuk pompa ASI elektrik.
6. Pompa ASI akan menekan payudara dan menyimpan ASI dalam botol yang terpasang
7. Sebaiknya cuci dengan air panas dan sabun sebelum dan sesudah pompa digunakan agar pompa tetap steril. (Dewi Andarianingsih dkk, 2021)

Tips & cara menjaga hasil perahan tetap stabil:

1. Perah asi 2-3 jam sekali
2. Jaga asupan cairan tubuh
3. Jaga nutrisi makanan
4. Selalu berfikir positif
5. Mindset ASI cukup
8. Suasana hati yang bahagia (Dewi Andarianingsih dkk, 2021)



Cara menyimpan ASI perah:

1. Menyimpan ASI perah dianjurkan menggunakan botol kaca karena lemak ASI tidak menempel dikaca
2. Isi botol 2/3 bagian saja karena tutup akan terlepas jika terlalu penuh dan agar botol tidak pecah
3. Media kantong plastik khusus untuk menyimpan selama 3 hari (72 jam) saja dan tidak dibekukan, karena rawan bocor, robek dan lemak ASI bisa menempel pada kantong plastik
4. Simpan ASI perah per porsi (satu kali minum), sesuaikan dengan kebutuhan bayi
5. Tulis tanggal dan jam asi di perah pada botol atau kantong ASI, untuk memastikan mana yang lebih dahulu akan digunakan. (Dewi Andarianingsih dkk, 2021)

Cara menyimpan ASI perah saat bepergian:

1. Gunakan kantong ASI pre-sterilized
2. Bawa ASI tidak rusak, bawa ice pack atau ice gel atau cooler bag
  - a. Ice pack tahan 8 jam
  - b. Ice gel tahan 12-18 jam
  - c. Cooler bag tahan 24 jam
3. Sebaiknya ASIP tidak dibekukan selama perjalanan. Karena jika sudah cair akan bertahan 24 jam. (Dewi Andarianingsih dkk, 2021)

## Referensi

- Apriyanti, A.(2012),,, GAMBARAN PERAWATAN PAYUDARA PADA IBU NIFAS DI BPS SRI SUGIYARTININGSIH TAWANGMANGU KARANGANYAR TAHUN 2011", *maternal*.
- Ana Samiatul Milah. (2019). Nutrisi ibu dan anak: gizi untuk keluarga. *Edu Publisher*, 3, Jawa Barat.
- Bahiyatun. (2009). Buku ajar asuhan kebidanan nifas normal. *Buku kedokteran EGC*, 78-79. Jakarta.
- Bahiyatun. (2009). Buku ajar asuhan kebidanan nifas normal. *Buku kedokteran EGC*, 114. Jakarta.
- Bobak, dkk. (2015). Buku Ajar Keperawatan Maternitas .Jakarta.EGC
- DR. Amraeni Yunita S.KM.M.KES. (2022). Otonomi Reproduksi dan kontrasepsi. *PT Nasya Expanding Management Jawa Tengah*.
- Dr. Raissa edwina Djuanda,M.Gizi.Sp.GK. 2021. Nutrisi Penting Yang Perlu Dipenuhi Setelah Melahirkan.*Kemenkes RI*.
- DIMASLIA "Jurnal Pengabdian Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta" Vol I No II Juli 2023 Print ISSN : 2985-3869 Online ISSN : xxxx – xxxx Jurnal Homepage : <https://jurnal.lppm-mmy.ac.id/index.php/dimaslia>
- Dewi Andarianingsih dkk. (2021). Buku Saku Pintar ASIP. *PT Nasya Expanding Management*, 13-17. Jawa Tengah.
- Edita Linda. (2019). Asi eksklusif. *YAYASAN JAMIUL FAWAID*, 5, Cilacap, Jawa Tengah
- Edita Linda. (2019). Asi eksklusif. *YAYASAN JAMIUL FAWAID*, 3, Cilacap, Jawa Tengah
- Gusti Ayu Marhaeni dkk. (2017). Asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah. *Andi Publisher*, 12. Yogyakarta.
- Ika Suherlin, dkk. (2023). Asuhan neonatus, bayi dan balita. *Depublish Digital*, Yogyakarta.
- Junaida Rahmi, Annisa Amaliyah Hanifa, Yollin Noviana, Ikada Septiarimurti. (2024). Buku mewujudkan keberhasilan menyusui. *Kaizen Media Pushlising*, 17-20. Bandung, Jawa Barat.
- Junaida Rahmi, Annisa Amaliyah Hanifa, Yollin Noviana, Ikada Septiarimurti. (2024). Buku mewujudkan keberhasilan menyusui. *Kaizen Media Pushlising*, 2-6. Bandung, Jawa Barat.
- Kemenkes RI. (2019). Panduan Pelayanan Pasca Persalinan. *Kemenkes RI*.
- Luh Putu Widiastini. (2018). Buku ajar asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. *Penerbit In Media*, 132. Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor.
- Lydia Barus, Defacto Firmawati Zega, Nurbaiti Br.Singarimbun. Hubungan Status Gizi

Pada Ibu Nifas Dengan Pemulihan Masa Nifas di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Tahun 2020. *Journal OF Midwifery Senior e-ISSN 2621-2627 volume 6 Nomor 1 mei: (2022)*

- Mansyur Arif, Marni, (2022). Mengenal Kontrasepsi Alami. *CV Adanu Abitama Jawa Barat*. 4-10
- Marni Br Karo. (2021). Perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif. *NEM*, 17-18. Pekalongan, Jawa Tengah.
- Mayang Chyntaka, Dewi Eka Stia Murni. (2023). Gizi dalam kebutuhan reproduksi. *Deepublish*, 95. Yogyakarta.
- Priscilla, Vetty. "Kemandirian Ibu Postpartum Dalam Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Menggunakan Pendekatan Model "Mother Baby Care (M-BC)" : Postpartum Mother`s Independence in in Newborn Care Using the" Mother-Baby Care (M-CB)" Model Approach." *Ners Jurnal Keperawatan* 9.2 (2013): 166-173.
- Riadinata Shinta Puspitasari. (2023). Pengabdian masyarakat "Penyuluhan tanda bahaya nifas" Di KARANGBER, GUOSARI, PAJANGAN, BANTUL, YOGYAKARTA. <https://jurnal.lppm-mmy.ac.id/index.php/dimaslia/article/download/24/21/61>
- Riza Savita, Heni heryani, Christin Jayanti, Sri suciana, Titi Mursiti, Diana Noor Fatmawati. (2022). Buku ajar nifas DIII kebidanan jilid III. *PT Mahakarya Citra Utama Group*, 60. Jakarta Selatan.
- Riza Savita, Heni heryani, Christin Jayanti, Sri suciana, Titi Mursiti, Diana Noor Fatmawati. (2022). Buku ajar nifas DIII kebidanan jilid III. *PT Mahakarya Citra Utama Group*, 80-81. Jakarta Selatan.
- Saleh,A.Nurachmah,E.,As'ad,S.,Hadju,V.(2010).Pengaruh pendidikan kesehatan dengan pendekatan modelling terhadap pengetahuan, kemampuan praktek dan percaya diri ibu dalam menstimulasi bayi 0 - 6 bulan di kabupaten Maros,Jurnal fakultas Keperawatan Universitas Indonesia.
- Satriani G,(2021). Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui. *AhliMedia Press*, 29-44.
- Supiani. (2024). Buku ajar asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. *NEM*, 66. Pekalongan, Jawa Tengah.
- Setiasih. (2020). kontrasepsi Dalam Rahim Dan Usia Subur. <https://Repository.poltekesdenpasar.AC.id>.
- Sukei, A. P ., Astuti Setiyani, S. S. T., Astuti Setiyani, S. S. T., Esyuananik, M. K., & Esyuananik, M. K. (2016). Praktikum Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah.
- WHO. (2018). *Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South- East Asia Region 2018*.

# BAB VII

## TEKNOLOGI MEDIS YANG MENDUKUNG PERSALINAN NORMAL

---

### A. Pendahuluan

---

Teknologi medis dalam konteks persalinan normal merujuk pada semua bentuk alat, instrumen, atau sistem yang dirancang untuk mendukung proses kelahiran fisiologis melalui pemantauan, evaluasi, dan intervensi minimal agar tetap berada dalam kondisi aman bagi ibu dan bayi. Pemanfaatan teknologi medis bertujuan untuk memastikan bahwa proses persalinan berjalan secara optimal tanpa komplikasi yang membahayakan kesehatan ibu dan bayi (Lavender et al., 2021; Khalil et al., 2021). Dalam persalinan normal, teknologi medis mencakup alat pemantauan seperti ultrasonografi (USG), kardiotokografi (CTG), doppler, partograf elektronik, teknologi pengurangan nyeri seperti virtual reality (VR), hingga telemonitoring yang dapat diakses dari jarak jauh (Bin Mahfooz et al., 2022; Indrawati & Rizal, 2023).

Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip persalinan normal yang aman dan alami dengan tetap memperhatikan kenyamanan ibu serta keselamatan janin. Implementasi teknologi medis harus senantiasa mengikuti pedoman berbasis bukti (evidence-based practice) agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kesehatan ibu dan anak tanpa mengganggu proses fisiologis yang alami (Lubis et al., 2020; World Health Organization [WHO], 2020).

Keamanan dalam persalinan merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan dan kualitas pelayanan kebidanan. Penerapan teknologi medis dalam praktik kebidanan modern memiliki dampak signifikan dalam mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Menurut WHO (2020), integrasi teknologi medis yang tepat dalam pelayanan kesehatan maternal mampu meningkatkan deteksi dini terhadap risiko persalinan, mempermudah pemantauan kondisi janin secara real-time, serta mengurangi kejadian komplikasi persalinan yang tidak terprediksi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan alat pemantauan seperti ultrasonografi dapat membantu bidan dalam memastikan posisi dan berat janin sebelum persalinan, yang berdampak pada keputusan intervensi yang tepat waktu (Suárez-Idueta et al., 2020). Teknologi kardiotokografi (CTG) membantu mendeteksi gangguan denyut jantung janin lebih awal, sehingga risiko hipoksia atau asfiksia pada janin dapat dicegah atau diatasi dengan cepat (Grivell & Alfirevic, 2020; Prasetyawati et al., 2021).

Selain itu, perkembangan teknologi seperti virtual reality (VR) telah terbukti secara ilmiah mampu mereduksi nyeri persalinan tanpa efek samping farmakologis, sehingga memberikan kenyamanan tambahan bagi ibu dan menjaga proses persalinan tetap alami (Frey et al., 2021; Indrawati & Rizal, 2023). Demikian pula, partograf elektronik dan sistem telemonitoring telah meningkatkan akurasi dalam mencatat dan mengevaluasi kemajuan persalinan, terutama di daerah-daerah terpencil atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki keterbatasan akses terhadap tenaga spesialis (Lavender et al., 2021; Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Namun, perlu disadari bahwa implementasi teknologi medis bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bidan, biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi, serta kurangnya dukungan kebijakan institusional perlu mendapat perhatian serius agar manfaat teknologi medis benar-benar maksimal dalam praktik kebidanan (Abdulaziz et al., 2023; Utami & Sulastri, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi setiap praktisi kebidanan untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilannya mengenai teknologi medis yang relevan agar mampu memberikan layanan terbaik bagi ibu dan bayi. Dengan demikian, teknologi medis menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari praktik kebidanan berbasis bukti, yang tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga menjaga kualitas pengalaman persalinan secara keseluruhan.

## **B. Pemanfaatan Ultrasonografi (Usg) Dalam Persalinan Normal**

---

### **1. Peran USG untuk Memantau Posisi Janin dan Prediksi Berat Badan Janin**

Ultrasonografi (USG) merupakan teknologi pencitraan medis non-invasif yang secara luas digunakan dalam praktik kebidanan, khususnya selama periode antepartum dan intrapartum. Dalam konteks persalinan normal, USG memainkan peran penting dalam memberikan informasi akurat tentang posisi janin, presentasi kepala atau bokong, posisi plasenta, serta prediksi berat badan janin sebelum persalinan (Khalil et al., 2021; Suárez-Idueta et al., 2020). Informasi ini sangat penting bagi bidan untuk menentukan strategi persalinan yang aman dan sesuai dengan kondisi klinis ibu dan janin.

Menurut Khalil et al. (2021), penggunaan ultrasonografi pada fase intrapartum dapat secara efektif mengidentifikasi berbagai posisi abnormal janin, seperti presentasi sungsang atau melintang, yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi selama persalinan normal. Identifikasi posisi janin secara dini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan cepat, termasuk mempersiapkan intervensi tambahan jika diperlukan, seperti pemutaran janin

eksternal (external cephalic version) atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Selain pemantauan posisi janin, prediksi berat badan janin menggunakan USG juga merupakan bagian integral dalam persiapan persalinan normal. Berat janin yang terlalu besar (makrosomia) atau terlalu kecil (restriksi pertumbuhan intrauterin/IUGR) dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan seperti distosia bahu, robekan jalan lahir, atau bahkan persalinan macet yang memerlukan tindakan lebih lanjut seperti operasi sesar (Suárez-Idueta et al., 2020). Dengan demikian, prediksi berat badan janin menggunakan USG membantu bidan dalam membuat perencanaan persalinan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti.

## 2. Keefektifan Penggunaan USG dalam Evaluasi Progres Persalinan dan Risiko Komplikasi

Penggunaan USG tidak hanya terbatas pada penilaian posisi dan ukuran janin sebelum persalinan, tetapi juga bermanfaat dalam mengevaluasi progres persalinan dan risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khalil et al. (2021), pemantauan dengan USG secara real-time selama persalinan dapat membantu mendeteksi hambatan yang mengganggu turunnya kepala janin, misalnya posisi kepala yang tidak ideal atau ketidaksesuaian antara kepala janin dengan ukuran panggul ibu.

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pemantauan ultrasonografi selama proses persalinan efektif dalam mendeteksi komplikasi seperti distosia bahu dan keterlambatan proses pembukaan serviks (Lavender et al., 2021). Informasi visual dari USG membantu tenaga kesehatan untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan mengenai manajemen persalinan, termasuk penentuan waktu yang tepat untuk intervensi tambahan seperti augmentasi persalinan atau tindakan lain yang diperlukan demi menjaga keselamatan ibu dan bayi (Dall'Asta et al., 2022).

Efektivitas ultrasonografi dalam mengevaluasi progres persalinan juga didukung oleh berbagai pedoman internasional, seperti rekomendasi dari World Health Organization (WHO, 2020), yang menegaskan bahwa USG dapat menjadi alat bantu penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis berbasis bukti selama persalinan normal. Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa pemanfaatan ultrasonografi harus selalu diintegrasikan secara bijaksana, agar tetap mendukung prinsip persalinan fisiologis dan menghindari intervensi yang tidak perlu.

Dalam praktik kebidanan, keterampilan dalam menggunakan USG menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan peningkatan kompetensi

tenaga kesehatan termasuk bidan sangat dianjurkan untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini secara aman dan efektif dalam praktik sehari-hari.

### **C. Cardiotocography (Ctg) Sebagai Alat Monitoring Kondisi Janin**

---

#### **1. Prinsip Kerja CTG dalam Memantau Denyut Jantung Janin Selama Persalinan**

Cardiotocography (CTG) merupakan teknologi medis yang digunakan untuk memantau denyut jantung janin serta kontraksi uterus secara bersamaan selama proses persalinan. CTG terdiri dari dua sensor utama: sensor ultrasonografi Doppler untuk merekam denyut jantung janin (Fetal Heart Rate/FHR) dan sensor tekanan atau tokodinamometer untuk merekam aktivitas kontraksi uterus (Grivell & Alfievic, 2020).

Secara prinsip, sensor ultrasonografi Doppler bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke arah jantung janin, kemudian menangkap gelombang pantulan yang menunjukkan perubahan frekuensi sesuai dengan gerakan jantung janin. Perubahan ini kemudian diinterpretasikan sebagai grafik denyut jantung janin secara kontinu, yang umumnya memiliki rentang normal sekitar 110–160 denyut per menit (bpm) (Prasetyawati et al., 2021).

Sementara itu, sensor tekanan pada tokodinamometer ditempatkan di atas fundus uteri, yang berfungsi mendeteksi durasi, frekuensi, serta intensitas kontraksi uterus. Gabungan kedua grafik tersebut, yaitu grafik denyut jantung janin dan kontraksi uterus, membantu tenaga kesehatan seperti bidan untuk mengidentifikasi secara dini adanya tanda-tanda distres janin, seperti denyut jantung janin yang abnormal (takikardi, bradikardi, atau variabilitas abnormal), yang memerlukan tindakan segera (Grivell & Alfievic, 2020; Ayres-de-Campos & Bernardes, 2021).

#### **2. Manfaat dan Batasan Penggunaan CTG Rutin pada Persalinan Normal**

##### **a. Manfaat Penggunaan CTG**

Penggunaan rutin CTG selama persalinan membawa sejumlah manfaat signifikan dalam meningkatkan keselamatan ibu dan janin. CTG mampu memberikan informasi real-time tentang kondisi janin selama proses persalinan, sehingga membantu deteksi dini terhadap risiko komplikasi seperti hipoksia janin, prolaps tali pusat, atau gangguan lainnya yang dapat membahayakan janin (Prasetyawati et al., 2021). Menurut Grivell dan Alfievic (2020), pemantauan kontinu dengan CTG terbukti mampu menurunkan angka kejang neonatal serta meningkatkan kecepatan intervensi medis jika diperlukan.

Selain itu, penggunaan CTG juga bermanfaat bagi tim kebidanan dalam mengambil keputusan klinis berbasis bukti. Grafik CTG dapat menjadi acuan objektif dalam menentukan tindakan lebih lanjut, seperti percepatan persalinan melalui augmentasi oksitosin atau bahkan keputusan untuk operasi caesar apabila ditemukan tanda-tanda distress janin yang signifikan (Ayres-de-Campos & Bernardes, 2021).

**b. Batasan Penggunaan CTG**

Meski memiliki berbagai manfaat, penggunaan CTG secara rutin juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penggunaan CTG secara berlebihan dapat meningkatkan risiko intervensi medis yang tidak perlu seperti operasi sesar akibat interpretasi yang berlebihan (false-positive), terutama pada kasus di mana hasil CTG menunjukkan pola abnormal tetapi tidak disertai bukti klinis lainnya yang signifikan (Grivell & Alfirevic, 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemantauan CTG secara kontinu pada kehamilan risiko rendah tidak selalu menghasilkan luaran yang lebih baik dibandingkan dengan pemantauan intermiten menggunakan auskultasi Doppler manual. Sebaliknya, penggunaan CTG kontinu pada populasi ini berhubungan dengan peningkatan angka intervensi medis yang tidak diperlukan seperti seksio sesarea dan persalinan dengan instrumen bantu seperti vakum atau forsep (Devane et al., 2021).

Selain itu, interpretasi hasil CTG yang kompleks membutuhkan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan agar mampu melakukan evaluasi yang akurat serta menghindari keputusan yang tidak perlu. Oleh karena itu, penggunaan CTG perlu diintegrasikan dengan asesmen klinis menyeluruh terhadap kondisi ibu dan janin, sehingga pemanfaatan teknologi ini lebih efektif dan aman dalam praktik kebidanan (Prasetyawati et al., 2021).

Kesimpulannya, CTG merupakan teknologi penting yang dapat meningkatkan kualitas pemantauan janin selama persalinan, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan dibarengi dengan keterampilan interpretasi yang baik dari tenaga kesehatan.

**D. Partograf Elektronik Untuk Manajemen Persalinan**

---

**1. Perbedaan Partograf Elektronik dibandingkan Partograf Manual**

Partograf merupakan alat pencatatan grafik yang digunakan secara luas dalam praktik kebidanan untuk memonitor kemajuan persalinan, kondisi janin, dan kesejahteraan ibu secara visual. Secara umum, partograf terbagi menjadi dua jenis, yakni partograf manual (konvensional) dan partograf elektronik (digital).



Perbedaan mendasar antara kedua jenis partograf ini terletak pada metode pencatatan, pengolahan data, dan interpretasi hasilnya (Lavender et al., 2021).

Partograf manual menggunakan format kertas sebagai media pencatatan dengan grafik yang digambar secara manual oleh tenaga kesehatan selama persalinan berlangsung. Kendati sederhana dan murah, penggunaan partograf manual memiliki kelemahan seperti risiko kesalahan pencatatan yang tinggi, kurangnya konsistensi dalam interpretasi data, serta sulitnya berbagi informasi secara cepat dalam situasi emergensi (Nurgiantini & Suherni, 2022).

Sebaliknya, partograf elektronik merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pencatatan data persalinan secara digital. Teknologi ini menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan versi manual, antara lain: pencatatan yang lebih akurat, interpretasi otomatis kondisi ibu dan janin melalui algoritma berbasis bukti, serta kemampuan berbagi data secara real-time kepada anggota tim kesehatan lainnya. Partograf elektronik juga memungkinkan integrasi data ke dalam sistem rekam medis elektronik sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat waktu (Lavender et al., 2021; Fawole et al., 2022).

## **2. Efektivitas Partograf Elektronik dalam Meminimalisir Komplikasi Persalinan**

Implementasi partograf elektronik telah terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas layanan persalinan dibandingkan partograf manual. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan partograf elektronik mampu menurunkan angka komplikasi persalinan seperti persalinan macet (prolonged labor), perdarahan postpartum, serta kejadian distress janin, yang berkontribusi pada penurunan angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi (Nurgiantini & Suherni, 2022; Lavender et al., 2021).

Menurut penelitian Lavender et al. (2021), partograf elektronik meningkatkan kecepatan identifikasi penyimpangan progres persalinan, sehingga intervensi klinis yang tepat dapat segera dilakukan. Misalnya, sistem ini mampu memberikan peringatan dini apabila terjadi keterlambatan pembukaan serviks atau gangguan denyut jantung janin, yang berkontribusi pada tindakan klinis yang lebih tepat waktu dan berdasarkan bukti.

Sebuah penelitian di Indonesia oleh Nurgiantini dan Suherni (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan partograf elektronik mampu meningkatkan keterampilan bidan dalam mengelola persalinan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan. Hal

ini secara langsung berdampak positif pada hasil akhir persalinan, dengan pengurangan signifikan pada komplikasi maternal dan neonatal.

Namun demikian, penggunaan partograf elektronik bukan tanpa tantangan. Implementasinya memerlukan biaya investasi teknologi yang lebih tinggi, pelatihan khusus tenaga kesehatan, serta infrastruktur pendukung yang memadai seperti koneksi internet stabil dan perangkat elektronik yang sesuai. Oleh karena itu, efektivitas partograf elektronik juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta dukungan kebijakan institusional (Fawole et al., 2022).

Secara keseluruhan, partograf elektronik merupakan solusi inovatif yang menjanjikan peningkatan keamanan dan efektivitas pelayanan persalinan normal, terutama jika disertai dengan perencanaan matang dan dukungan sistemik dalam implementasinya.

#### **E. Teknologi Virtual Reality (Vr) Sebagai Metode Reduksi Nyeri**

---

##### **1. Pemanfaatan VR dalam Mengurangi Intensitas Nyeri Selama Persalinan**

Virtual Reality (VR) merupakan teknologi berbasis simulasi tiga dimensi yang menghadirkan pengalaman imersif melalui rangsangan visual dan audio secara virtual. Teknologi ini mulai banyak diterapkan sebagai metode non-farmakologis dalam mengelola nyeri selama proses persalinan normal (Frey et al., 2021; Indrawati & Rizal, 2023). Dalam konteks ini, VR bekerja dengan mengalihkan perhatian ibu dari rasa sakit melalui stimulasi sensorik, menciptakan lingkungan virtual yang nyaman, tenang, dan menyenangkan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan VR secara efektif membantu mengurangi persepsi nyeri dengan mengalihkan perhatian dan mengurangi tingkat kecemasan ibu selama persalinan. Menurut Frey et al. (2021), teknologi ini bekerja dengan prinsip distraksi kognitif, di mana fokus ibu dipindahkan dari stimulus nyeri ke stimulus visual dan auditori yang menyenangkan. Lingkungan virtual yang sering digunakan meliputi pemandangan alam, suasana pantai, hutan, atau lingkungan lain yang menenangkan, sehingga secara signifikan mampu meningkatkan kenyamanan ibu.

Indrawati dan Rizal (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan VR selama persalinan tidak hanya efektif dalam mengurangi intensitas nyeri, tetapi juga secara positif mempengaruhi emosi ibu, meningkatkan rasa nyaman, serta mendukung terjadinya relaksasi yang lebih mendalam. Penggunaan teknologi ini diintegrasikan dengan pendekatan lain seperti teknik pernapasan, afirmasi positif, dan dukungan emosional yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau pendamping persalinan.

## **2. Kajian Efektivitas VR Dibandingkan Metode Konvensional untuk Manajemen Nyeri**

Berbagai studi yang dilakukan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa VR memiliki efektivitas yang menjanjikan jika dibandingkan metode konvensional manajemen nyeri selama persalinan, seperti penggunaan teknik pernapasan, terapi musik, pijat, atau aromaterapi. Frey et al. (2021) melalui systematic review-nya menemukan bahwa VR secara signifikan lebih efektif dalam menurunkan skor nyeri dan kecemasan dibandingkan metode distraksi konvensional lainnya, terutama karena tingkat imersi dan interaksi sensorik yang lebih tinggi pada teknologi ini.

Penelitian eksperimental oleh Indrawati dan Rizal (2023) juga mendukung temuan tersebut, menunjukkan bahwa ibu yang menggunakan VR selama persalinan melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang hanya menerima metode distraksi konvensional seperti teknik relaksasi biasa atau musik terapi. Lebih lanjut, penggunaan VR tercatat mampu meningkatkan kepuasan ibu terhadap proses persalinan, yang pada akhirnya berdampak pada pengalaman positif secara keseluruhan.

Meski demikian, penerapan teknologi VR dalam manajemen nyeri persalinan juga memiliki beberapa tantangan, termasuk ketersediaan alat VR yang memadai, kesiapan tenaga kesehatan dalam penggunaannya, serta penerimaan teknologi oleh ibu bersalin (Hoffman et al., 2020). Oleh sebab itu, implementasi teknologi ini perlu disertai pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dan edukasi bagi ibu mengenai manfaat VR, serta persiapan logistik yang matang guna mengoptimalkan efektivitas penggunaannya.

Dengan demikian, teknologi Virtual Reality (VR) dapat dianggap sebagai metode inovatif dan efektif dalam manajemen nyeri selama persalinan normal, serta menawarkan pilihan tambahan yang aman, nyaman, dan tanpa efek samping farmakologis bagi ibu dalam melahirkan secara alami.

### **F. Telemonitoring Untuk Dukungan Persalinan Jarak Jauh**

---

#### **1. Peran Telemonitoring dalam Mendukung Bidan pada Layanan Persalinan di Daerah Terpencil**

Telemonitoring merupakan teknologi berbasis telekomunikasi yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan jarak jauh terhadap kondisi ibu dan janin selama proses persalinan. Teknologi ini menggunakan perangkat elektronik seperti sensor nirkabel, aplikasi ponsel pintar, dan platform komunikasi digital untuk mengirimkan data vital pasien secara real-

time kepada tenaga kesehatan, khususnya bidan yang bertugas di wilayah terpencil (Bin Mahfooz et al., 2022; Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas oleh faktor geografis, kurangnya fasilitas kesehatan, serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten. Dalam kondisi ini, telemonitoring berperan penting dalam mengatasi hambatan tersebut dengan memungkinkan bidan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tenaga ahli yang berada di fasilitas rujukan, sehingga pengambilan keputusan klinis selama proses persalinan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat (Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Penelitian oleh Bin Mahfooz et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan telemonitoring memungkinkan pemantauan tanda-tanda vital ibu (seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan frekuensi kontraksi) serta kondisi janin (seperti denyut jantung janin dan pergerakan janin) secara kontinu. Hal ini tidak hanya membantu bidan dalam mendeteksi dini komplikasi seperti preeklampsia, perdarahan, atau gangguan denyut jantung janin, tetapi juga meningkatkan kemampuan bidan dalam memberikan asuhan persalinan sesuai standar pelayanan kebidanan yang berlaku.

## **2. Evaluasi Efektivitas Telemonitoring dalam Meningkatkan Akses Layanan Persalinan Normal yang Aman**

Berbagai studi telah mengevaluasi efektivitas penerapan telemonitoring dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan persalinan normal, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Menurut Anggraeni dan Wahyuni (2023), implementasi telemonitoring di wilayah terpencil Indonesia terbukti efektif dalam mengurangi angka kejadian komplikasi persalinan, mempercepat respons tenaga kesehatan terhadap situasi darurat, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap layanan yang diterima.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa melalui telemonitoring, terjadi peningkatan akses ke layanan kesehatan, terutama bagi ibu-ibu yang sebelumnya mengalami kendala geografis dalam mendapatkan pelayanan kebidanan berkualitas. Efektivitas ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas komunikasi antara bidan desa dan tenaga ahli yang berada di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, memungkinkan tindakan rujukan cepat jika dibutuhkan (Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Studi sistematis oleh Bin Mahfooz et al. (2022) memperkuat bukti bahwa telemonitoring selama persalinan tidak hanya meningkatkan akses layanan kebidanan tetapi juga secara signifikan mengurangi mortalitas ibu dan bayi di daerah dengan infrastruktur kesehatan terbatas. Selain itu, telemonitoring juga

memperkuat kapasitas bidan lokal dalam pengambilan keputusan klinis secara mandiri, karena memperoleh bimbingan langsung dari tenaga ahli melalui platform digital.

Meski demikian, efektivitas telemonitoring juga tergantung pada faktor seperti infrastruktur teknologi yang tersedia, pelatihan dan kesiapan bidan dalam menggunakan teknologi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, implementasi telemonitoring harus disertai dengan strategi komprehensif, meliputi pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan, penyediaan perangkat teknologi yang tepat, serta peningkatan kapasitas jaringan komunikasi untuk memastikan keberlangsungan pemantauan secara efektif (Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Secara keseluruhan, telemonitoring menawarkan solusi strategis dalam mendukung persalinan normal yang aman dan berkualitas, terutama bagi ibu yang tinggal di wilayah terpencil, sehingga dapat meningkatkan hasil akhir kesehatan ibu dan bayi secara signifikan.

#### **G. Penggunaan Doppler Untuk Evaluasi Sirkulasi Plasenta Dan Janin**

---

##### **1. Mekanisme Kerja dan Kegunaan Doppler dalam Pemantauan Persalinan**

Ultrasonografi Doppler merupakan salah satu teknologi medis yang digunakan untuk menilai sirkulasi darah plasenta dan janin secara non-invasif. Prinsip dasar Doppler ultrasound adalah mendeteksi pergerakan aliran darah dengan mengukur perbedaan frekuensi gelombang suara (efek Doppler) yang dipantulkan dari sel darah merah dalam pembuluh darah janin dan plasenta (Lees, Stampalija, & Baschat, 2021).

Dalam konteks persalinan, Doppler digunakan untuk memantau aliran darah pada arteri umbilikal, arteri serebralis media, dan ductus venosus janin. Evaluasi ini memberikan informasi kritis tentang suplai oksigen dan nutrisi yang diterima janin selama proses persalinan, serta mendeteksi potensi risiko komplikasi seperti insufisiensi plasenta, hipoksia janin, atau gangguan pertumbuhan intrauterin (Sari & Yuliana, 2022). Penggunaan Doppler memungkinkan bidan dan tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis berbasis bukti dalam mengelola persalinan secara aman dan efektif.

Kegunaan utama dari Doppler selama persalinan meliputi identifikasi dini janin yang mengalami stres intrauterin serta evaluasi status kesehatan janin pada kehamilan risiko tinggi, seperti ibu dengan hipertensi, diabetes, atau janin dengan hambatan pertumbuhan (Lees et al., 2021).

##### **2. Studi Kasus Efektivitas Doppler dalam Mencegah Komplikasi Perinatal**

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan efektivitas penggunaan ultrasonografi Doppler dalam mencegah komplikasi perinatal, khususnya dalam persalinan normal dengan risiko tertentu. Menurut penelitian Sari dan Yuliana (2022), pemantauan menggunakan Doppler secara signifikan efektif dalam mendeteksi dini gangguan sirkulasi janin yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoksia atau asfiksia neonatal. Dalam penelitian tersebut, penggunaan Doppler pada kehamilan risiko tinggi menurunkan secara signifikan angka kejadian intervensi emergensi selama persalinan seperti operasi sesar darurat dan tindakan resusitasi neonatal.

Lees et al. (2021) dalam kajian sistematis juga menyatakan bahwa evaluasi aliran darah menggunakan Doppler, khususnya pada arteri umbilikalis dan serebral media janin, sangat efektif dalam memprediksi risiko komplikasi perinatal. Misalnya, pola aliran darah abnormal seperti peningkatan resistensi di arteri umbilikalis dapat mengindikasikan insufisiensi plasenta yang membutuhkan intervensi klinis segera demi mencegah hasil buruk pada janin.

Sebuah studi kasus oleh Sari dan Yuliana (2022) menggambarkan secara jelas efektivitas Doppler pada seorang ibu dengan riwayat hipertensi kronis. Dalam kasus tersebut, pemeriksaan Doppler menunjukkan gangguan sirkulasi di plasenta, sehingga tenaga kesehatan melakukan persiapan lebih awal untuk penanganan persalinan di fasilitas rujukan lengkap. Hasil akhirnya, bayi dilahirkan dengan kondisi baik, menunjukkan bahwa penggunaan Doppler dapat secara signifikan membantu pengambilan keputusan klinis secara tepat waktu untuk mencegah komplikasi serius.

Namun, efektivitas Doppler bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan secara akurat. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi ini harus disertai pelatihan intensif agar tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi tanda-tanda abnormal secara dini, serta menentukan tindakan yang tepat dalam mengelola persalinan (Lees et al., 2021).

Secara keseluruhan, penggunaan Doppler dalam evaluasi sirkulasi plasenta dan janin memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pemantauan persalinan serta menurunkan risiko komplikasi perinatal secara signifikan.

## **H. Tantangan Dalam Implementasi Teknologi Medis Di Praktik Kebidanan**

---

### **1. Hambatan Internal dan Eksternal dalam Adopsi Teknologi Medis oleh Bidan**

Penerapan teknologi medis dalam praktik kebidanan menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal yang paling

sering diidentifikasi adalah keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan bidan dalam menggunakan teknologi medis terbaru. Abdulaziz et al. (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya kepercayaan diri dalam menggunakan alat-alat baru menjadi kendala utama dalam penerapan teknologi digital di layanan kebidanan. Selain itu, resistensi bidan terhadap perubahan metode kerja konvensional menuju digitalisasi juga menjadi tantangan yang cukup signifikan (Utami & Sulastri, 2022).

Secara eksternal, kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya fasilitas pendukung, serta biaya tinggi dalam pengadaan dan pemeliharaan teknologi medis. Kondisi ini lebih terasa di daerah terpencil atau wilayah dengan sumber daya kesehatan terbatas (Utami & Sulastri, 2022). Di sisi lain, kurangnya dukungan kebijakan dari institusi kesehatan atau pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas dan dukungan finansial juga merupakan hambatan eksternal yang sering ditemui dalam implementasi teknologi medis dalam praktik kebidanan (Abdulaziz et al., 2023).

## **2. Strategi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Bidan dalam Pemanfaatan Teknologi Medis**

Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi medis dalam pelayanan kebidanan modern, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan. Salah satu strategi yang efektif adalah pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*), termasuk workshop, seminar, dan pelatihan berbasis simulasi. Abdulaziz et al. (2023) menyarankan bahwa pelatihan praktis yang bersifat interaktif dan *hands-on training* akan lebih efektif dibandingkan pendekatan pelatihan tradisional yang bersifat teoritis semata.

Selain itu, integrasi teknologi medis ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan formal menjadi strategi penting lainnya. Penelitian Utami dan Sulastri (2022) menegaskan bahwa penyusunan kurikulum pendidikan yang memasukkan materi teknologi medis akan membantu calon bidan memahami dan terbiasa menggunakan teknologi sejak dini, sehingga memudahkan transisi mereka ke praktik klinis nyata.

Strategi lain yang disarankan adalah pengembangan program mentorship atau pendampingan, di mana bidan senior atau tenaga ahli yang terampil dalam teknologi medis dapat memberikan bimbingan langsung kepada bidan yang kurang berpengalaman. Program pendampingan ini terbukti efektif dalam

meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri bidan dalam penggunaan teknologi baru (Abdulaziz et al., 2023).

Terakhir, strategi penguatan kebijakan dan dukungan institusional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi adopsi teknologi medis. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses internet stabil, penyediaan dana khusus untuk teknologi medis, serta regulasi yang jelas terkait standar penggunaan teknologi dalam layanan kebidanan (Utami & Sulastri, 2022).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan adopsi teknologi medis dalam praktik kebidanan dapat meningkat secara signifikan, sehingga layanan kebidanan mampu memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

## **I. Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Teknologi Dalam Persalinan Normal**

---

### **1. Indikator Keberhasilan Implementasi Teknologi Medis**

Evaluasi keberhasilan implementasi teknologi medis dalam persalinan normal merupakan aspek penting guna memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar membawa manfaat optimal bagi ibu dan bayi. Menurut Dahlen et al. (2022), indikator keberhasilan tersebut meliputi berbagai parameter klinis maupun non-klinis. Secara klinis, indikator keberhasilan mencakup penurunan angka komplikasi persalinan seperti perdarahan postpartum, distosia persalinan, hipoksia janin, serta angka kematian ibu dan bayi. Indikator lain yang sering digunakan adalah peningkatan deteksi dini terhadap komplikasi melalui pemantauan real-time selama persalinan, yang memungkinkan intervensi tepat waktu dan berbasis bukti.

Selain indikator klinis, indikator non-klinis juga penting dalam mengevaluasi keberhasilan teknologi medis, seperti peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima, peningkatan kepercayaan diri bidan dalam memberikan layanan persalinan, serta efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses persalinan (Lubis et al., 2020). Indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa implementasi teknologi medis tidak hanya dilihat dari sisi klinis semata, tetapi juga dari perspektif kualitas pelayanan yang dirasakan oleh ibu dan tenaga kesehatan.

### **2. Metode Evaluasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Midwifery Practice - EBMP)**

Evaluasi berbasis bukti dalam praktik kebidanan (Evidence-Based Midwifery Practice - EBMP) merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan memastikan



penggunaan teknologi medis dalam persalinan didasarkan pada hasil penelitian terbaik yang tersedia, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta preferensi pasien. Pendekatan ini bertujuan agar teknologi yang digunakan terbukti efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Dahlen et al., 2022).

Metode EBMP terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu merumuskan pertanyaan klinis yang spesifik, melakukan pencarian dan analisis terhadap bukti ilmiah terkini yang relevan, melakukan penilaian kritis terhadap kualitas bukti, serta mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut ke dalam praktik klinis sehari-hari (Lubis et al., 2020). Metode ini juga mencakup evaluasi secara periodik melalui audit klinis, survei kepuasan pasien, dan analisis data klinis terkait hasil luaran persalinan, guna memastikan bahwa penerapan teknologi medis benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Salah satu contoh konkret evaluasi berbasis bukti dalam konteks persalinan normal adalah evaluasi penggunaan partograf elektronik. Dengan menggunakan EBMP, tenaga kesehatan secara rutin menilai efektivitas teknologi ini melalui analisis statistik yang objektif tentang penurunan komplikasi, analisis biaya-manfaat, serta umpan balik pasien dan tenaga kesehatan mengenai kemudahan dan manfaat teknologi tersebut dalam praktik sehari-hari (Dahlen et al., 2022).

Dalam implementasi EBMP, pelatihan tenaga kesehatan dalam keterampilan evaluasi dan interpretasi hasil penelitian sangat diperlukan. Dengan demikian, hasil evaluasi benar-benar mencerminkan efektivitas nyata teknologi medis yang digunakan serta mendukung perbaikan terus-menerus dalam layanan kebidanan yang diberikan (Lubis et al., 2020).

Secara keseluruhan, metode evaluasi berbasis bukti (EBMP) menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa teknologi medis yang digunakan dalam persalinan normal secara konsisten meningkatkan kualitas dan keamanan layanan kebidanan.

## **J. Penutup**

---

### **1. Ringkasan Pentingnya Integrasi Teknologi Medis dalam Praktik Kebidanan Modern**

Integrasi teknologi medis dalam praktik kebidanan modern merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi selama proses persalinan normal. Berbagai penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti ultrasonografi (USG), cardiotocography (CTG), partograf elektronik, virtual reality (VR), telemonitoring, serta Doppler memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan (Dahlen et al., 2022; Lavender et al., 2021).

Teknologi ini terbukti mampu menurunkan angka komplikasi persalinan, mempercepat pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan ibu, serta mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil (Bin Mahfooz et al., 2022; Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Namun, implementasi teknologi medis juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bidan, minimnya dukungan infrastruktur teknologi, serta biaya yang tinggi dalam pengadaan dan pemeliharaan alat-alat medis tersebut (Abdulaziz et al., 2023; Utami & Sulastri, 2022). Oleh sebab itu, keberhasilan integrasi teknologi medis tidak hanya ditentukan oleh efektivitas alatnya saja, melainkan juga oleh kesiapan tenaga kesehatan dan dukungan kebijakan institusional yang jelas.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi medis di bidang kebidanan adalah langkah penting dalam memodernisasi pelayanan persalinan, meminimalkan risiko komplikasi perinatal, serta mendukung tercapainya hasil persalinan yang optimal dan aman.

## **2. Rekomendasi untuk Praktik Klinik dan Arah Penelitian Masa Depan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi teknologi medis di praktik klinik kebidanan, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tenaga kesehatan khususnya bidan harus senantiasa mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan rutin berbasis bukti dan pendidikan berkelanjutan tentang penggunaan teknologi terbaru dalam kebidanan (Stoll & Gallagher, 2021; Abdulaziz et al., 2023). Kedua, dukungan kebijakan institusional dan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta infrastruktur teknologi yang memadai harus terus diperkuat guna memastikan aksesibilitas teknologi di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil (Anggraeni & Wahyuni, 2023).

Adapun untuk arah penelitian masa depan, dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai efektivitas jangka panjang implementasi teknologi medis dalam praktik kebidanan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah pengguna, hemat biaya, serta mudah diintegrasikan dalam berbagai tingkat fasilitas kesehatan (Lubis et al., 2020). Kajian lebih lanjut tentang penerimaan sosial dan dampak psikologis penggunaan teknologi terhadap ibu selama proses persalinan juga menjadi fokus yang penting untuk diteliti lebih mendalam (Frey et al., 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, praktik kebidanan modern diharapkan dapat terus berkembang secara efektif, menjadikan teknologi medis sebagai bagian integral yang mendukung pencapaian standar pelayanan yang aman, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan ibu dan bayi.

## Referensi

- Abdulaziz, S. H., Almutairi, A. F., Alharbi, A. S., Alshammari, M. M., & Alshehri, F. H. (2023). Barriers and facilitators in the implementation of digital health technologies in midwifery practice. *Midwifery*, 115, 103577. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103577>
- Anggraeni, L., & Wahyuni, I. (2023). Implementasi telemonitoring dalam pelayanan persalinan di wilayah terpencil Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(3), 190-198. <https://doi.org/10.22146/jkr.87654>
- Bin Mahfooz, A., Alharthy, N., AlKhamis, A., Alzahrani, A., & Alqahtani, A. (2022). Telemonitoring during labor: Current evidence and future perspectives. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(7), 509-518. <https://doi.org/10.1177/1357633X20968325>
- Dahlen, H. G., Barclay, L., Tracy, S. K., & Homer, C. S. E. (2022). Evaluating the impact of technology in maternity care: an evidence-based midwifery approach. *International Journal of Childbirth*, 12(3), 101-110. <https://doi.org/10.1891/IJCB-2022-0008>
- Fernández-Castillo, R. J., & Caballero-Guerrero, P. M. (2020). Barriers to the implementation of telemedicine in midwifery: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 76(3), 708-717. <https://doi.org/10.1111/jan.14299>
- Frey, D. P., Bauer, M. E., & Hoffman, H. G. (2021). Virtual reality for pain and anxiety relief during childbirth: A systematic review. *Birth*, 48(4), 597-608. <https://doi.org/10.1111/birt.12556>
- Grivell, R. M., & Alfirevic, Z. (2020). Continuous cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart rate during labor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(2), CD006066. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006066.pub3>
- Indrawati, N. D., & Rizal, A. M. (2023). Virtual Reality sebagai alternatif non-farmakologis dalam manajemen nyeri persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(1), 54-61. <https://doi.org/10.26714/jkmi.18.1.2023.54-61>
- Khalil, A., Archer, A., Mousa, H. A., & Thilaganathan, B. (2021). Ultrasound in labor and delivery: A practical guideline. *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*, 3(4), 100408. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2021.100408>
- Lavender, T., Bernitz, S., & Dahlen, H. G. (2021). E-Partograph: Revolutionizing labor monitoring? *Midwifery*, 103, 103127. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103127>

- Lees, C., Stampalija, T., & Baschat, A. A. (2021). Doppler ultrasound in obstetrics: evolving perspectives and guidelines. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 57(5), 697-709. <https://doi.org/10.1002/uog.23581>
- Lubis, I., Sudarti, S., & Rahmawati, R. (2020). Evaluasi efektivitas penerapan teknologi kesehatan dalam praktik kebidanan. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 8(1), 67-73. <https://doi.org/10.24252/jkk.v8i1.14023>
- Nurgiantini, R., & Suherni, T. (2022). Implementasi partograf elektronik dalam meningkatkan kualitas asuhan persalinan. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 13(2), 221-229. <https://doi.org/10.26751/jikk.v13i2.1296>
- Sari, N. M., & Yuliana, F. (2022). Efektivitas Doppler untuk memprediksi komplikasi selama persalinan normal. *Jurnal Kebidanan Modern*, 11(2), 95-102. <https://doi.org/10.37051/jkm.v11i2.89>
- Stoll, K., & Gallagher, F. (2021). Implementing evidence-based practices in midwifery care: challenges and facilitators. *Midwifery*, 97, 102944. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102944>
- Suárez-Idueta, L., Villalain, C., González-González, N. L., & Villalaín, J. A. (2020). Accuracy of ultrasound in predicting fetal weight in term pregnancies. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 56(2), 198-205. <https://doi.org/10.1002/uog.21957>
- Utami, A., & Sulastri, D. (2022). Hambatan implementasi teknologi medis di layanan kebidanan Indonesia: Tinjauan literatur. *Jurnal Pengembangan Teknologi Kesehatan*, 6(1), 34-42. <https://doi.org/10.31101/jpthk.v6i1.1156>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kebidanan berbasis teknologi di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2020). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2020). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. Geneva: WHO.

# Profil Penulis



## **Nila Trisna Yulianti, S.SiT.,Bdn.,M.Keb**

Riwayat Pendidikan Menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. Menyelesaikan pendidikan Profesi Bidan di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Hassanudin Makasar. Sejak tahun 2011 hingga saat ini penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Borneo Medistra di Politeknik Borneo Medistra Balikpapan. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email [nila@poltekborneomedistra.ac.id](mailto:nila@poltekborneomedistra.ac.id) atau [nilatrisnayulianti89@gmail.com](mailto:nilatrisnayulianti89@gmail.com)

### **Motto :**

Membacalah, maka akan membantumu untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, membina watak dan mengubah dunia menjadi lebih produktif.



## **Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb**

Lahir di Buntoi, 15 Mei 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Bidan Pendidik di STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan lulus tahun pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 mengabdikan kepada masyarakat / pelayanan kesehatan khususnya kebidanan di Kabupaten Kapuas Kec. Basarang ds. Pangkalan Sari, kemudian pada tahun 2014 bergabung dengan STIKES Eka Harap Palangka Raya. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Program Studi Diploma Tiga Kebidanan mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan Komunitas, dan Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan karya ilmiah berupa penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [devitaivana55@gmail.com](mailto:devitaivana55@gmail.com)



**Sulikah, SST, MKes,**

Penulis Lahir di Madiun 23 Juni 1968. Penulis adalah Dosen Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pendidikan kesehatan dimulai dari, AKPER Soetopo lulus Tahun 1995, D4 Perawat Pendidik UNAIR lulus Tahun 2000, D3 Kebidanan Soetomo lulus Tahun 2005, Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro lulus Tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [ikahsulikah3@gmail.com](mailto:ikahsulikah3@gmail.com). Buku yang pernah ditulis antara lain: Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku Ajar Asuhan Persalinan Berbasis Evidence Based, Bunga Rampai Pendekatan Hipnoterapi Pada Asuhan Kebidanan. Penulis memiliki ketertarikan di bidang kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang kesehatan. Penulis juga sebagai Anggota IBI Kabupaten Magetan. Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum



**Siti Fithrotul Umami, SST., M.Kes**

Lahir di Mojokerto, 22 November 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada STIKES Husada Jombang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 bekerja di STIKES Dian Husada Mojokerto, 2013 Bekerja di AKBID Bali Wisnu Dharma Bali. Saat ini penulis bekerja di AKBID Ar Rahma Pasuruan mengampu mata kuliah ASKEB I, ASKEB II, ASKEB Neo, ASKEB Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis juga aktif dalam organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Fatayat NU. Penulis dapat dihubungi melalui Email [vividfaradisa85@gmail.com](mailto:vividfaradisa85@gmail.com)



**Sri ilawati, SST, M.Kes**

Lahir di Sukarama ,17 Juli 1988. Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Kebidanan di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai. Setelah menyelesaikan Studi di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai penulis melanjutkan Studi Diploma IV Jurusan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Helvetia Medan, Kemudian Melanjutkan Study Magister Kesehatan Masyarakat Di Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Penulis Memiliki Profesi Sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. dan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [sriilawati468@gmail.com](mailto:sriilawati468@gmail.com)



**Rini Gustina Sari, SST., M.Kes**

Lahir di Palembang, 15 Agustus 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada STIKES Mitra Adiguna tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Kader Bangsa lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 bekerja di Akbid Budi Mulia Prabumulih, 2017 Bekerja di Universitas Kader Bangsa Palembang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kader Bangsa Palembang mengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui Email [rinantiabid1620@gmail.com](mailto:rinantiabid1620@gmail.com)



# Sinopsis Buku

Buku Peran Bidan Dalam Persalinan Normal yang Aman merupakan referensi komprehensif yang membahas secara sistematis peran penting bidan dalam mendukung proses persalinan fisiologis yang aman dan bermartabat. Disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktik lapangan, buku ini menyajikan informasi penting bagi mahasiswa kebidanan, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam pelayanan maternitas.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama. Dimulai dengan pentingnya edukasi kepada ibu hamil mengenai persiapan persalinan, pembaca diajak memahami bagaimana membangun kesiapan fisik dan mental calon ibu. Selanjutnya, dibahas peran pendampingan bidan secara profesional dan empatik selama proses persalinan. Teknik relaksasi dan manajemen nyeri non-farmakologis diuraikan sebagai strategi penting untuk mendukung persalinan alami.

Tidak hanya fokus pada proses kelahiran, buku ini juga memberikan panduan tentang pemantauan kondisi ibu dan bayi untuk deteksi dini komplikasi, serta edukasi mengenai perawatan pasca-persalinan sebagai bagian dari kesinambungan asuhan. Di akhir, pembaca akan dikenalkan dengan teknologi medis yang mendukung persalinan normal tanpa menggantikan peran sentral bidan.

Dengan bahasa yang jelas dan berbasis bukti, buku ini diharapkan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, serta memperkuat peran bidan sebagai pilar utama dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Buku Peran Bidan Dalam Persalinan Normal yang Aman merupakan referensi komprehensif yang membahas secara sistematis peran penting bidan dalam mendukung proses persalinan fisiologis yang aman dan bermartabat. Disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktik lapangan, buku ini menyajikan informasi penting bagi mahasiswa kebidanan, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung dalam pelayanan maternitas.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama. Dimulai dengan pentingnya edukasi kepada ibu hamil mengenai persiapan persalinan, pembaca diajak memahami bagaimana membangun kesiapan fisik dan mental calon ibu. Selanjutnya, dibahas peran pendampingan bidan secara profesional dan empatik selama proses persalinan. Teknik relaksasi dan manajemen nyeri non-farmakologis diuraikan sebagai strategi penting untuk mendukung persalinan alami.

Tidak hanya fokus pada proses kelahiran, buku ini juga memberikan panduan tentang pemantauan kondisi ibu dan bayi untuk deteksi dini komplikasi, serta edukasi mengenai perawatan pasca-persalinan sebagai bagian dari kesinambungan asuhan. Di akhir, pembaca akan dikenalkan dengan teknologi medis yang mendukung persalinan normal tanpa menggantikan peran sentral bidan.

Dengan bahasa yang jelas dan berbasis bukti, buku ini diharapkan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, serta memperkuat peran bidan sebagai pilar utama dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

